발 간 등 록 번 호
G000F8L-2025-171

환자중심의 건강보험 재택의료 포괄모형 개발

연구진

연구책임자 홍미영 부연구위원

공동연구자 김경창 주임연구원
전예지 주임연구원
문종윤 상근객원연구위원

주제어 재택의료, 방문의료, 재택관리, 건강보험 시범사업

건강보험심사평가원
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

머리말

제공 서비스에 방문의료가 있거나 사업명에 재택을 포함하는 15개 건강보험 시범사업은 서로 다른 시기에, 특정 환자를 대상으로 분절적 설계·운영되어 통합 관리 되고 있지 않으며, 사용 용어, 수가 수준, 산정기준, 본인부담률 등의 차이로 이용자와 제공자 모두에게 혼선을 초래하고 있다. 또한 2026년 3월 일상생활 수행에 어려움을 겪는 사람이 살던 곳에서 계속하여 건강한 생활을 영위할 수 있도록 의료 · 요양 등 지원하는 것을 목적으로 한 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」이 시행 예정됨에 따라 환자중심 재택의료 포괄모형 마련의 필요가 커지고 있다.

이에 이 연구는 건강보험 재택의료의 현황을 파악하고, 이해관계자 의견을 모아 일관되고 지속가능한 운영 방안을 검토하였다. 이를 통하여 재택의료 제공과 의료이용 과정에서 발생할 수 있는 공백과 중복을 최소화하고, 연속적·포괄적 관리체계를 확립할 수 있도록 이용자 중심의 건강보험 재택의료 포괄모형을 제시했다.

본 연구 결과를 바탕으로 재택의료가 필요한 환자가 보다 원활하고 안정적으로 이용할 수 있는 기반이 마련되기를 기대한다. 아울러 향후 건강보험 재택의료가 지속가능성을 확보하고, 다양한 지역과 인구집단에서 일관성 있게 운영될 수 있는 계기가 되기를 바란다.

2025년 12월

건강보험심사평가원 원장 강중구

건강보험심사평가원 심사평가정책연구소장 김유석

요약 ····· i

제1장 서론 1

1. 연구 배경 ····· 3
2. 연구 목적 ····· 5
3. 연구 내용 및 방법 ····· 5

제2장 우리나라의 재택의료 제도 7

1. 건강보험 재택의료 ····· 9
2. 장기요양 재택의료센터 시범사업 ····· 34

제3장 외국의 재택의료 수가체계 37

1. 일본 건강보험 재택의료 제도 ····· 39
2. 미국 건강보험 재택의료 제도 ····· 61
3. 소결 ····· 76

제4장 건강보험 재택의료 제공 및 이용 현황 분석 79

1. 분석 개요 ····· 81
2. 일반 현황 ····· 82
3. 재택의료 제공 및 이용 현황 ····· 91

CONTENTS

제5장 건강보험 재택의료에 대한 인식 및 개선의견 105

1. 일대일 심층 면접(IDI) 방법 ····· 107
2. 일대일 심층 면접(IDI) 결과 ····· 110
3. 소결 ····· 123

제6장 건강보험 재택의료 포괄모형 125

1. 건강보험 재택의료 개념(안) ····· 127
2. 건강보험 재택의료 포괄모형(안) ····· 130

제7장 결론 및 제언 137

■ 참고문헌 ····· 143
■ ABSTRACT ····· 151

표목차

〈표 1〉 건강보험 재택의료 시범사업 별 목적 및 개요 (2025년 5월 기준) ····· 9
〈표 2〉 건강보험 재택의료 별 서비스 내용 (2025년 5월 기준) ····· 12
〈표 3〉 건강보험 재택의료 수가구성 (2025년 5월 기준) ····· 13
〈표 4〉 건강보험 재택의료 대상 환자 특성 및 서비스 제공기간 (2025년 5월 기준) ····· 14
〈표 5〉 건강보험 재택의료 서비스 제공기관 (2025년 5월 기준) ····· 15
〈표 6〉 재택의료 시범사업 별 팀구성 기준 및 환자 본인부담률 (2025년 5월 기준) ····· 16
〈표 7〉 건강보험 재택의료 평가·계획수립 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준) ····· 17
〈표 8〉 건강보험 재택의료 교육·상담료 수가 수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준) ····· 19
〈표 9〉 건강보험 재택의료 의사 방문료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준) ····· 23
〈표 10〉 건강보험 의사 방문의료 수가 가감산 기준 (2025년 5월 기준) ····· 25
〈표 11〉 건강보험 간호사 방문의료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준) ····· 26
〈표 12〉 2020년 가정간호 기본방문료 수가 기준 변경사항 (2025년 5월 기준) ····· 27
〈표 13〉 건강보험 물리·작업치료사 방문의료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준) · 28
〈표 14〉 건강보험 재택의료 환자관리료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준) ····· 29
〈표 15〉 건강보험 재택의료 시범사업 평가지표 및 결과 ····· 32
〈표 16〉 장기요양 재택의료센터 시범사업 급여 산정기준 ····· 35
〈표 17〉 일본 건강보험 환자 본인부담률 ····· 40
〈표 18〉 일본 의과 진료점수표 구성 ····· 42
〈표 19〉 일본 건강보험 왕진료 및 가산항목 ····· 44
〈표 20〉 일본 건강보험 재택환자 방문진료료 및 가감산 항목 ····· 46
〈표 21〉 일본 건강보험 의학종합관리료 세부기준 ····· 47
〈표 22〉 일본 건강보험 의학종합관리료 수가 및 가산항목 ····· 49
〈표 23〉 일본 건강보험 방문진료 관련 지도·지시료 내용 및 점수 ····· 51
〈표 24〉 일본 건강보험 재택요양지도 관리료 목록 ····· 53
〈표 25〉 일본 건강보험 비대면 모니터링 ····· 54
〈표 26〉 일본 연령별 재택의료 이용 현황 ····· 56
〈표 27〉 일본 재택의료 환자의 주요 질환 (2024년) ····· 57
〈표 28〉 일본 재택의료 환자조사 결과 (2024년) ····· 58
〈표 29〉 일본 재택의료 횟수 및 시간 ····· 59
〈표 30〉 일본 재택의료 의학관리료 산정 현황 ····· 60
〈표 31〉 미국 메디케어의 재택의료 제공서비스 ····· 62
〈표 32〉 미국 CMS OASIS 평가항목 ····· 63
〈표 33〉 미국 메디케어 임상그룹(Clinical grouping) 세부내용 ····· 65
〈표 34〉 미국 CMS 전향적 지불제도 건강보험 청구코드(HIPPS)별 세부기준 예시 ····· 65

CONTENTS

〈표 35〉 미국 메디케어 HHVBP 모델 구성요소 (2023-2024 성과연도) ····· 66
〈표 36〉 미국 메디케어 재택의료 등록 및 보상절차 ····· 67
〈표 37〉 미국 메디케어 서비스 행위별 코드 내용 ····· 68
〈표 38〉 미국 메디케어 재택방문 관련 CPT 코드 ····· 70
〈표 39〉 미국 메디케어 비대면 모니터링 관련 CPT 코드 ····· 72
〈표 40〉 미국 메디케어 재택의료 이용현황 ····· 73
〈표 41〉 미국 메디케어 재택의료 LUPA 비율 및 평균 방문 수 (2020~2024) ····· 73
〈표 42〉 미국 메디케어 서비스 제공자별 연평균 방문 횟수 ····· 73
〈표 43〉 미국 메디케어 서비스 분야별 환자당 30일 단위 평균 추정 비용 ····· 74
〈표 44〉 미국 메디케어 재택의료 원격진료, 원격모니터링 현황 (2024년) ····· 74
〈표 45〉 미국 메디케어 재택의료 임상군별(Clinical group) 분포 ····· 75
〈표 46〉 일본과 미국의 재택의료 제도 ····· 77
〈표 47〉 건강보험 재택의료 참여 기관 및 환자 수 ····· 82
〈표 48〉 건강보험 재택의료 이용 환자 일반현황 ····· 83
〈표 49〉 건강보험 재택의료 제공기관 소재유형별 일반 현황 ····· 84
〈표 50〉 건강보험 재택의료 제공 기관 종별 일반 현황 ····· 86
〈표 51〉 건강보험 재택의료 일반현황 (2024년 기준) ····· 88
〈표 52〉 건강보험 재택의료 사업별 주상병 (상위 5개) ····· 89
〈표 53〉 연간 건강보험 재택의료 이용 현황별 환자 수 ····· 91
〈표 54〉 재택의료 단일 이용환자의 참여 사업 현황 (2023년, 2024년) ····· 92
〈표 55〉 2024년 2개 사업 이용 환자 조합별 현황 ····· 93
〈표 56〉 2024년 2개 사업 이용 환자 조합별 청구현황 ····· 95
〈표 57〉 2024년 재활필요 환자 2개 사업 이용 조합별 현황 ····· 96
〈표 58〉 2024년 암환자 2개 사업 이용 조합별 현황 ····· 96
〈표 59〉 2024년 암환자 2개 사업 이용 조합별 현황 ····· 97
〈표 60〉 연간 건강보험 재택의료 제공 현황별 의료기관 수 ····· 98
〈표 61〉 2024년 1개 재택의료 제공 현황 및 기관 수 ····· 98
〈표 62〉 2024년 2개 재택의료 제공 현황 및 기관 수 ····· 99
〈표 63〉 2024년 3개 재택의료 제공 현황 및 기관 수 ····· 99
〈표 64〉 재택의료 이용 및 제공 유형별 일반현황 ····· 101
〈표 65〉 재택의료 교차, 연속 이용 유형별 관여 사업 (상위 5개) ····· 101
〈표 66〉 단일 재택의료 이용 환자의 사업별 참여 현황 ····· 102
〈표 67〉 교차 재택의료 이용 환자의 참여 사업 (상위 15개) ····· 103
〈표 68〉 이용 유형별 일반현황 ····· 103
〈표 69〉 연속 이용 환자의 참여 사업 (상위 10개) ····· 104

〈표 70〉 일대일 심층 면접 반구조화 질문지 ····· 108
〈표 71〉 심층 면접 범주 ····· 110
〈표 72〉 심층 면접 범주별 주요 키워드 언급 빈도 ····· 111
〈표 73〉 심층 면접 참여자 유형별 주요 의견 차이 ····· 123
〈표 74〉 재택의료 개념에 관한 선행 연구 ····· 129
〈표 75〉 건강보험 재택의료 시범사업 별 대상자와 제공기관 특성에 따른 중증도 구분 ··· 131

CONTENTS

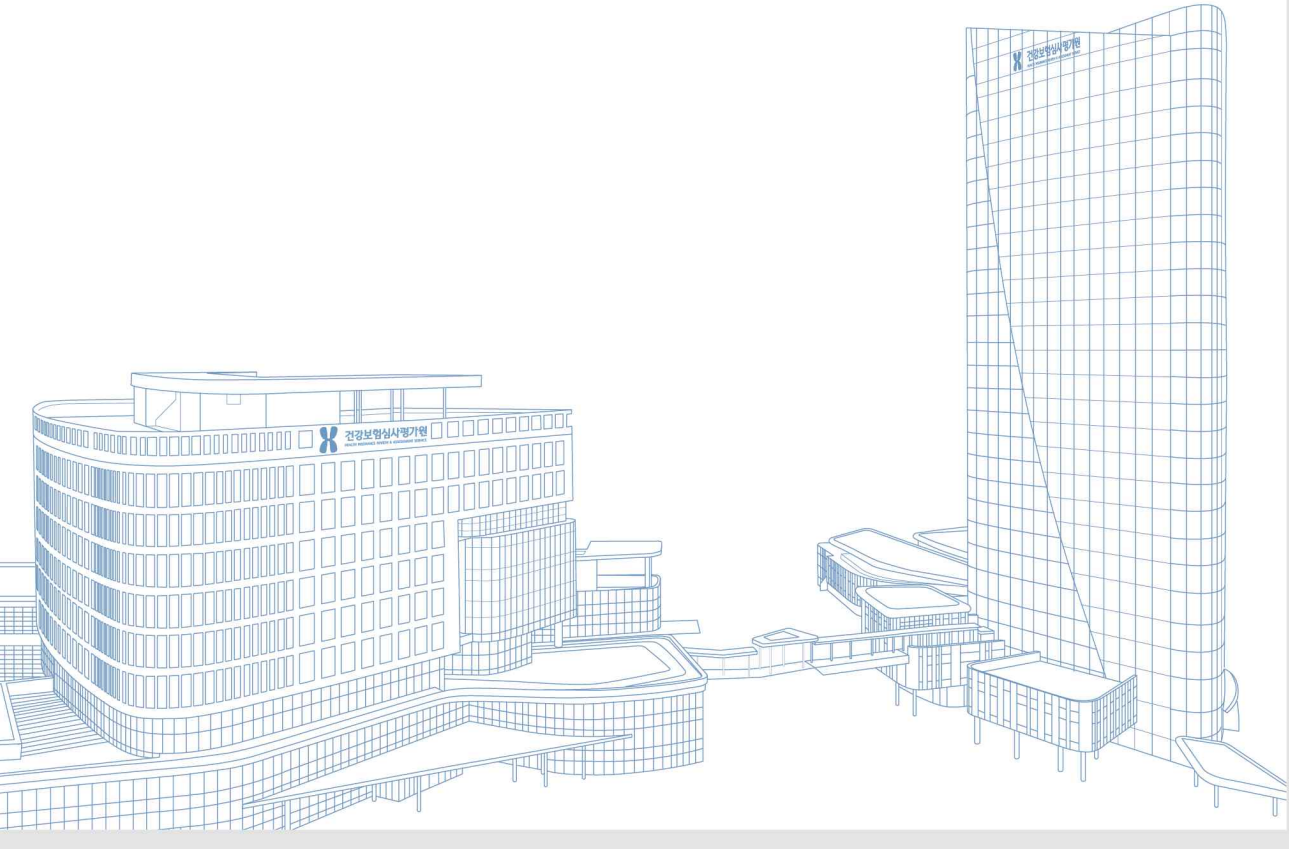
그림목차

[그림 1] 연구 수행 체계 ····· 6
[그림 2] 건강보험 재택의료 평가 및 계획수립 수가수준 (2025년 5월 기준) ····· 18
[그림 3] 건강보험 재택의료 교육·상담료 수가수준 (2025년 5월 기준) ····· 21
[그림 4] 건강보험 재택의료 의사 방문료 수가수준 (2025년 5월 기준) ····· 24
[그림 5] 건강보험 재택의료 간호사 방문료 수가수준 (2025년 5월 기준) ····· 27
[그림 6] 건강보험 재택의료 환자관리료 수가수준 (2025년 5월 기준) ····· 30
[그림 7] 장기요양 재택의료 시범사업 서비스별 세부 내용 ····· 34
[그림 8] 장기요양 재택의료센터 시범사업 기본수가 모형 ····· 35
[그림 9] 장기요양 재택의료센터 시범사업 의원-보건소 협업형 모형 ····· 36
[그림 10] 일본 왕진, 방문진료 건수 추이 ····· 55
[그림 11] 일본 재택의료 환자 수 연간 추이 ····· 55
[그림 12] 일본 연령별 재택의료 점수(2024.6월 기준) ····· 56
[그림 13] 2024년 재택의료 전향적 지불제도(HHPPS) 체계 ····· 64
[그림 14] 재택의료 단일, 교차, 연속 이용 정의 ····· 100
[그림 15] 건강보험 재택의료 포괄모형(안) ····· 132

HIRA
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

환자중심의 건강보험 재택의료 포괄모형 개발

요약



요 약

1. 연구 목적 및 방법

○ 우리나라 건강보험 재택의료는 대상자 특성과 서비스 제공 내용에 따라 다양한 시범사업과 행위별 수가가 운영됨

- 동일한 대상자에게 유사한 서비스를 제공해도 시범사업별로 수가 수준과 산정 기준, 본인부담률 등의 차이가 발생함

○ 또한 재택의료가 특정 대상에게만 제공되어 재택의료 이용에 공백이 발생할 우려가 있으나, 이에 대한 의료이용과 공급현황이 전체적으로 파악되지 않음

○ 이에 건강보험 재택의료의 일관되고 지속가능한 운영을 위해 국내외 재택의료 제도 및 성과를 파악하고 다양한 이해관계자의 의견을 종합하여 환자중심 포괄모형을 개발하고자 함

연구내용	연구방법
국내외 재택의료 제도, 성과 등 현황 파악	• (문헌 고찰) 국내 재택의료 시범사업 별 운영 현황과 성과지표, 효과평가 결과 검토, 미국, 일본의 관련기관 홈페이지, 논문 등을 수집하여 급여 범위, 수가 수준 등 수가체계 및 성과 확인 • (전문가 자문) 재택의료 운영 현황 및 효과에 대한 의견수렴
건강보험 재택의료 이용 및 제공 현황 분석	• (자료 분석) 진료비 청구자료를 활용한 재택의료 제공 현황 및 이용 경로 파악
이해관계자 의견조사	• (일대일 심층 면접) 재택의료 제공 및 이용 경험, 재택의료 개념, 필요성 및 효과, 개선방안 등에 대한 심층 면접 실시
건강보험 재택의료 포괄모형(안) 개발	• (전문가 자문) 건강보험 재택의료 관련 용어 구분 및 개선의견 수렴 • 연구 결과를 종합하여 환자중심 재택의료 포괄모형(안) 제안

[요약 그림 1] 연구 수행 체계

2. 연구 결과

가. 우리나라의 재택의료 제도

○ 2025년 5월 기준, 건강보험 시범사업 중 '방문의료'가 포함되거나 사업명에 '재택' 이 있는 사업은 총 15개로 통합·포괄적 의료서비스, 비대면 관리, 방문진료 등으로 분류됨. 주요 사업 목적은 의료접근성 향상, 지속적이고 통합적인 의료서비스 제공, 불필요한 입원 및 의료비 감소 등임

○ 건강보험 재택의료 사업명에서 사용하는 용어는 주치의, 재택의료, 사례관리, 방문, 가정 등으로 혼재됨. 예를 들어, 중증소아 재택의료와 가정용 인공호흡기 환자 재택의료는 명칭이 유사하지만 서비스 내용이 다르며, 비대면 관리 사업인 질환군별 재택의료는 재택관리라는 용어를 사용하기도 함

○ 서비스 내용은 평가 및 계획수립, 교육·상담, 방문의료, 환자관리 등이 있으며, 사업별로 제공되는 서비스와 수가 구성이 상이함. 환자관리는 환자와 의료진 간 비대면 서비스로 이루어지며 온콜 시스템 운영, 전화 등을 통한 양방향 소통, 다학제팀 회의 등이 있음

○ 대부분의 사업이 의료기관 종별 구분으로 제공 기관을 제한함. 서비스 제공 팀 구성은 사업 목적에 따라 다르며, 특정 교육 수료, 전문 자격 취득, 임상 경력 2~3년 이상 등을 요구하기도 함

○ 환자 본인부담률은 0%에서 30%까지 다양하게 적용되며, 중증·희귀난치 질환 등 산정특례 대상자는 별도 기준에 따름. 수가와 산정 기준 역시 사업별로 차이가 있음

나. 외국의 재택의료 수가체계

○ 일본과 미국은 모두 건강보험 재택의료 대상자를 자력 이동이 곤란한 자와 같이 상병이 아닌 상태로 명시함. 미국은 칩거상태의 환자가 전문간호 등의 필요가 있음을 문서로 인증하도록 함. 환자의 의료적 필요에 따라 다직종 서비스 제공을 보장한다는 공통점도 확인됨. 일본은 의사, 간호사, 약사, 영양사, 재활전문가 등이 미국은 간호, 물리·작업·언어 치료뿐만 아니라 요양보호, 사회서비스 등이 포함되는 포괄적 서비스를 인정함

〈요약표 1〉 일본과 미국의 재택의료 제도

구분	일본 건강보험	미국 메디케어
대상자	• 재택요양 중인 통원 곤란자	• 이동이 어려운 상태임을 의료인에게 인정받은 자 • 표준화된 임상평가 도구 OASIS 사용 • 60일 간격이나 퇴원 등 이벤트 발생 시 환자 상태 재평가
제공기관	• 모든 진료소, 병원 제공 • 인력구성 및 인프라 구축에 따라 기관 단위 가산	• 재택의료기관으로 제한
제공 서비스	• 전문 인력별 방문의료, 평가, 치료계획 등 통합관리 • 비대면 모니터링, 다직종, 다기관 협력 등	• 전문 인력별 방문의료, 평가, 치료계획 등 통합관리 • 의료용품 및 장비, 요양보호 등
지불제도	• 행위별수가	• (지속관리) 월단위 묶음수가 • (일시적 방문) 행위별수가
가산기준	• 긴급, 야간, 휴일, 심야, 초과진료시간, 임종케어 등	• 60일 이내 이용 여부, 지역사회 거주, 임상범주(중증도), 동반질환, 기능 장애수준 등에 따라 묶음수가 수준 차등
감산기준	• 동일일 방문, 2개 이상의 의료기관이 동일 환자 방문 등	
의료질 평가	-	• QRP, HHVBP로 품질데이터 보고를 의무화하고 성과기반 인센티브 적용
의료와 돌봄의 역할	• 질병 치료와 증상 악화방지 목적은 건강보험, 생활지원과 기능유지 목적은 개호보험 적용 • 동일·유사 서비스는 개호보험 우선 적용	• 메디케어에서 의료와 요양 동시 제공

* QRP: Pay-for-Reporting, HHVBP: Home Health Value-Based Purchasing

다. 건강보험 재택의료 제공 및 이용 현황 분석

○ (분석 대상) 2025년 5월 기준, 의사, 간호사, 물리·작업치료사 등이 제공하는 방문의료가 있거나, 사업명에 '재택'을 포함하는 15개 시범사업과 방문의료가 포함된 가정간호 기본방문과 가정형 호스피스를 대상으로 함

- (자료원 및 분석 기간) 심사평가원 건강보험 진료비 청구자료를 활용함. 분석기간은 분석 대상 중 최초로 시행된 시범사업인 장애인 건강주치의 시범사업 시작일인 2018년 5월부터 2024년 12월까지로 함

○ (참여 기관 및 이용환자 수) 분석 기간 동안 건강보험 재택의료 참여 기관은 1,960개소이며 일차의료 한의 방문진료 참여 기관이 48.3%로 가장 많음. 중증소아 재택의료는

4개 기관이 참여함. 재택의료 이용 환자는 255,097명이며, 가정간호 기본방문 140,692명(55.2%)이 가장 많음. 2022년 12월부터 시행한 암환자(요루) 재택의료 환자가 338명(0.1%), 중증소아 재택의료 830명(0.3%)임

○ (이용유형) 1개 재택의료만 이용한 환자가 전체의 97.4%로 가장 많음. 2개의 재택의료 이용은 4.3%, 3개 이용 0.2% 순임

- 2024년 2개 사업 이용환자 5,034명이 가장 많이 참여한 사업조합은 가정간호 기본방문과 일차의료 방문진료 수가 시범사업으로 2,490명(49.5%)이 이용함. 두 번째로 많은 조합은 일차의료 방문진료 수가 시범사업과 장애인 건강주치의 시범사업 동시 이용으로 대상 환자는 654명임

라. 건강보험 재택의료에 대한 인식 및 개선의견

○ 일대일 심층 면접(IDI) 결과 모든 그룹에서 재택의료의 긍정적인 효과(환자 만족도, 의료비 절감)에 대한 인식이 높음. 또한, 현재 시범사업의 파편화와 용어 혼재 문제에 대한 공감대가 형성되어 있으며, 통합 및 개선의 필요성을 강조함

○ 이해관계자별 재택의료를 바라보는 관점과 우선순위에 차이가 있음. 의료계는 서비스 제공의 현실적 제약과 수가 수준의 문제를, 학계는 개념적 정합성과 장기적 비전을, 정책 담당자는 정책 집행의 효율성과 재정적 지속 가능성을, 그리고 환자는 서비스의 실질적 편익과 접근성을 강조함

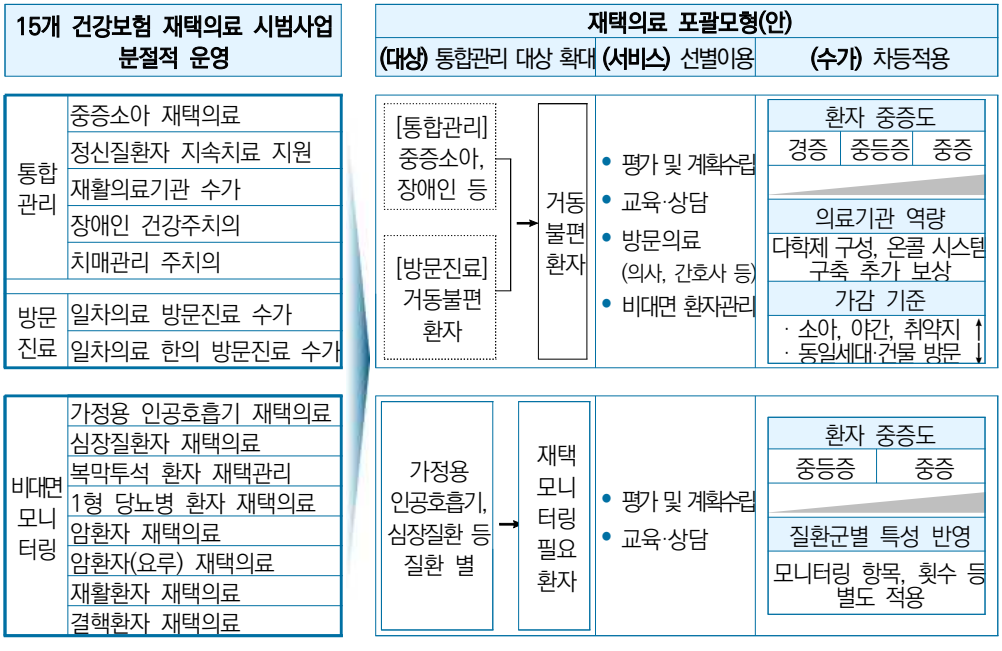
마. 건강보험 재택의료 포괄모형(안)

○ 국내외 현황, 심층 면접 및 선행 연구에 따라 건강보험 재택의료, 방문의료 등의 개념을 대상자와 서비스 내용을 모두 고려하여 다음과 같이 제시함

- 재택의료는 의료적 필요가 있는 거동불편 재가환자에게 다학제 의료진이 제공하는 계획적·정기적·포괄적 의료서비스이며, 방문의료는 재택의료의 하위개념으로 의료진이 환자의 가정에 방문하여 제공하는 의료서비스를 의미함

○ 본 연구에서 검토한 15개 시범사업은 통합관리를 위한 재택의료, 방문진료, 비대면 모니터링으로 구분됨. 포괄모형은 거동불편자를 대상으로 하는 재택의료와 비대면

모니터링 단독 제공으로 재정리함. 기존 방문진료는 재택의료 하위개념으로 서비스 제공 범위와 대상이 확대되는 방향으로 포괄모형을 제안함

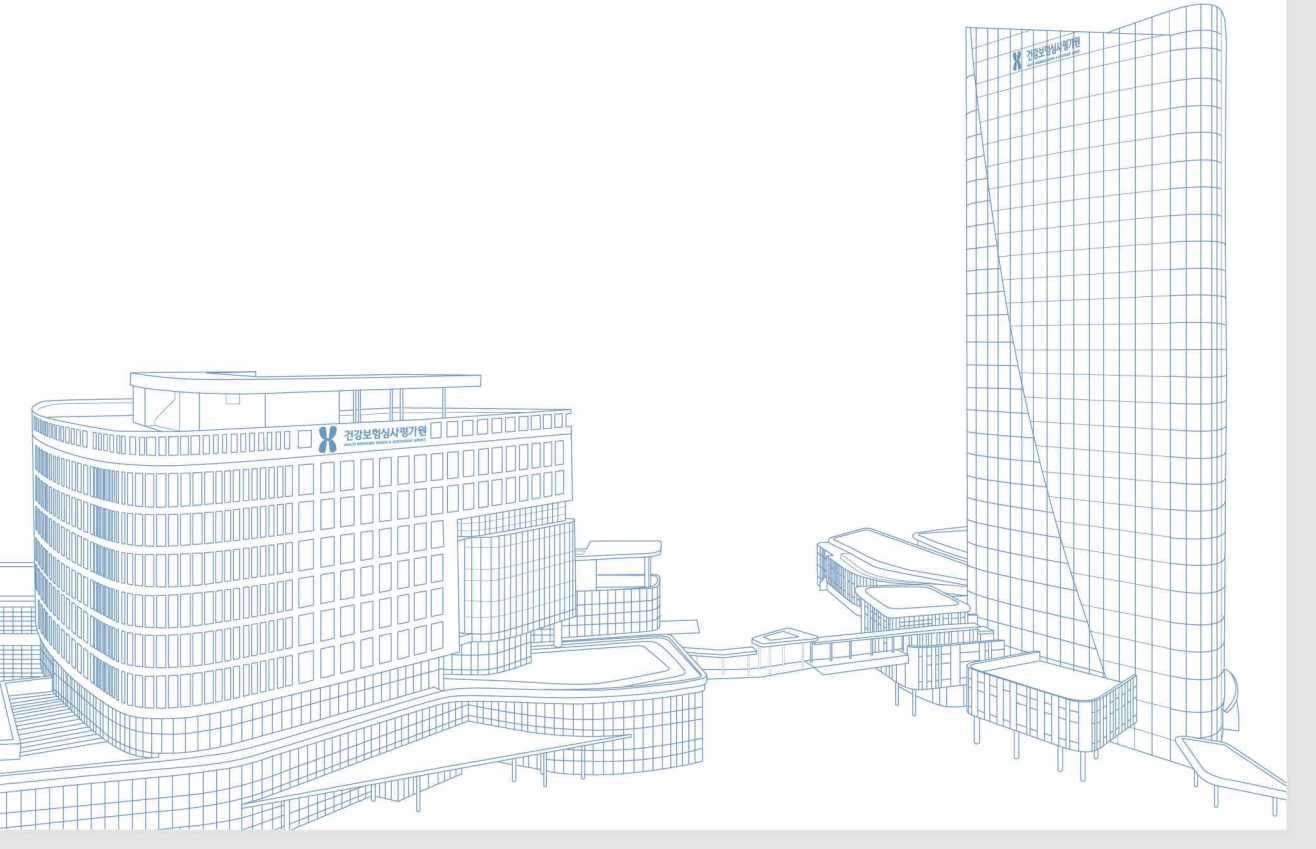


[요약 그림 2] 건강보험 재택의료 포괄모형(안)

HIRA
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

제1장

서론



제1장 서론

1. 연구 배경

○ 우리나라는 2018년 65세 이상 비율이 14% 이상인 고령사회 진입 6년 만인 2024년 12월 20% 이상인 초고령 사회에 진입함(행정안전부 보도자료. 2024). 고령화 영향으로 인구 및 질병구조의 변화가 이루어지고 있으며, 국민에게 필요한 의료서비스 형태가 다양해짐(김희년 외, 2024)

- 국내 거동불편 노인은 65세 이상 전체 노인인구의 10% 수준인 약 60만 명으로 추산되며, 향후 인구 고령화 추세에 따라 거동불편 노인의 수는 빠르게 증가할 것으로 전망됨(김창오 외, 2020)

○ '2023년도 노인실태조사' 결과에 따르면 건강 악화로 독립적 생활이 어려울 때를 가정한 경우 응답자의 48.9%가 현재 자신의 집에서 계속 살기를 희망함. 이는 독립적 생활이 어려운 상태에서도 친숙한 환경을 선호하며 자신의 공간에서 생활하고자 하는 욕구가 강함을 나타냄(강은나 외, 2023)

- 같은 조사에서 지역사회 거주를 위해 필요한 서비스 중 방문 의료·건강서비스가 63.1%로 나타났으며, 서비스가 필요하다고 응답한 노인은 55.4%로 절반 이상이 유료이용 의향이 있다고 답변함

○ 우리나라 건강보험 재택의료는 대상자 특성과 서비스 제공 내용에 따라 다양한 시범사업과 행위별 수가가 운영됨. 사업 목적과 대상에 따라 차이가 있으나 환자 평가 및 관리 계획수립, 교육·상담, 의사, 간호사, 물리·작업치료사의 방문의료, 비대면 환자 관리 등의 서비스를 제공함

- 장애인 건강주치의나 중증소아 재택의료 등은 통합관리를 목적으로 평가, 계획수립, 방문진료 등 여러 내용을 포함하지만, 일차의료 방문진료는 단일 기능만 수행함. 또한 유사한 서비스를 제공해도 수가 수준, 서비스 제공자 자격, 본인부담률 등의 차이가 발생함

○ 건강보험 재택의료 대상은 주로 특정 상병이나 환자군을 대상으로 하여 서비스 이용 공백이 발생할 수 있으나, 이에 대한 의료이용과 공급현황이 전체적으로 파악되지 않음

○ 재택, 주치의, 방문, 가정 등의 개념이 일관되지 않게 사용되며, 장기요양의 재택의료센터나 방문간호 등과 혼용되기도 함. '중증소아 재택의료'와 '장애인 건강주치의'는 통합관리 서비스임에도 제도명이 다르고, '중증소아 재택의료'와 '가정용 인공호흡기 환자 재택의료'는 명칭이 유사하지만 서비스 내용이 달라 혼선을 초래함

○ 일차의료 기반 재택의료는 의료서비스 제공 공간을 환자의 주거지로 옮겨 물리적 의료접근성을 높이고, 다학제팀의 지속적이고 포괄적인 의료서비스를 제공하는 모델로 장애가 있거나 건강상태가 좋지 않은 환자에게 더 효과적인 것으로 확인됨(Totten AM et al, 2016)

- 미국의 재택의료는 2000년대 이후 재가 요양 서비스 확대, 제공자 보상체계정비 등을 통해 발전해옴. 특히, 노인 대상 일차의료 기반 재택의료, 장기 돌봄 서비스 등은 이용환자의 입원율, 재원기간, 의료비를 감소시키는 효과가 있음(이태훈 외, 2022; Valluru et al., 2016; Wajnberg et al., 2010; Hughes, 2010)

- 일본의 재택의료는 1992년 정식으로 요양급여로 인정되면서, 입원, 외래에 이어 제3의 의료로 자리매김하였으며, 개호보험제도 시행과 지역포괄케어시스템 구축을 통해 체계적으로 추진함. 특히, 재택요양지원 진료소를 통한 정기적 가정방문은 재택환자 임종 지원 및 입원율 감소에 효과가 있으며, 재택의료 이용 환자는 2011년 약 11만명에서 2023년 약 24만명으로 2배 이상 증가함(오영인 외, 2019; Sun, Y, et al., 2023; 홍미영 외, 2022; 후생노동성, 2023)

○ 우리나라 노인장기요양보험은 요양병원이나 시설을 선택하는 수급자의 지역사회 계속 거주 지원을 위해 건강보험 일차의료 방문진료 수가 시범사업과 연계하여 재택의료를 제공하는 장기요양 재택의료센터 시범사업을 2022년 12월부터 추진함(보건복지부 외, 2024)

○ 또한 2026년 3월 일상생활 수행에 어려움을 겪는 사람이 살고 있는 곳에서 계속하여 건강한 생활을 영위할 수 있도록 의료·요양 등을 지원하는 것을 목적으로 한 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」이 시행 예정임에 따라 환자중심 재택의료 포괄모형 마련의 필요성이 커지고 있음

2. 연구 목적

○ 이 연구는 건강보험 재택의료의 효율성과 일관성을 확보하고 지속가능한 운영을 위한 포괄모형 개발을 목적으로 함. 구체적인 연구 목적은 다음과 같음

- 첫째, 국내외 재택의료 현황 및 성과를 파악함
- 둘째, 재택의료 서비스에 포함되는 방문의료, 재택관리 등의 개념을 제시함
- 셋째, 환자중심 건강보험 재택의료 포괄모형을 제안함

3. 연구 내용 및 방법

가. 국내외 재택의료 제도 및 성과 파악

○ 국내 보건복지부 고시, 시범사업 지침 등 자료를 수집하여 재택의료 사업별 수가 수준, 인력구성과 자격, 서비스 제공 내용, 본인부담률 등 현황을 파악함

○ 국내 재택의료 시범사업별 성과지표와 효과평가 결과를 확인함

○ 일본, 미국 등 외국의 재택의료 정의와 대상자 기준, 제공 서비스 내용, 평가 체계 등 파악을 위해 근거법령, 고시, 논문 등을 활용하여 우리나라와의 정책을 비교함

나. 건강보험 재택의료 이용 및 제공 현황 분석

○ (제공현황) 기관별 건강보험 재택의료 시범사업 제공 현황을 종합적으로 파악하여 기관 내 통합 가능한 시범사업 또는 서비스 등을 확인함

○ (이용현황) 건강보험 재택의료 서비스 이용 행태를 교차·연속·단일이용으로 구분하여 유사 서비스 다기관 이용 현황을 파악함

다. 우리나라 재택의료 문제점 진단과 포괄모형 방향에 관한 이해관계자 의견조사

○ 재택의료 개념과 환자중심 재택의료 서비스 포괄모형에 관한 사회적 인식과 이해관계 집단별 차이를 파악하기 위해 의료계, 학계, 정책 관련자, 환자를 대상으로

일대일 심층 면접(IDI: In-Depth Interview)을 수행함. 재택의료 제공 및 이용 경험, 재택의료 개념, 필요성 및 효과, 개선방안 등을 주제로 면접을 실시함

- 심층 면접 결과는 주요 내용을 주제별로 분류하여, 집단별 의견을 분석함

라. 환자중심 건강보험 재택의료 포괄모형 개발

○ 선행 연구보고서, 논문 등을 고찰하고, 건강보험 청구자료를 활용하여 건강보험 재택의료의 운영 현황과 성과를 파악함

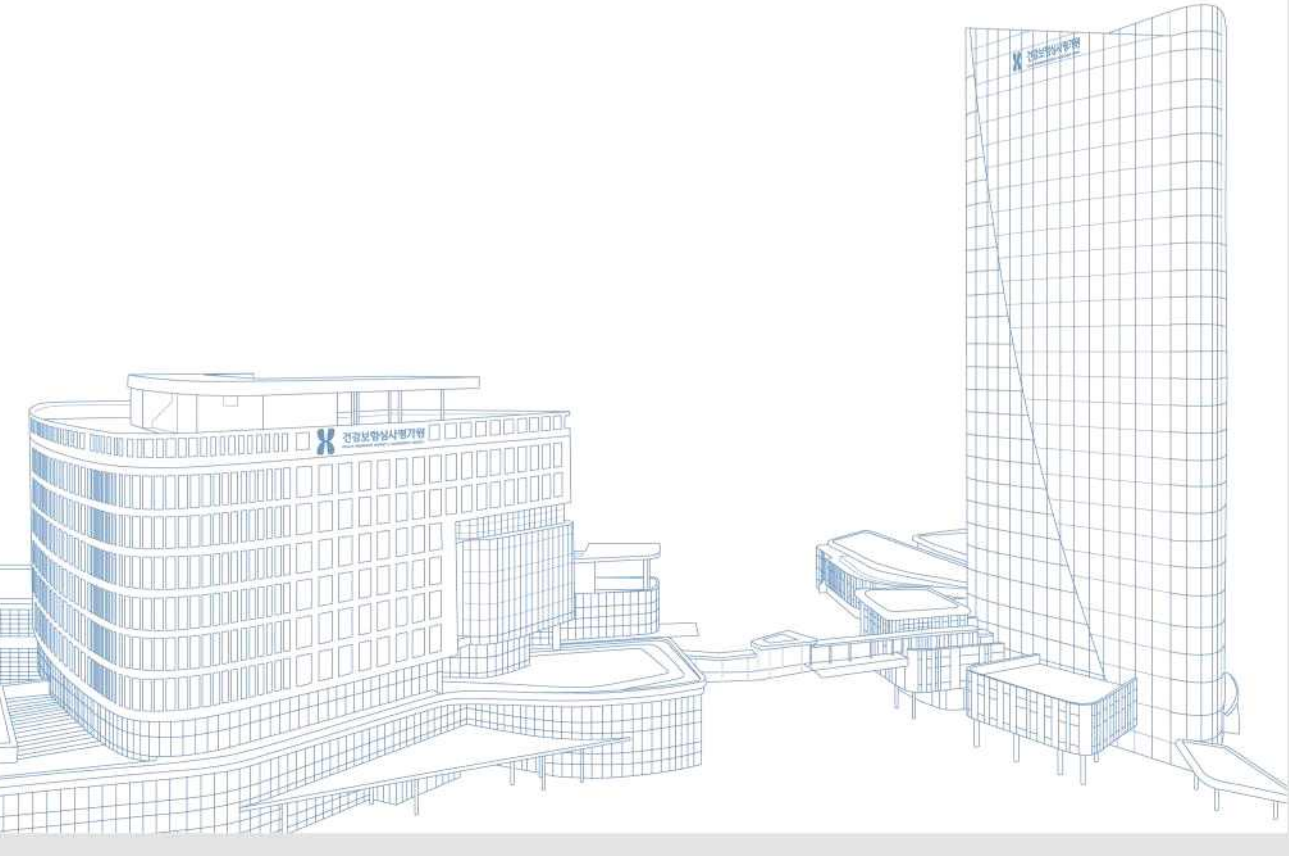
○ 심층 면접(IDI)과 전문가 자문회의를 통해 건강보험 재택의료 포괄모형을 제시함

연구내용	연구방법
국내외 재택의료 제도, 성과 등 현황 파악	• (문헌 고찰) 국내 재택의료 시범사업 별 운영 현황과 성과지표, 효과평가 결과 검토, 미국, 일본의 관련기관 홈페이지, 논문 등을 수집하여 급여 범위, 수가 수준 등 수가체계 및 성과 확인 • (전문가 자문) 재택의료 운영 현황 및 효과에 대한 의견수렴
건강보험 재택의료 이용 및 제공 현황 분석	• (자료 분석) 진료비 청구자료를 활용한 재택의료 제공 현황 및 이용 경로 파악
이해관계자 의견조사	• (일대일 심층 면접) 재택의료 제공 및 이용 경험, 재택의료 개념, 필요성 및 효과, 개선방안 등에 대한 심층 면접 실시
건강보험 재택의료 포괄모형(안) 개발	• (전문가 자문) 건강보험 재택의료 관련 용어 구분 및 개선의견 수렴 • 연구 결과를 종합하여 환자중심 재택의료 포괄모형(안) 제안

[그림 1] 연구 수행 체계

제2장

우리나라의 재택의료 제도



제2장 우리나라의 재택의료 제도

1. 건강보험 재택의료

가. 개요

○ 2025년 5월 기준, 의사, 간호사, 사회복지사, 물리·작업치료사가 제공하는 방문의료가 있거나, 사업명에 '재택'이 포함된 15개 시범사업을 검토 대상으로 함

- 사업명에 '재택'이 포함되어 제도적으로 재택의료로 분류되거나, 재택의료의 핵심 요소인 환자 거주지 기반 방문의료를 포함하는 시범사업을 선정 함

○ 사업 유형은 개요에 따라 통합·포괄적 의료서비스, 비대면 모니터링, 방문의료로 구분되며, 일부 차이가 있으나 의료접근성 향상, 지속적·통합적 의료서비스 제공, 불필요한 입원 및 의료비 감소 등을 목적으로 함

〈표 1〉 건강보험 재택의료 시범사업 별 목적 및 개요 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료 (시행 시기)	목적	개요
장애인 건강주치의 시범사업 (2018.5.)	• 장애인에게 필수적 **의료서비스 이용의 접근성** 향상	• 장애인이 건강 **주치의**로 등록 신청한 의사를 건강 주치의로 선택하여 전반적 건강관리(일반건강관리)나 장애 관련 건강상태 (주장애관리) 등을 **지속적·포괄적으로 관리** 받도록 함
중증소아 재택의료 시범사업 (2019.1.)	• 가정에 있는 중증소아 청소년 환자에게 **통합적인 의료서비스 제공** – 중증소아 청소년의 성장 및 발달을 촉진하고, 가족의 삶의 질 향상에 기여 – 지속적이고 포괄적인 의료서비스를 가정에서 제공할 수 있도록 교육·상담 서비스를 제공하여 역량 강화	• 재택의료 서비스가 필요한 중증소아 청소년 환자를 대상으로 의료기관의 **재택의료팀**(의사·간호사 등)이 재택의료 관리 계획을 수립하고 가정방문을 통해 진료 및 간호, 재활, 교육·상담 등의 **지속적이고 포괄적인 의료서비스를 제공**
정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리 (2020.1.)	• 정신응급 환자 발생 시 초기 집중치료부터 **지속치료 지원까지 충분한 의료서비스를 제공**하여, 정신질환 증상 악화를 예방하고 사회복귀 도모	• 정신질환자의 급성기 입원 치료부터 **퇴원 후 사례관리** 및 낮병동 치료까지 지속적인 의료서비스를 받을 수 있도록 ①급성기 치료 활성화, ②병원기반 사례관리 및 ③낮병동 관리료

건강보험 재택의료 (시행 시기)		목적	개요
재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활 (2023.1.)		• 뇌졸중, 척수손상 등 급성기 치료 후 재활환자의 기능 회복시기에 집중 재활을 통해 **장애 최소화 및 조기 일상생활로 복귀**	• 급성기 치료 후 회복기 환자의 기능회복 및 조기 사회복귀를 위해 다양한 직종이 함께 환자의 상태 및 주거환경 등을 체계적으로 파악하고 환자 특성에 맞는 **재활서비스 중심의 통합적 치료 제공**
치매관리주치의 시범사업 (2024.7.)		• 치매환자가 지역사회에 거주하면서 치매와 그 외 건강문제까지 꾸준히 치료·관리하여 건강 및 삶의 질을 유지·증진시킬 수 있는 의료체계 구축	• 치매관리**주치의**가 환자평가를 통해 치료·관리 **계획을 수립**하고, 계획에 따라 **치매 및 기타 질환 치료·관리**
질환군별 재택의료 시범사업	복막투석 환자 (2019.12.)	• **재택환자를 지속적으로 관리**하고 피드백을 제공해 입원 및 질환 악화로 인한 불필요한 의료비 지출을 줄이고, 환자 삶의 질 제고 • 자가관리에 대한 교육·상담, 환자 상태에 대한 정기적 모니터링 등 재택관리 서비스 제공에 대한 보상 마련	• 의료인의 **방문은 불필요**하지만 지속적인 재택의료 서비스가 필요한 환자를 **주기적으로 확인하면서 관리**
	1형 당뇨병 환자 (2020.1.)		
	가정용 인공호흡기 환자 (2020.5.)	• 의료기관이 아닌 **가정에서**도 **의료적 관리서비스를 지속적으로 제공**하여 질병 악화, 장기입원 등으로 인한 환자 삶의 질 저하 예방 • 환자관리에 대한 교육·상담, 환자 상태에 대한 정기적 모니터링 등 재택의료 서비스 제공에 대한 보상체계 마련	• 가정용 인공호흡기를 부착한 중증 재택환자를 대상으로 환자 교육·상담 및 비대면 관리 등 의료서비스 제공
	심장 질환자 (2020.10.)		• 심장질환으로 삽입형제세동기(ICD), 심장재동기화치료기(CRT), 심박기(Pacemaker) 삽입 재택환자를 대상으로 환자 교육 · 상담 및 비대면 관리 등 의료서비스 제공
	재활환자 (2020.12.)		• 퇴원 이후에도 자택에서 지속적으로 의료적 관리가 필요한 재활환자를 대상으로 교육·상담 및 비대면 관리 등의 의료서비스 제공
	결핵환자 (2021.10.)		• 결핵(다제내성 포함) 환자를 대상으로, 자가 관리에 대한 교육·상담과 비대면 관리 등 의료서비스 제공
	암환자 (2021.12.)		• 지속적으로 재택관리가 필요한 암환자를 대상으로, 자가 관리에 대한 교육·상담과 비대면 관리 등 의료서비스 제공
	암환자(요루) (2022.12.)		
일차의료 방문진료 수가 시범사업	의과 (2019.12.)	• 방문진료에 따른 적정 보상 마련으로 **거동불편자 의료접근성 향상** 및 커뮤니티케어 기반 확보	• **지역 내** 시범기관의 (한)의사가 거동이 불편하여 의료기관에 내원하기 어렵다고 판단한 환자를 대상으로 직접 **방문진료 의료서비스 제공**
	한의 (2021.8.)	• 한의 방문진료 활성화로 **거동불편 재가환자의 의료접근성 향상** 및 다양하고 충분한 의료서비스 제공 기반 확대	

* 재활의료기관 수가 시범사업은 2017년 10월부터 시행하였으나, 재택의료인 방문재활치료가 포함된 3단계 시범사업은 2023년 1월에 개정되어 해당 시점으로 기재함

○ 시범사업은 아니지만 건강보험 체계에서 방문의료를 제공되는 가정간호 기본방문료(가-13)와 가정형 호스피스(완-11,12) 현황을 함께 확인함

- (가정간호 기본방문료) 가정전문간호사가 환자를 방문하여 간호서비스를 제공함. 장기입원이나 불필요한 입원을 줄이고 자원 활용의 효율성 제고하기 위한 입원대체 서비스로 1994년 시범사업으로 시작하여 2001년 1월 본 사업으로 전환함. 「의료법 시행규칙」 제24조에 명시된 가정간호의 범위는 간호, 검체의 채취 및 운반, 투약, 주사, 응급처치 등에 대한 교육 및 훈련, 상담, 다른 보건의료기관 등에 대한 건강관리에 관한 의뢰임

- (가정형 호스피스) 퇴원 가능한 말기 암환자가 가정에서 지내는 동안 돌봄의 연속성을 확보하고, 불필요한 입원, 응급실 방문 등 비효율적 의료이용 개선이 요구됨에 따라 2009년 12월 건강보험 수가 1차 시범사업이 도입됨. 2020년 9월 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률」제2조제6호 및 제28조에 의한 암, 후천성면역결핍증, 만성폐쇄성호흡기질환, 만성간경화, 만성호흡부전 환자로 대상자를 확대하여 수가를 신설함

○ 통합관리를 위한 재택의료는 주치의(장애인, 치매), 재택의료(중증소아), 사례관리(정신질환자)이며, 방문의료는 방문(방문진료, 방문재활)과 가정(가정간호, 호스피스)을 함께 사용함. 비대면 모니터링인 질환군별 재택의료는 복막투석환자 대상 사업만 재택관리임

- '중증소아 재택의료'와 '장애인 건강주치의'는 통합관리임에도 제도명이 다르고, '중증소아 재택의료'와 '가정용 인공호흡기 환자 재택의료'는 명칭이 유사하지만 서비스 내용이 다름

○ 행위별수가제로 추진되는 건강보험 재택의료 시범사업은 서비스 내용이 행위분류의 기준이 되며, 해당 분류에 따라 대부분 수가 수준이 달리 적용됨

- 행위분류에 따른 수가명도 간호사의 환자 방문은 가정간호 기본방문, 장애인 건강주치의는 방문간호, 중증소아와 가정형 호스피스는 간호사 방문으로 일부 차이가 있음. 참고로 노인장기요양보험의 간호사 등의 방문은 '방문간호'로 함

〈표 2〉 건강보험 재택의료 별 서비스 내용 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	서비스 내용
장애인 건강주치의	• 포괄평가 및 계획수립료 (중간점검료) • 교육·상담료 • 환자관리료 • 방문료: 방문진료료, 방문간호료
중증소아 재택의료	• 재택의료 관리계획수립료 • 교육·상담료 • 방문료: 의사방문료, 간호사방문료, 물리·작업치료사 방문료 • 환자관리료(기본/집중) • 재택의료 평가·연계료
정신질환자 지속치료 지원: 병원기반 사례관리	• 퇴원계획수립료 • 교육·상담료 • 방문료: 의사방문료, 사례관리요원방문료 • 환자관리료 • 정신질환자 사례관리료
재활의료기관 수가: 방문재활	• 재활의료기관 방문재활계획수립료 • 재활의료기관 방문재활치료료: 치료사 • 재활의료기관 방문재활관리료
치매관리주치의	• 포괄평가 및 계획수립료 (중간점검료) • 환자관리료 • 교육·상담료 • 방문진료료
질환군별 재택의료 (8개) *복막투석 재택관리	• 교육·상담료 • 환자관리료
일차의료 (한의) 방문진료	• 방문진료료
(수가) 가정간호 기본방문료	• 가정간호 기본방문료
(수가) 가정형 호스피스	• 가정형 호스피스 방문료: 의사방문료, 간호사방문료, 사회복지사 방문료 • 가정형 호스피스 통합환자관리료

○ 건강보험 재택의료는 평가 및 계획수립, 교육·상담, 환자 방문, 환자관리로 수가를 구분함

- 장애인 건강주치의, 중증소아 재택의료, 정신질환자 지속치료 지원: 병원기반 사례관리 사업은 환자의 평가에 따른 계획을 수립하고, 계획에 따른 교육·상담, 방문의료, 비대면 관리 등을 종합적으로 제공함

- 중증소아 재택의료의 '재택의료 평가·연계료'는 2025년 1월 신설된 수가로 다학제팀 회의를 통해 중간평가 및 서비스 변경 등을 실시하거나, 거주지 중심 서비스를 연계하는 등에 대한 내용이 포함됨
- 정신질환자 지속치료 지원: 병원기반 사례관리와 재활의료기관: 방문재활, 일차의료 방문진료는 간호사, 사회복지사, 물리·작업치료사 등 동반인력 수가가 팀 방문 또는 가산 등으로 인정됨
- 가정형호스피스 통합관리료는 팀 회의를 통해 환자 상태 평가 및 계획수립, 전화상담 등 상시적 환자관리, 팀원과 전화보고를 한 경우 산정함
- 환자관리는 비대면 서비스로 비정기적 상담 요청에 응하기 위한 온콜 시스템(on-call system), 환자 상태를 확인하기 위한 양방향 소통, 다학제팀 회의로 구분됨

〈표 3〉 건강보험 재택의료 수가구성 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	평가 및 계획수립	교육·상담	환자 방문				환자 관리		
			의사	간호사	물리·작업치료사	사회복지사	의료진→환자	환자→의료진	팀 회의
장애인 건강주치의 시범사업	○	○	○	○	-	-	○	-	-
중증소아 재택의료 시범사업[1]	○	○	○	○	○	-	-	○	△
정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리	○	○	○	△	-	△	○	-	○
재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활	○	-	-	-	○	△	-	-	○
치매관리주치의 시범사업	○	○	○	-	-	-	○	-	-
질환군별 재택의료 시범사업 (8개)	-	○	-	-	-	-	○[2]	-	-
일차의료 방문진료 수가 시범사업	-	-	○	△	△	-	-	-	-
일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업	-	-	○	-	-	-	-	-	-
가정간호 기본방문료	-	-	-	○	-	-	-	-	-
가정형 호스피스	△	-	○	○	-	○	○	-	○

* 주 1. 재택의료 평가·연계료에 다학제팀 회의, 중간평가, 지역사회연계 수가가 포함됨
2. 복막투석환자만 정보 자동전송 내용이 포함됨
3. 독립적인 수가는 아니지만 가산이나 기준에 포함된 경우 △로 구분함

○ 대부분의 건강보험 재택의료는 특정 상병이나 자격으로 사업 대상을 한정함

- 일반적으로 방문의료가 포함된 사업은 거동불편자를 대상으로 함. '정신질환자 지속

치료지원 시범사업: 병원기반 사례관리 시범사업'은 정신건강의학과 퇴원환자 중 전문의의 의학적 판단 하에 사례관리가 필요한 경우 퇴원계획수립, 방문관리 등의 서비스를 제공하므로 거동불편 여부를 고려하지 않음

- 질환군별 재택의료는 비대면 모니터링이 필요한 환자군을 대상으로 함

〈표 4〉 건강보험 재택의료 대상 환자 특성 및 서비스 제공기간 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료		대상 환자 특성		서비스 제공 기간
		대상 환자	거동 불편	
장애인 건강주치의 시범사업		장애인	○	-
중증소아 재택의료 시범사업		만 18세 이하 재택의료가 필요한 의료적 요구가 있는 환자	○	만 24세 이하까지
정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리		정신건강의학과 퇴원예정환자	-	180일
재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활		중추신경계, 근골격계 등	○	120일
치매관리주치의 시범사업		치매 환자 (입원환자 제외)	○	-
질환군별 재택의료 시범사업	복막투석 환자	만성신장병 5기 환자	×	-
	1형 당뇨병 환자	인슐린 투여가 반드시 필요한 제1형 당뇨병 환자	×	-
	가정용 인공호흡기 환자	가정용 인공호흡기 처방 요양비 급여 대상자	○	-
	심장질환자	ICD, CRT, 심박기 삽입 심장질환자	×	-
	재활환자	근골격계 수술환자 또는 중추신경계 질환자	○	90일/ 6개월
	결핵환자	결핵 및 다제내성 결핵 환자	×	완치
	암환자	장루조성술을 받은 암환자	×	12개월
	암환자(요루)	요루조성술을 받은 암환자	×	
일차의료 방문진료 수가 시범사업	의과	진료를 받아야할 필요가 있는 거동불편자	○	-
	한의			
가정간호 기본방문료		입원진료 후 조기 퇴원한 환자 또는 입원이 요구되는 외래 및 응급실 환자	○	-
가정형 호스피스		말기암, 말기만성폐쇄성 호흡기질환, 말기만성 호흡부전, 말기AIDS, 말기 만성간경화	○	사망

○ 대상자의 특성과 사업 목적에 따라 서비스 제공 기간이 제한되거나 별도 종료기간이 정해지지 않음

- 중증소아 재택의료는 소아·청소년 환자의 연령으로 제공 기간을 제한함. 정신질환자 지속치료지원 시범사업과 재활의료기관 수가 시범사업은 급성기 치료부터 초기 지역사회복귀까지 지원을 목표로 하여 퇴원 후 치료 효과를 극대화 할 수 있는 기간을 구체적으로 명시함. 자기관리 역량 강화와 완치를 위한 약물복용 관리를 위한

모니터링인 경우 목표가 달성되는 시점을 서비스 기간으로 정함

- 서비스 제공 기간에 제한이 없는 사업 중 장애인 건강주치의와 치매 관리주치의는 매년 1회 이상 대상자를 평가하고 이에 따른 치료·관리계획을 재수립하도록 함

○ 건강보험 재택의료 제공 기관은 대부분 의료기관 종별구분으로 제한됨. 전문진료센터나 전문병원 등 지정 기관이나 상근하는 의료인력 수준을 제시하기도 함

- 장애인 건강주치의 시범사업은 의원부터 상급종합병원 서비스 제공이 가능하지만 주로 의원중심으로 운영됨

〈표 5〉 건강보험 재택의료 서비스 제공기관 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료		서비스 제공기관			
		상급종합	종합병원	병원	의원
장애인 건강주치의 시범사업		○[1]	○	○	○
중증소아 재택의료 시범사업		○	○[2]	–	–
정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리		○	○	○	–
재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활		–	–	○[3]	–
치매관리주치의 시범사업		–	○	○	○
질환군별 재택의료 시범사업	복막투석 환자	○	○	○	–
	1형 당뇨병 환자	○	○	–	–
	가정용 인공호흡기 환자	○	○	–	–
	심장질환자	○	○	–	–
	재활환자[4]	○	○	○	–
	결핵환자	○	○	○	–
	암환자	○	○	–	–
	암환자(요루)	○	○	–	–
일차의료 방문진료 수가 시범사업	의과	–	–	○[5]	○
	한의	–	–	–	○(한의원)
가정간호 기본방문료		○	○	○	○
가정형 호스피스[6]		○	○	○	○

* 주 1. 지역장애인보건의료센터 또는 발달장애인거점병원으로 지정된 상급종합병원
2. 어린이 공공전문진료센터로 지정된 종합병원 서비스 제공 가능
3. 재활의료기관 지정·운영 기관
4. 재활의학과 전문의 2인 이상이 상근하고 있는 병원급 이상 의료기관
5. 예외적으로 장기요양 재택의료센터 시범사업 참여 기관으로 선정된 지방의료원
6. 호스피스전문 기관 지정·운영 기관

○ 의사나 간호사의 단독 방문사업 이외의 시범사업이 다학제팀을 구성하여 운영함. 팀 구성과 세부 자격은 사업의 목적에 따라 상이하나 특정 교육수료, 전문자격 취득, 임상경력 2~3년 이상 등을 요구함. 장애인 건강주치의는 주치의 교육을 이수해야 함

○ 가정간호 기본방문과 가정형호스피스는 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 따라 본인부담률 20% 적용하나 중증, 희귀난치 질환 등에 적용되는 경우 해당 기준에 따름

- 건강보험 환자 기준 일차의료 방문진료 본인부담률이 30%로 가장 높고, 중증소아 재택의료가 5%로 가장 낮음. 다만, 일차의료 방문진료는 장기요양 1, 2등급 와상환자와 산소치료, 인공호흡기 요양비 대상자는 본인부담률 15%로 함
- 결핵환자, 암환자 등 산정특례 대상 질환자인 경우 동일 기준을 적용함
- 질환군별 재택의료 시범사업 중 일부와 장애인 건강주치의는 환자관리료의 본인부담률이 없음. 기존 본인부담이 없던 시범사업들은 개정을 통해 순차적으로 사업 전체 본인부담률과 동일하게 적용하도록 변경하고 있음

〈표 6〉 재택의료 시범사업 별 팀구성 기준 및 환자 본인부담률 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료		팀구성	본부율
장애인 건강주치의 시범사업		-	10% (환자관리료 본인부담 없음)
중증소아 재택의료 시범사업		(재택의료팀) 의사, 간호사(종합병원 이상 소아청소년 분야 경력 2년 이상), 물리·작업치료사(종합병원 이상 경력 2년 이상), 영양사, 약사, 사회복지사 등	5%
정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리		(사례관리팀) 전문의, 간호사, 사회복지사, 임상심리사 등	10%
재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활		(방문재활팀) 전문의, 간호사, 물리·작업치료사, 사회복지사 등	20%
치매관리주치의 시범사업		-	20%
질환군별 재택의료 시범사업	복막투석 환자	(재택관리팀) 전문의, 간호사	10% (환자관리료 본인부담 없음)
	1형 당뇨병 환자	(재택의료팀) 전문의, 간호사(실무경력 3년 이상), 임상 영양사 (교육전담인력 배치)	
	가정용 인공호흡기 환자	(재택의료팀) 전문의, 간호사(실무경력 3년 이상) (선택)물리치료사	
	심장질환자	(재택의료팀) 전문의, 간호사(실무경력 3년 이상)	
	재활환자	(재택의료팀) 전문의, 간호사, 물리·작업치료사	10%
	결핵환자	(재택의료팀) 전문의, 간호사(실무경력 2년 이상, 결핵관리전담 간호사 기본교육 이수)	0% (산정특례)
	암환자	(재택의료팀) 전문의, 간호사(WOCN 이수 또는 실무경력 3년 이상), 임상 영양사	5% (산정특례)
	암환자(요루)	(재택의료팀) 전문의, 간호사(WOCN 이수 또는 실무경력 3년 이상)	
일차의료 (한의) 방문진료 수가 시범사업		-	30%
가정간호 기본방문료		-	20% (산정특례)
가정형 호스피스		의사, 전담간호사(호스피스·가정전문간호사, 또는 호스피스기관 2년 이상 경력), 1급 사회복지사	20% (산정특례)

나. 수가 및 산정 기준

1) 환자 상태평가 및 계획수립

○ 장애인 건강주치의, 중증소아 재택의료, 정신질환자 지속치료 지원: 병원기반 사례관리, 재활의료기관: 방문재활, 치매관리주치의는 환자의 상태를 평가하고 서비스 제공 계획을 수립함. 가정형 호스피스의 통합환자 관리료는 방문의료를 제외한 평가 및 계획, 교육·상담, 비대면 관리, 팀 회의 등 전체 내용을 포함함

〈표 7〉 건강보험 재택의료 평가·계획수립 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	행위명			점수(점)	금액(원)[1]	산정 횟수	본인부담률[2]
장애인 건강주치의 시범사업	포괄평가 및 계획수립료	일반 건강관리	의원(중증)	672.49	63,280	1회/연	10%
			의원(경증)	526.38	49,530		
		주장애 관리	의원(중증)	672.49	63,280		
			병원 이상(중증)	775.25	63,730		
		통합관리	의원(중증)	1,008.85	94,930		
	중간점검료	일반 건강관리	의원(중증)	378.32	35,600	1회/연	
			의원(경증)	293.76	27,640		
		주장애 관리	의원(중증)	378.32	35,600		
			병원 이상(중증)	436.08	35,850		
		통합관리	의원(중증)	567.48	53,400		
중증소아 재택의료 시범사업	재택의료 관리계획 (재)수립료			2,084.76	171,370	1회/연	5%
정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리	퇴원계획수립료			591.19	48,600	퇴원 시 1회	10%
재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활	재활의료기관 방문재활계획수립료			613.69	50,450	방문재활 전 1회	20%
치매관리주치의 시범사업	포괄평가 및 계획수립료	치매전문 관리	의원	526.38	49,530	1회/연	20%
			병원 이상	606.77	49,880		
		통합관리	의원	684.29	64,390		
	중간점검료	치매전문 관리	의원	293.76	27,640	계획수립 4개월 후	
			병원 이상	338.67	27,840		
		통합관리	의원	381.89	35,940		

* 주 1. 2025년 점수 당 단가: 의원 94.1원, 병원 82.2원 적용
2. 건강보험 가입자 및 피부양자 기준

- 중증소아 재택의료의 관리 계획수립 수가가 가장 높음. 장애인 건강주치의 등은 재수립이나 중간점검 시 약 50% 낮지만 중증소아 재택의료는 동일 수가를 적용한다는 특징이 있음. 또한 다학제팀 회의를 통한 중간평가 및 서비스 변경, 지역사회 연계에 대한 내용을 보상하는 재택의료 평가·연계료[1]가 별도로 있음
- 장애인 건강주치의, 중증소아 재택의료, 치매관리주치의는 연 1회 산정 하며, 환자 상태가 변화된 경우 연 1회 중간점검하거나 재수립함

(단위: 원)



[그림 2] 건강보험 재택의료 평가 및 계획수립 수가수준 (2025년 5월 기준)

○ 동네의원에서 지속적·포괄적·체계적 만성질환 관리를 위해 환자가 의사 1인을 선택하여 포괄평가 후 수립된 관리 계획을 바탕으로 1년 단위 만성질환 관리 서비스를 제공하는 '가-500 만성질환 통합관리료'수가에도 포괄평가 및 계획수립 수가가 포함됨

- 2025년 기준 초기평가 및 계획수립은 연 1회 35,250원 산정 가능하며, 서비스 제공기관 당 500명 이내의 환자만 관리 가능할 수 있음. 2주기부터 산정 가능한 지속계획수립은 27,650원, 점검 및 평가는 27,650원임

1) 654.19점, 2025년 기준 53,770원, 10회/연 산정 가능

2) 교육·상담

○ 교육상담은 환자 및 가족을 대상으로 재택에서 필요한 환자 관리에 대한 교육과 상담을 제공하는 것을 의미함

- 장애인 건강주치의, 중증소아 재택의료, 정신질환 지속치료 지원: 병원기반 사례관리, 치매관리 주치의, 8개 질환군별 재택의료에서 교육·상담 수가를 별도 보상하며 교육 시행자 자격과 제공 시간 등에 따라 수가를 달리함
- 산정 횟수는 초·차기와 환자 특성(연령, 근골격계질환/중추신경계질환, 카테터 사용/파우치 사용)에 따라 구분되기도 함

〈표 8〉 건강보험 재택의료 교육·상담료 수가 수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	행위명		점수(점)	금액(원)[1]	산정 기준			본인 부담률[2]
					교육 시행자	시간	횟수	
장애인 건강주치의 시범사업	교육·상담료 I	의원 (경증·중증)	156.17	14,700	의사 (주치의)	10분 이상 20분 미만	8회/연	10%
		병원 이상 (중증)	180.05	14,800				
	교육·상담료 II	의원 (경증·중증)	274.89	25,870		20분 이상 30분 미만		
		병원 이상 (중증)	316.87	26,050				
	교육·상담료 III	의원 (경증·중증)	393.61	37,040		30분 이상		
		병원 이상 (중증)	453.69	37,290				
중증소아 재택의료 시범사업	교육·상담료		368.98	30,330	재택의료팀	-	12회/연	5%
정신질환자 지속치료 지원 시범사업	교육상담료		203.74	16,750	사례관리팀	-	1회	10%
치매관리 주치의 시범사업	교육·상담료	의원	111.91	10,530	의사 (주치의)	10분 이상	8회/연	20%
		병원 이상	128.94	10,600				
질환군별 재택의료	복막투석	교육상담료 I	516.82	42,480	전문의	15분 이상	초기 4회/연 차기 2회/연	10%
		교육상담료 II	325.63	26,770	재택관리팀	20분 이상	초기 6회/연 차기 4회/연	

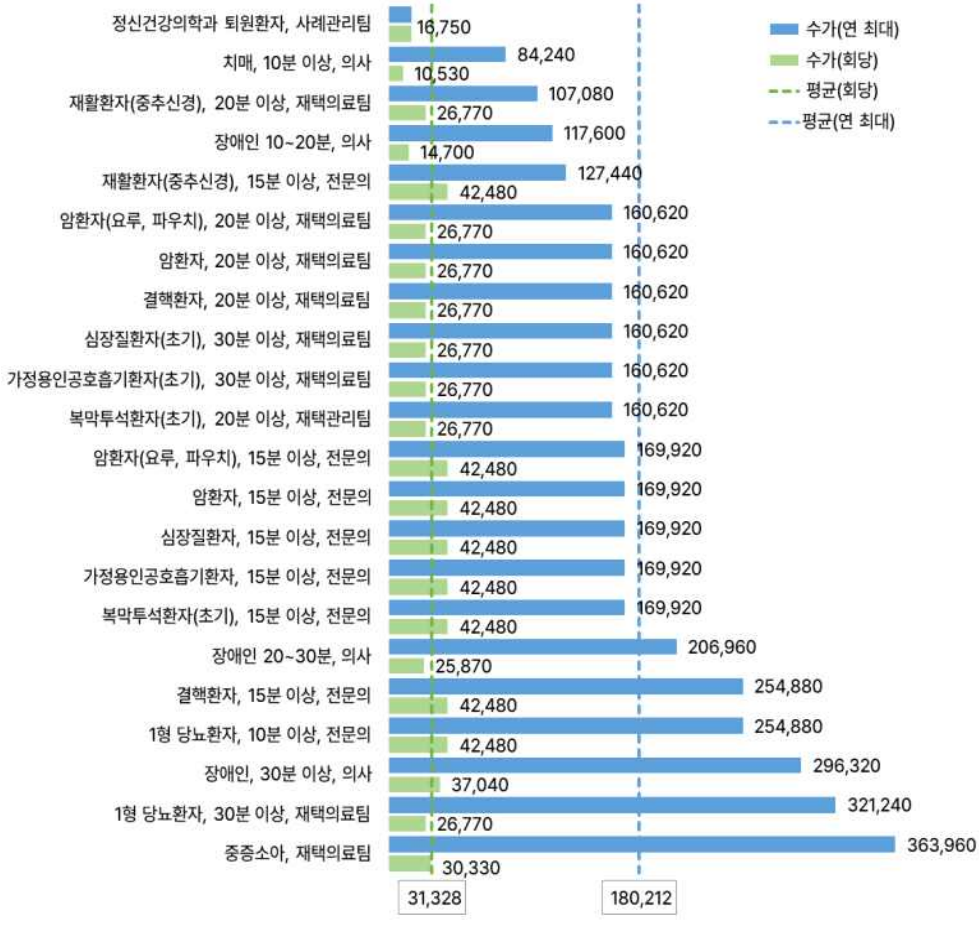
건강보험 재택의료		행위명	점수(점)	금액(원)[1]	산정 기준			본인 부담률[2]
					교육 시행자	시간	횟수	
시범 사업	1형 당뇨병	교육상담료 Ⅰ	516.82	42,480	전문의	10분 이상	6회/연[3]	
		교육상담료 Ⅱ	325.63	26,770	재택의료팀	30분 이상	8회/연[4]	
	가정용 인공 호흡기	교육상담료 Ⅰ	516.82	42,480	전문의	15분 이상	4회/연	
		교육상담료 Ⅱ	325.63	26,770	재택의료팀	30분 이상	초기 6회/연 차기 4회/연	
	심장 질환	교육상담료 Ⅰ	516.82	42,480	전문의	15분 이상	4회/연	
		교육상담료 Ⅱ	325.63	26,770	재택의료팀	30분 이상	초기 6회/연 차기 4회/연	
	재활	교육상담료 Ⅰ	516.82	42,480	전문의	15분 이상	근골격 2회/90일 중추신경 3회/6개월	
		교육상담료 Ⅱ	325.63	26,770	재택의료팀	20분 이상	근골격 3회/90일 중추신경 4회/6개월	
	결핵	교육상담료 Ⅰ	516.82	42,480	전문의	15분 이상	6회/연	0%
		교육상담료 Ⅱ	325.63	26,770	재택의료팀	20분 이상	6회/연	
	암	교육상담료 Ⅰ	516.82	42,480	전문의	15분 이상	4회/연	5%
		교육상담료 Ⅱ	325.63	26,770	재택의료팀	20분 이상	6회/연	
	암 (요루)	교육상담료 Ⅰ	516.82	42,480	전문의	15분 이상	카테터 2회/연 파우치 4회/연	
		교육상담료 Ⅱ	325.63	26,770	재택의료팀	20분 이상	카테터 3회/연 파우치 6회/연	

* 주 1. 2025년 점수 당 단가: 의원 94.1원, 병원 82.2원 적용
2. 건강보험 가입자 및 피부양자 기준
3. 만 19세 미만 초기 8회/연 이내 기준 적용
4. 만 19세 미만 초기 12회/연, 차기 10회/연 이내 기준 적용

○ 교육·상담 수가는 재택의료 뿐만 아니라 암환자 항암화학요법, 방사선 치료와 장루·요루 환자 대상의 교육·상담료(가-23), 만성질환 통합관리료(가-500), 당뇨병, 고혈압 등에 대한 비급여(고-1) 등이 있음

- 만성질환 통합관리료 교육·상담은 시간과 교육 시행자에 따라 Ⅰ(10분 이상, 의사), Ⅱ(20분 이상, 케어코디네이터)로 구분되며 2025년 수가는 각각 163.74점(15,410원), 145.60점(13,700원)임. 1과 Ⅱ를 합산하여 주기당 10회 이내로 산정함
- 가-23 교육상담료는 암환자(항암화학요법, 방사선 치료, 수술 후), 심장질환, 장루·요루, 만성신부전, 복막투석, 혈액투석 환자를 대상으로 하며 6세 미만에 경우 10% 가산, 재교육을 실시한 경우 소정점수의 50%만 산정함. 수가 수준은 전문의가 10~15분간 제공하는 질환군별 재택의료가 가장 높으며, 의원에 소속된 치매 주치의가 10분 이상 실시한 경우 가장 낮음

(단위: 원)



[그림 3] 건강보험 재택의료 교육·상담료 수가수준 (2025년 5월 기준)

3) 방문의료(의사, 간호사, 물리·작업치료사, 사회복지사)

○ 의사의 방문의료는 장애인 건강주치의, 중증소아 재택의료, 정신질환 지속치료 지원: 병원기반 사례관리, 치매관리 주치의, 일차의료 (한의) 방문진료, 가정형 호스피스에서 제공함

○ 모든 시범사업 방문의료 수가는 교통비를 포함하며 가정형호스피스는 이동거리와 무관하게 정액 교통비(108.30점)를 적용함

○ 일부 방문진료료는 방문진료 시 발생하는 행위·약제와 치료재료 관련 비용을 모두 포함하는 방문진료료Ⅰ과 포함하지 않는 방문진료료Ⅱ로 구분함. 가정형호스피스는 초회의 경우 재회에 비해 수가 수준이 높음

- 한의 방문진료료를 제외하고, 방문진료료 Ⅰ, Ⅱ로 구분하지 않는 중증소아 재택의료 등은 행위·약제와 관련 비용을 포함하지 않는 경우로 해석함

- 장애인 건강주치의는 장애의 심한 정도에 따라 수가와 제공 횟수 모두 차등함

○ 일차의료 방문진료는 질 관리를 위해 서비스 제공자의 횟수를 제한함. 장애인 건강주치의는 주치의 1인당 등록환자 수를 200명으로 제한하고 있어 방문의료는 환자 단위 기준을 적용하지만, 등록환자 기준이 없는 치매관리 주치의도 환자 단위임

○ 일차의료 (한의)방문진료 수가 시범사업과 가정형 호스피스는 가산·감산 기준이 있음

- 가산과 감산은 점수 혹은 원 점수의 비율(%)로 정해지며 가산기준은 가정형 호스피스 초회 공휴일 및 야간, 임종돌봄 및 관리 등이 가장 높음

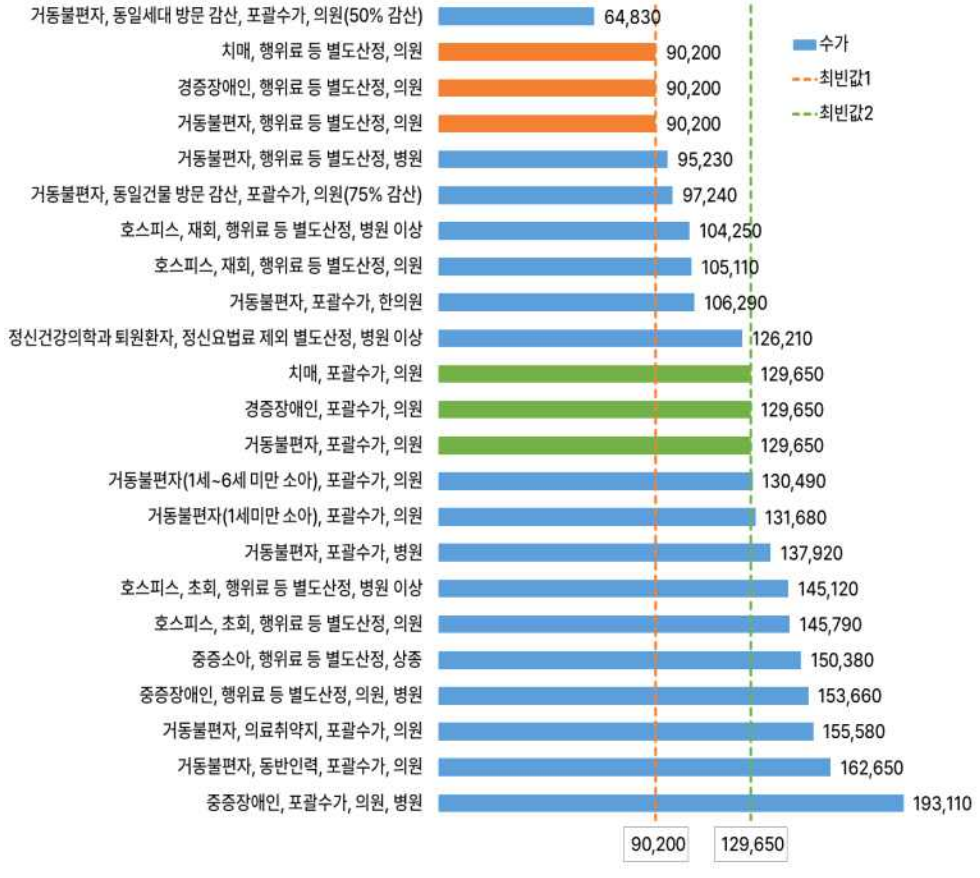
〈표 9〉 건강보험 재택의료 의사 방문료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	행위명			점수(점)	금액(원)[1]	산정 기준	본인 부담률[2]
장애인 건강주치의 시범사업	방문 진료료 I	의원	경증	1,377.81	129,650	• ·(환자 단위) 의사+간호사 중증 24회/연 경증 4회/연 월 최대 4회까지	10%
			중증	2052.23	193,110		
		병원이상 (중증)		2,365.64	194,460		
	방문 진료료 II	의원	경증	958.51	90,200		
			중증	1,632.90	153,660		
		병원이상 (중증)		1,882.27	541,720		
중증소아 재택의료 시범사업	의사 방문료			1,829.39	150,380	• 전문의	5%
정신질환자 지속치료 지원 시범사업	의사 방문료			1,535.38	126,210	• (환자 단위) 전문의+사례관리요원 4회/연 이내	10%
치매관리 주치의 시범사업	방문진료료 I			1,377.81	129,650	• (환자 단위) 4회/연	20%
	방문진료료 II			1,377.81	129,650		
일차의료 방문진료 수가 시범사업	의과	방문 진료료 I	의원	1,377.81	129,650	• ·(의사 단위) 60회/월* * 재택의료센터 100회/월 • ·(환자 단위) 3회/주* * 말기 암환자 등 제외 • (가산) 동반인력(의과만 적용), 소아, 의료접근성취약지 • (감산) 동일건물, 동일세대	30%
			병원 이상	1,677.81	137,920		
		방문 진료료 II	의원	958.51	90,200		
			병원 이상	1,158.51	95,230		
	한의	한의 방문진료료		1,037.97	106,290		
가정형 호스피스	의사 방문료	초회	상종	1,657.15	136,220	• 교통비 108.30점 별도산정 • 전문의 • (가산) 공휴일 및 야간, 임종돌봄 및 관리, 간호사 동시방문	5~60%[3]
			종병	1,657.15	136,220		
			병원	1,657.15	136,220		
			의원	1,441.00	135,600		
		재회	상종	1,160.02	95,350		
			종병	1,160.02	95,350		
			병원	1,160.02	95,350		
			의원	1,008.71	94,920		

* 주 1. 2025년 점수 당 단가: 의원 94.1원, 병원 82.2원 적용
2. 건강보험 가입자 및 피부양자 기준
3. 암 5%, 후천성면역결핍증 10%, 만성폐쇄성호흡기질환·만성간경화 30~60%

○ 중증장애인 대상 포괄수가(장애인 건강주치의)는 포괄수가 최빈값(일차의료 방문진료 등)과 비교하여 약 150% 수준이며, 가정형 호스피스 초회수가에 공휴일 및 야간, 임종돌봄 및 관리 등의 가산과 별도 산정 가능한 교통비를 적용하면 22만 원 이상으로 가장 높음

(단위: 원)



[그림 4] 건강보험 재택의료 의사 방문료 수가수준 (2025년 5월 기준)

〈표 10〉 건강보험 의사 방문의료 수가 가감산 기준 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	구분	기준	규모 (점수 혹은 가산)	금액(원)[1)]
일차의료 방문진료 수가 시범사업	가산	동반인력(간호사, 물리·작업치료사)	350.69점	33,000
		1세 미만 1~6세 미만	21.56점 8.88점	2,030 840
		의료접근성취약지 방문진료료 Ⅰ 의료접근성취약지 방문진료료 Ⅱ	275.56점 191.70점	25,930 18,040
	감산	동일건물 동일세대	75% 50%	97,240 64,830
일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업	가산	1세 미만 1~6세 미만	21.56점 8.88점	2,210 910
		의료접근성취약지	207.59점	21,260
	감산	동일건물 동일세대	75% 50%	79,720 53,150
가정형 호스피스	가산	공휴일 및 야간	30%	(초회) 40,870
		임종돌봄 및 관리	30%	
		간호사 동시방문	30%	
		교통비	108.30점	8,900

* 주. 2025년 점수 당 단가: 의원 94.1원, 한의원 102.4원, 병원 82.2원 적용. 가정형 호스피스는 병원 기준, 일차의료 (한의) 방문진료료 기준

○ 간호사의 방문의료는 장애인 건강주치의, 중증소아 재택의료, 가정간호 기본방문료, 가정형 호스피스에 포함됨. 정신질환자 지속치료 지원: 병원기반 사례관리와 일차의료 방문진료 수가 시범사업은 동반인력 가산과 팀 방문으로 간호사 방문의료를 일정 부분 보상함

○ 간호사 방문료는 가정간호사 등 전문 간호사나 특정 기간 이상의 임상 경력을 요구하며, 자격과 동시 방문 가능 여부에 따라 수가 차이가 있음

- 가정간호는 의료법 시행규칙에 따라 가정전문간호사만 시행 가능했으나 2024년 12월 관련 법령 개정으로 의원과 병원급에 한해 가정간호에 관한 교육을 이수하는 등 보건복지부 장관이 정하여 고시하는 요건을 갖춘 경우에도 실시 할 수 있도록 변경됨

〈표 11〉 건강보험 간호사 방문의료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	행위명			점수(점)	금액(원)[1]	산정 기준	본인 부담률[2]
장애인 건강주치의 시범사업	방문 간호료	의원		852.64	80,230	• ·(환자 단위) 의사+간호사 중증 24회/연 경증 4회/연 월 최대 4회까지	10%
		병원 이상	중증	982.88	80,790		
중증소아 재택의료 시범사업	간호사 방문료			1,079.32	88,720	• 종합병원급 이상 의료기관에서 소아청소년 분야 임상경력 2년 이상 또는 가정전문간호사	5%
가정간호 기본방문료	가정간호 기본방문료	상급종합		961.01	79,000	• 가정전문간호사 등 • (간호사 단위) 7회/일 • (가산) 1세 미만 소아 20%, 초회 간호사 2인방문 50% • (감산) 사회복지시설 50%	20%
		종합병원		928.97	76,360		
		병원		897.60	73,780		
		의원		852.64	80,230		
		한의원		850.59	87,100		
가정형 호스피스	간호사 방문료	상급종합		1,112.52	91,450	• 호스피스전문간호사, 가정전문간호사 또는 호스피스 전문기관에서 경력 2년 이상 간호사 • 교통비 108.30점 별도산정 • (가산) 공휴일 및 야간, 임종 돌봄 및 관리 30%	5~60%[3]
		종합병원		1,112.52	91,450		
		병원		1,112.52	91,450		
		의원		969.29	91,210		

* 주 1. 2025년 점수 당 단가: 의원 94.1원, 병원 82.2원 적용
2. 건강보험 가입자 및 피부양자 기준
3. 암 5%, 후천성면역결핍증 10%, 만성폐쇄성호흡기질환·만성간경화 30~60%

- 가정간호 기본방문료는 2020년 1월 고시 개정[2] 시행으로 만 1세 미만 소아 가산 20%를 제외한 연령·시간에 대한 가산과 환자가 100분의 100으로 부담하였던 교통비를 방문료에 포함하여 수가를 조정함. 또한 간호사 1인당 하루 방문가능 횟수와 요양시설 등 사회복지시설에서 서비스를 제공하는 경우에 대한 내용을 추가함

2) 보건복지부 고시 제2019 -263호, 제 2019-302호

〈표 12〉 2020년 가정간호 기본방문료 수가 기준 변경사항 (2025년 5월 기준)

구분	개정 전	개정 후 현재 기준 (복지부 고시 2019-263호, 2019-302호)
수가 조정	약 44천원 ~ 약 47천원 ('19년 기준) * 교통비(108.30점) 환자 전액본인부담	약 70천원 ~ 약 78천원 ('20년 기준) * 교통비 포함
가산 정비	1세미만(50%), 1세~6세미만(30%), 70세 이상 가산(30%)	1세미만 가산(20%)유지, 그 외 가정간호 기본방문료에 반영
	평일 18시(토요일 13시)~09시 또는 공휴일 가산(50%)	-
	-	간호사 2인 가산 신설 * 가정간호 기본방문료 50% 가산
수가 차등화	-	종별 재택/요양시설 차등 * 사회복지시설 재가환자 가정간호 기본방문료의 50% 산정
방문횟수	제한 없음	방문가능 횟수 7회 이하(간호사 1인당/1일)

(단위: 원)



[그림 5] 건강보험 재택의료 간호사 방문료 수가수준 (2025년 5월 기준)

○ 물리·작업치료사의 방문의료는 중증소아 재택의료, 재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활에 포함됨. 일차의료 방문진료 수가 시범사업은 동반인력으로 물리·작업치료사 방문의료를 일정 부분 보상함. 재활의료기관 수가 시범사업은 별도의 이학요법료가 방문료에 모두 포함되어 있으며, 중증소아 재택의료는 별도산정 할 수 있음

○ 사회복지사 방문료는 가정형 호스피스만 있음. 정신질환자 지속치료 지원: 병원기반 사례관리와 재활의료기관: 방문재활은 팀 방문으로 사회복지사 방문을 일정 부분 보상함

〈표 13〉 건강보험 물리·작업치료사 방문의료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	행위명		점수(점)	금액(원)[1]	산정 기준	본인 부담률[2]
중증소아 재택의료 시범사업	물리·작업치료사 방문료		911.02	74,890	• 18회/연, 최대 5회 추가 가능 • 이학요법료 별도산정 가능 • 종합병원 이상 2년 경력	5%
재활의료기관 수가 시범사업	방문 재활 치료료	치료사 2인	2,259.31	185,720	• 주 2회(60분 이상) • 최대 120일 제공 • 이학요법료 별도산정 불가	20%
		치료사 1인, 사회복지사 1인	1,899.62	156,150		
		치료사 1인	1,367.48	112,410		

* 주 1. 2025년 점수 당 단가: 의원 94.1원, 병원 82.2원 적용
2. 건강보험 가입자 및 피부양자 기준

4) 환자관리

○ 환자관리는 비대면 서비스로 비정기적 상담을 위한 온콜 시스템(on-call system), 전화를 통한 의사 등의 환자 상태 확인, 다학제 팀회의 등을 의미함. 환자와 직접적으로 대면하지 않아 본인부담률이 없는 경우도 있음

○ 장애인 건강주치의, 중증소아 재택의료, 정신질환 지속치료 지원: 병원기반 사례관리, 재활의료기관: 방문재활, 치매관리 주치의, 8개 질환군별 재택의료, 가정형 호스피스에서 별도 보상함

- 정신질환자 지속치료 지원사업과 가정형 호스피스를 제외한 모든 사업이 월 1회 산정하며 서비스 제공 횟수는 월 1회부터 상시 관리까지 다양함

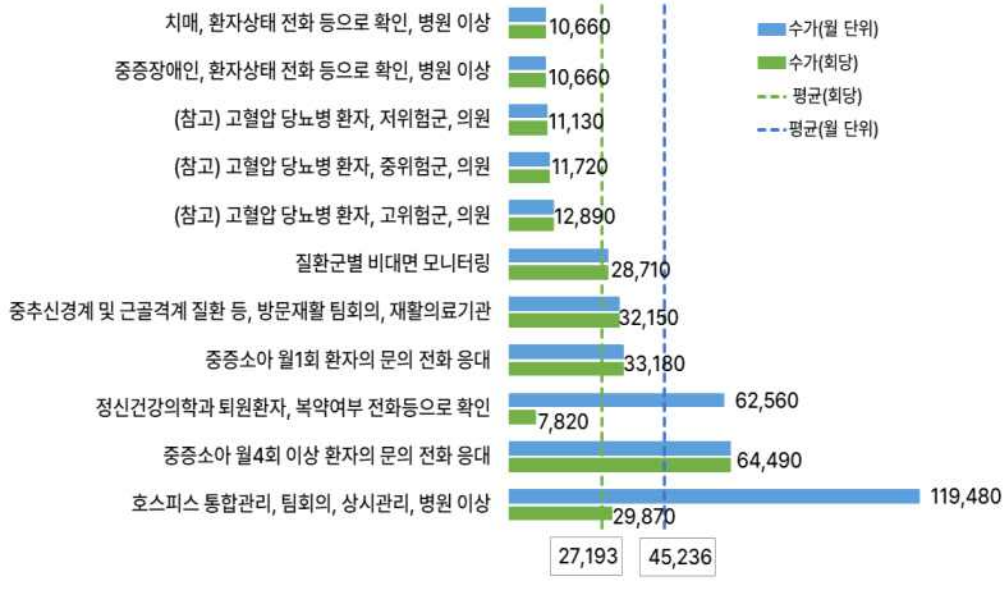
〈표 14〉 건강보험 재택의료 환자관리료 수가수준 및 산정 기준 (2025년 5월 기준)

건강보험 재택의료	행위명		점수(점)	금액(원)[1]	산정 기준			본인 부담률[2]
					제공자	관리 횟수	산정 횟수	
장애인 건강주치의 시범사업	환자 관리료	의원	111.89	10,530	의사 (주치의)	1회/월	1회/월	0%
		병원이상 (중증)	128.94	10,600				
중증소아 재택의료 시범사업	환자 관리료	기본	403.59	33,180	전문의, 간호사	1회/월	1회/월	5%
		집중	784.60	64,490		4회/월		
정신질환자 지속치료 지원	환자관리료		95.09	7,820	사례관리팀	-	8회/월	0%
재활의료기관 수가 시범사업	재활의료기관 방문재활관리료		391.07	32,150	방문재활팀	-	1회/월	20%
치매관리 주치의 시범사업	환자 관리료	의원	111.91	10,530	의사 (주치의)	1회/월	1회/월	20%
		병원 이상	128.94	10,600				
질환 군별 재택 의료	복막 투석	환자 관리료	349.26	28,710	재택관리팀	2회/월[3]	1회/월	0%
	1형 당뇨병	환자 관리료	349.26	28,710	재택의료팀	2회/월	1회/월	
	가정용 인공 호흡기	환자 관리료	349.26	28,710	재택의료팀	2회/월	1회/월	
	심장 질환	환자 관리료	349.26	28,710	재택의료팀	1회/월	1회/월	
	재활	환자 관리료	349.26	28,710	재택의료팀	2회/월	1회/월	10%
	결핵	환자 관리료	349.26	28,710	재택의료팀	2회/월	1회/월	0%
	암	환자 관리료	349.26	28,710	재택의료팀	2회/월	1회/월	5%
	암 (요루)	환자 관리료	349.26	28,710	재택의료팀	2회/월[4]	1회/월	
가정형 호스피스	통합 환자 관리료	상종	363.41	29,870	호스피스팀	• 상시 • (가산) 초회 50%	1회/주	0%
		종병	363.41	29,870				
		병원	363.41	29,870				
		의원	316.17	29,750				

* 주 1. 2025년 점수 당 단가: 의원 94.1원, 병원 82.2원 적용
2. 건강보험 가입자 및 피부양자 기준
3. 자동전송의 경우 3회/주 자료 확인, 1회/월 전화
4. 파우치는 최대 12회, 카테터는 최대 6회 산정

- 사업별 청구 주기(월/주)가 달라 회당 수가는 중증소아 집중이, 월 8회까지 청구 가능한 것을 고려하면 정신건강의학과 퇴원환자 대상 수가가 가장 높음
  - 주 1회 청구 가능한 것을 고려하면 가정형 호스피스 수가가 가장 높음. 다만 가정형 호스피스는 평가 및 계획수립도 포함된 수가임을 고려해야 함

(단위: 원)



[그림 6] 건강보험 재택의료 환자관리료 수가수준 (2025년 5월 기준)

○ 건강보험 재택의료는 아니지만 만성질환 통합관리의 일환인 일차의료 만성질환관리 시범사업의 환자관리료는 전화 등을 통해 임상 수치 및 환자 상태를 확인한 경우 월1회 산정함. 저위험군(118.31점, 11,130원), 중위험군(124.54점, 11,720원), 고위험군(136.99점, 12,890원)으로 수가를 구분함

- 포괄평가 및 계획수립의 문진, 신체검사, 임상검사 등의 결과를 활용하여 분류된 환자위험군 등급으로 1년간 산정함

다. 재택의료 시범사업 평가지표 및 결과

○ 건강보험 시범사업은 「건강보험 시범사업 추진절차 및 평가에 대한 훈령(보건복지부 훈령 제120호)」에 따라 최대 3년을 주기로 하며, 종료되는 해에 추진성과, 비용효과성 및 대체가능성, 건강보험 요양급여 적용 필요성 등이 포함된 성과보고서를 건강보험 시범사업 심의위원회에 제출해야 함

○ 2024년 7월 도입된 치매관리주치의 시범사업을 제외한 14개 시범사업에 대해 최대 3년 주기로 1회 이상 평가연구가 수행되었으며, 본 연구에서는 가장 최근 보고서의 평가지표와 결과를 확인함. 시범사업별 대상 질환과 제공 형태가 다르지만, 의료접근성 향상, 불필요한 입원 및 응급 이용 축소, 연속적 관리 확보, 참여자 만족도 제고, 비용효과성 확보 등 유사한 범주의 평가지표를 사용하여 성과를 측정함

- 의료이용 변화 지표로 외래 이용량, 응급 이용, 입원 일수 및 입원율, 재입원율 등을 활용함. 이 지표는 입원이나 응급실 이용 등의 의료 이용이 감소하고 의료접근성이 유지 또는 향상되는지를 보여줌
- 재택복귀 유지율 등의 지표는 재택의료가 단순히 의료접근성을 넘어서 환자의 기능적 상태와 지속 가능성에 어떤 영향을 주는지를 반영함
- 평가 대상인 재택의료 시범사업은 시행 기간이 비교적 짧고, 고령의 중등증 이상의 환자를 대상으로 하는 경우가 대부분으로 건강상태 개선 등의 결과지표를 도출하기 어려워 참여자의 만족도를 주요 지표로 활용함. 평가결과 환자와 보호자, 의료진 등의 사업 만족도와 지속 참여 의향은 모두 70% 이상으로 높게 나타남. 이는 삶의 질과 주관적 건강상태 개선에 관한 내용을 모두 포함함

○ 비대면 모니터링과 교육·상담만 제공하는 질환군별 재택의료 평가연구에서는 방문의료를 추가 혹은 연계하도록 하고 질환군별로 구분된 사업을 하나로 통합하여 중증도에 따른 차등 수가를 적용할 것을 제안함(장석용 외, 2024)

- 지속적 교육·상담이 필요한 인공호흡기 등 장치삽입 환자와 응급상황에 대비한 모니터링으로 의료진과의 즉각적 양방향 의사소통이 필요한 심장질환자는 중증군으로 구분하며, 복막투석 환자와 1형당뇨병 환자를 중등증으로 구분할 것을 제안함

〈표 15〉 건강보험 재택의료 시범사업 평가지표 및 결과

건강보험 재택의료		주요 평가지표 및 결과
장애인 건강주치의[1]		• 적극참여자의 만성질환 외래 이용건수 증가(7.4건→11.9건) • 응급이용 감소(1.0건→0.6건) • 외래의료민감성 질환(ACSC) 입원 경험 감소(10.9%→7.5%)
중증소아 재택의료[2]		• 1인당 평균 입원진료비 13,636천원, 입원일수 12.9일 낮음 • 1인당 평균 외래 진료비 5,712천원, 외래일수 37일 높음 • 환자와 보호자의 삶의질 향상효과가 있다는 응답 94.0%, 95.2
정신질환자 지속치료 지원: 병원기반 사례관리[3]		• 1인당 재원일수 감소(73.2일→58.9일) • 30일 이내 재입원율 감소(64.5%→51.2%) • 1인당 총 입원 의료비 증가 (1,556천원→2,262천원)
재활의료기관: 방문재활[4]		• 방문재활 종결 후 재택복귀유지율* 90.3% * 재택복귀유지율 = (방문재활 종결 후 30일 이내 재활관련 입원 청구내역이 없는 환자 수) / (방문재활을 종결한 전체 환자 수)
질환군별 재택의료	복막투석 환자[5]	• 비용-편익분석 결과 순 편익은 350,206원 • 의료진 사업만족도 82.0%, 환자 94.5% 지속참여 의향 있음
	1형 당뇨병 환자[5]	• 비용-편익분석 결과 순 편익은 176,666원 • 의료진 사업만족도 73.3%, 환자 93.8% 지속참여 의향 있음
	가정용 인공호흡기 환자[5]	• 비용-편익분석 결과 순 편익은 1,548,455원 • 의료진 사업만족도 66.7%, 환자 100% 지속참여 의향 있음
	심장질환자[6]	• 등록환자가 미등록환자에 비해 약 1,613천원 적음 • 의료진 사업만족도 50.0%, 환자 88.0% 지속참여 의향 있음
	재활환자[6]	• 등록환자가 미등록환자에 비해 약 2,169천원 적음 • 의료진 사업만족도 55.0%, 환자 89.5% 지속참여 의향 있음
	결핵환자[6]	• 등록환자가 미등록환자에 비해 약 5,321천원 적음 • 의료진 사업만족도 59.0%, 환자 93.0% 지속참여 의향 있음
	암환자[6]	• 등록환자가 미등록환자에 비해 약 17,953천원 적음 • 의료진 사업만족도 70.0%, 환자 92.9% 지속참여 의향 있음
	암환자(요루)[5]	• 비용-편익분석 결과 순 편익은 1,055천원 • 의료진 사업만족도 63.7%, 환자 73.0% 지속참여 의향 있음
일차의료 방문진료[7]		• 환자의 78.0% 만족하며 83.5%가 향후 시범사업에 지속 참여하겠다고 응답 • 의사의 77.7%가 향후 시범사업 지속참여 희망
일차의료 한의 방문진료[8]		• 건강보험 환자의 한의 방문진료 이용 후 한의원 외래 내원일수 및 외래진료 감소 • 환자의 82.1%, 참여 한의사 89.6%가 시범사업에 만족, 지속참여 희망

* 자료 1. 박진관 외. 장애인 건강주치의 시범사업 평가 및 제도 활성화 방안. 심사평가원. 2022.
2. 홍미영 외. 중증소아 재택의료 시범사업 2차 효과평가 및 개선방안. 심사평가원. 2024.
3. 김성완 외. 정신질환자 지속치료 지원 시범사업 평가(2차). 전남대산학협력단, 심사평가원. 2024.
4. 배하석 외. 급성기환자 퇴원지원, 재활의료기관 수가 시범사업 효과평가 및 모형개선 연구. 이화여대산학협력단, 심사평가원. 2025.
5. 장석용 외. 질환군별 재택의료 시범사업 효과분석. 연세대산학협력단, 심사평가원. 2024.
6. 지영건 외. 질환군별 재택의료 시범사업 효과평가.차의과대산학협력단, 심사평가원. 2023.
7. 홍미영 외. 일차의료 방문진료 수가 시범사업 효과평가 및 개선방안. 2022.
8. 위세아 외. 일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업 효과평가 및 개선방안. 심사평가원. 2024.

라. 건강보험 재택의료 소결

○ 2025년 5월 기준, 건강보험 시범사업 중 방문의료가 포함되거나 사업명에 재택이 있는 사업은 총 15개로 통합·포괄적 의료서비스, 비대면 관리, 방문진료 등으로 분류됨. 주요 사업 목적은 의료접근성 향상, 지속적이고 통합적인 의료서비스 제공, 불필요한 입원 및 의료비 감소 등임

- 질환군별 재택의료 시범사업은 복막투석, 1형 당뇨병, 가정용 인공호흡기 환자 등을 대상으로 하며, 의료인의 직접 방문 없이 교육·상담 및 정기적 모니터링 등 비대면 관리 서비스를 제공하는 것이 특징임
- 행위별 수가인 가정간호 기본방문료와 가정형 호스피스도 재택의료 범주에 포함됨

○ 건강보험 재택의료는 '주치의', '재택의료', '사례관리', '방문', '가정' 등으로 혼재됨. 예를 들어, '중증소아 재택의료'와 '가정용 인공호흡기 환자 재택의료'는 명칭이 유사하지만 서비스 내용이 다르며, 비대면 관리 사업인 질환군별 재택의료는 '재택관리'라는 용어를 사용하기도 함. 이러한 용어의 불일치는 사업의 목적과 내용에 대한 명확한 이해를 방해함

○ 서비스 내용은 평가 및 계획수립, 교육·상담, 환자 방문, 환자 관리 등이 있으며, 사업별로 제공되는 서비스와 수가 구성이 상이함. 환자 관리는 온콜 시스템 운영, 양방향 소통, 다학제팀 회의 등으로 구분됨

- 일반적으로 거동불편자 대상이지만, 정신질환자 지속치료 지원 시범사업처럼 거동불편 여부를 고려하지 않는 경우도 있음. 질환군별 재택의료는 비대면 모니터링 필요 환자군을 대상으로 하며, 서비스 제공 기간은 사업 목적과 환자 특성에 따라 상이함

○ 서비스 제공은 의료기관 종별 구분에 따라 제한되며, 팀 구성은 사업 목적에 따라 다르며, 특정 교육 수료, 전문 자격 취득, 임상 경력 2~3년 이상 등을 요구하기도 함

○ 환자 본인부담률은 0%에서 30%까지 다양하게 적용되며, 중증·희귀난치 질환 등 산정특례 대상자는 별도 기준을 따름. 수가 및 산정 기준 또한 환자 상태 평가 및 계획수립, 교육·상담 등 서비스 내용에 따라 다르게 책정됨

○ 유사한 서비스라 하더라도 수가와 산정 기준은 사업별 대상자 특성과 운영 목적에 따라 상이함. 이는 서비스 제공 인력의 자격 요건, 대상자의 중증도 등 구조적 차이에 기인하는 것으로, 단순 비교 시 오해가 발생할 수 있어 해석에 유의해야 함

2. 장기요양 재택의료센터 시범사업[3)]

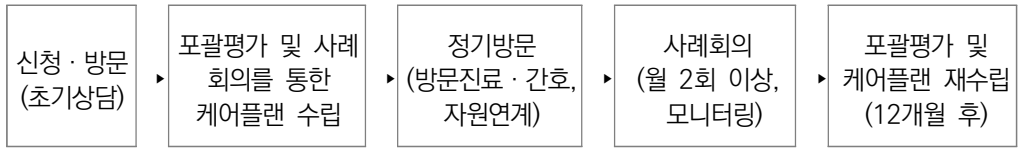
○ (개요) 거동이 불편하여 의료기관에 내원하기 어렵다고 의사가 판단한 장기요양수급자를 대상으로 의사, 간호사, 사회복지사 등이 가정을 방문하여 방문진료·간호 및 지역사회 돌봄 서비스 연계 등 제공함

○ 사업 대상

- (환자) 장기요양 재가 수급자 1~2등급자를 우선으로 거동이 불편하여 재택의료가 필요한 사람으로 의사가 판단한 경우. 노인주거복지시설 및 장기요양기관 입소자는 서비스 제공이 불가함
- (의료기관) 「일차의료 방문진료 수가 시범사업」에 참여 중인 의원급 의료기관과 지방의료원·보건의료원·보건소(지소)임. 참여 희망 의료기관 소관 지방자치단체(시·군·구)가 해당 의료기관과 협약하여 건강보험공단에 신청함
- (서비스 제공 인력) 의사, 간호사, 사회복지사 등 각 1인 이상으로 팀 구성
  - (의사) 일반의 또는 전문의
  - (간호사) 임상경력 24개월 이상인 간호사 또는 가정전문 간호사
  - (사회복지사) 1급 또는 2급 사회복지사

○ (서비스 내용) 수급자 가정을 팀 단위로 방문하여 포괄평가를 각 영역별로 실시하고 케어플랜 수립, 방문진료 및 간호, 지역사회 자원 연계 등 통합 사례관리 제공

- 포괄평가는 의사, 간호사, 사회복지사 등 팀 단위 방문 원칙
- 의사는 월 1회 이상 방문진료, 간호사는 월 2회 이상 방문간호 제공
- 사회복지사는 주기적 상담을 통한 요양·돌봄 수요 발굴 및 서비스 연계



[그림 7] 장기요양 재택의료 시범사업 서비스별 세부 내용

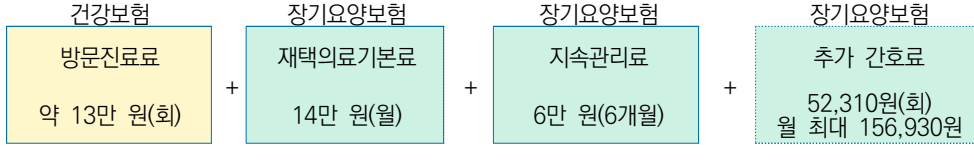
3) 보건복지부, 국민건강보험공단. 장기요양 재택의료센터 시범사업 지침. 2025.

○ (급여비용) 건강보험 수가(기존)에 장기요양보험 수가(신설)를 더하여 지급

- (방문진료료) 의사 1인당 월 최대 100회까지 가능하며, 나머지 사항은 일차의료 방문진료 수가 시범사업에서 정한 사항을 따름
- (재택의료기본료) 건강상태 및 사회·환경 등을 포괄적으로 평가하고 케어플랜을 수립한 후 재택의료팀이 사례 관리한 경우 산정함
- (지속관리료) 6개월 이상 연속하여 사례관리를 제공한 경우 산정함
- (추가 간호료) 기본 제공되는 2회를 초과한 경우 월 최대 3회까지 추가로 산정 가능함

〈표 16〉 장기요양 재택의료센터 시범사업 급여 산정기준

구분		산정 기준
건강보험		• 일차의료 방문진료수가 시범사업 – (의사 단위) 최대 100회/월 – 1회 방문 시 방문진료료(129,650원), 건강보험환자 본인부담 30%
장기요양보험	재택의료기본료	• (수급자 단위) 1회/월 산정 • 수급자 사망으로 종결 시 50% 산정 • 수급자 본인부담 없음
	지속 관리료	• (수급자 단위) 1회/6개월 • 수급자 본인부담 없음
	추가 간호료	• (수급자 단위) 기본 2회를 초과한 경우 추가 3회/월 산정 가능 • 1인당 최소 30분 이상 방문 • 수급자 본인부담률 건강보험 15%, 의료급여 6%, 기초수급자 면제



[그림 8] 장기요양 재택의료센터 시범사업 기본수가 모형

○ (효과평가 결과) 2022년 12월~2023년 5월 기간 동안 재택의료센터 참여자와 미참여자의 시범사업 이용 전, 후 6개월간의 현황 비교분석 결과[4)]

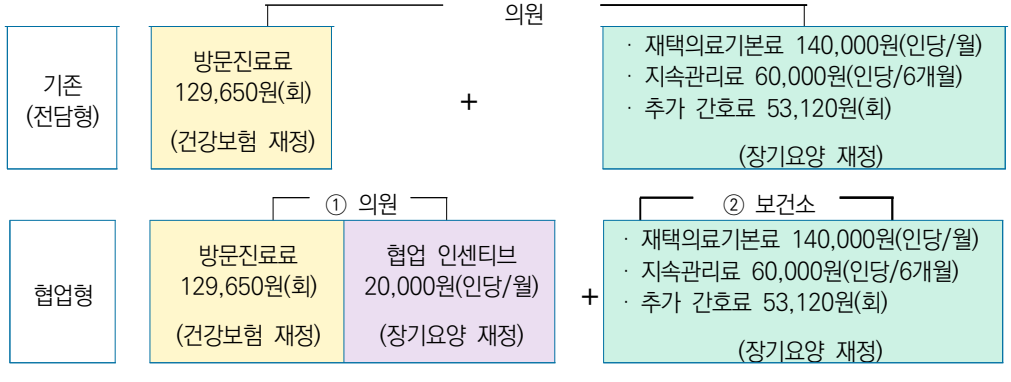
- (의료이용) 응급실 방문 횟수는 참여군 0.6회→0.4회 감소, 미참여군 0.5회→0.6회 증가함. 입원일수는 참여군 6.6일→3.6일 감소, 미참여군 6.3일→8.5일 증가함. 건강보험 진료비는 참여군 3,782천원→3,039천원 감소, 미참여군 4,240천원→5,028천원 증가함

- (요양병원 입원 위험) 참여군이 대조군에 비해 요양병원 입원 발생을 통계적으로 유의하게 27% 예방함(위험비 0.73)

○ 정부는 2026년 1월 이후 시범사업 계정을 다음과 같이 예고함[5)]

- 82개 군지역 또는 공모시작 시범 기준 재택의료센터가 지정되어 있지 않은 시·구 지역의 경우, 일차의료 방문진료 수가 시범사업 참여 의료기관의 의사와 보건소의 간호사, 사회복지사로 팀을 구성하여 공동참여 할 수 있음. 동일 지역 내 의료기관 참여가 원칙이나 참여를 희망하는 의료기관이 없는 경우 인접 지역 의료기관과 협업하여 참여 가능함. 이를 의원-보건소 협업형으로 구분함

- 기존 수가에서 의원은 방문진료료, 보건소는 재택의료기본료를 지급함. 의원은 방문진료 외 추가적 사례관리에 대한 보상으로 협업 인센티브를 신설함

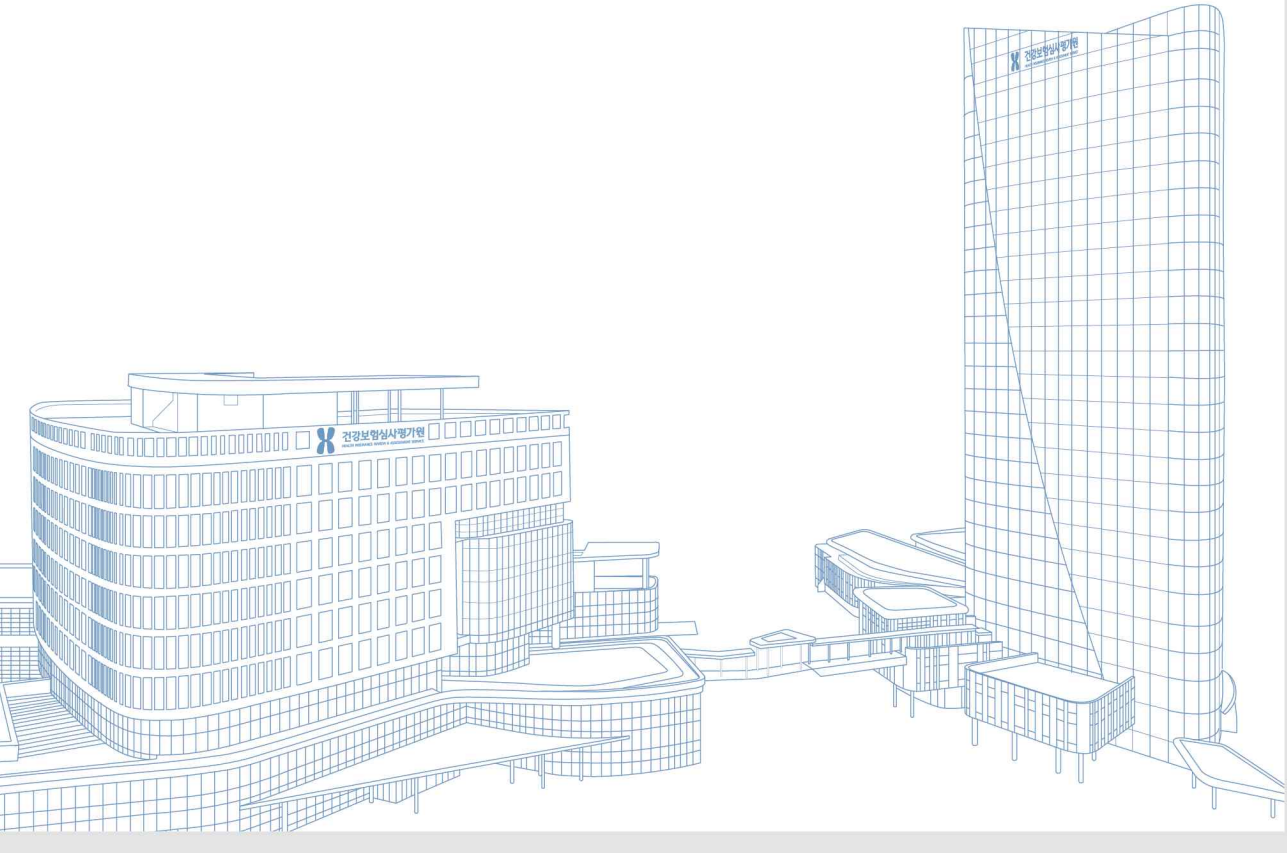


[그림 9] 장기요양 재택의료센터 시범사업 의원-보건소 협업형 모형

4) 이정석 외. 장기요양 재택의료센터 시범사업 효과분석: 의료이용과 시설 입소예방. 국민건강보험공단. 2024.
5) 보건복지부 공고 제2025-737호. 「장기요양 재택의료센터 시버맛업」참여 지방자치단체·의료기관 공모. 2025.10.28.

제3장

외국의 재택의료 수가체계



제3장 외국의 재택의료 수가체계

1. 일본 건강보험 재택의료 제도

가. 개요

○ (대상자) 재택요양 중인 통원 곤란자로 질병이나 외상 혹은 고령에 의한 ADL 저하 또는 인지증 외 정신질환 등에 의한 장해로 자력통원이 어려운 경우를 의미하며 일상생활의 행동에 지장을 주는 장애가 있는 고령자, 신경계 난치병이나 외상 후유증을 가진 소아·청소년 장애인, 악성질환 말기 환자로 구분함. 의료기관 입원환자는 대상자에서 제외되나 요양시설 입소환자는 포함됨(Yoshimura R, 2023)

○ (개호보험과 역할 구분) 질병 치료와 증상 악화 방지 목적은 건강보험을, 생활지원과 기능유지 목적인 경우 개호보험을 적용함. 동일·유사 서비스는 개호보험을 우선 적용함(의료보험과 개호보험의 급여 조정에 관한 유의사항, 2024.3.27.)

- 다만 아래의 기준에 해당하는 경우 우선적으로 건강보험을 적용함
  - (중증·희귀 질환) 말기 악성 종양, 다발성 경화증, 중증 근무력증, 스몬병, 근위축성 측삭경화증(ALS), 척수소뇌 변성증, 헌팅턴병, 진행성 근이영양증, 파킨슨병, 다계통 위축증, 프리온병, 아급성 경화성 전뇌염(SSPE), 라이소좀병, 부신백질이영양증, 척수성 근위축증, 구척수성 근위축증, 만성 염증성 탈수초성 다발 신경병, 후천성 면역결핍 증후군(AIDS), 경수 손상, 인공호흡기 사용
  - (급성악화로 주3일 이상 방문간호 필요) 폐렴, 요로감염, 심부전, 욕창, 신경계 질환의 급성악화로 의사가 주 3일 이상 방문간호가 필요하다고 판단한 경우. 급성악화 기간은 최대 14일로 재판정을 통해 연장 가능함
  - (치매 외 정신질환으로 정신과적 관리 필요) 조현병, 양극성 장애, 중증 우울증, 발달장애, 알코올·약물 의존에 따른 정신질환, 외상후 스트레스 장애(PTSD) 등으로 지속적인 관찰과 투약 관리, 자·타해 위험 관리 등 정신과 치료가 필요한 경우
- 의사가 케어매니저 및 방문간호스테이션과 협의를 통해 작성한 방문간호지시서로

대상자를 판단하며, 보험자는 개별 케이스를 심사·승인할 권한이 있음

○ (제공 기관) 모든 진료소와 병원이 재택의료 가능하지만 재택요양지원 기준에 충족한 경우 전년도 지속관리 환자 수(70명 이상, 50~69명, 30~49명으로 구분)에 따라 가산 수가가 인정되며, 기능강화형은 이에 추가 수가를 더함(진료수가표 시설기준. 2024)

- (재택요양지원) 진료소는 기준 요건을 충족하면 재택요양지원기관으로 인정되며, 병원은 특성에 맞는 추가 요건을 만족해야 함
  - (기준 요건) 환자의 요구에 따라 24시간 왕진과 방문간호가 가능하며, 응급입원 대응 체계, 재택임종돌봄 실적(연 1회 이상), 타 의료기관이나 개호서비스 연계 담당자(케어매니저)와 협력체계 등 구축
  - (병원 추가 요건) 허가 병상 200병상 미만이거나 반경 4km의 거리에 다른 진료소가 없으면서 재택의료 담당 의사 3명 이상이 상근하는 경우
- (기능강화형) 재택의료지원 기관의 요건을 모두 충족하고 추가로 재택의료 담당 상근 의사 3명 이상, 긴급 및 야간 왕진 실적(연 10회 이상), 재택사망 또는 14세 미만 아동 관리 실적(연 4회 이상) 등의 요건을 만족해야 함. 연계유형에 따라 단독형은 한 의료기관 단독으로, 연계형은 2개 이상의 의료기관 네트워크를 통해 요건을 충족하는 경우를 의미함
  - 2020년 진료소 기준 재택요양지원의 약 24%가 기능강화형 기준을 충족했으며, 단독형은 전체 기능강화형의 약 5.8% 수준임(2020년 의료시설조사, 2021)

○ (본인부담률) 재택의료만의 별도 본인부담률 기준은 없으며, 연령과 소득수준에 따라 차등함. 6세 미만까지 20%가 적용되며, 70세 이상 75세 미만은 20%, 75세 이상은 10%임. 단, 근로소득이 있는 현역소득자의 경우 30% 부과함

〈표 17〉 일본 건강보험 환자 본인부담률

소득수준 / 연령	일반·저소득자	현역 소득자
6세 미만	20%	
60세 이상 70세 미만	30%	30%
70세 이상 75세 미만	20%	
75세 이상	10%	

* 자료: 후생노동성, 국민건강보험제도의 개요. 2021

○ (교통비) 실비전액 환자가 부담함. 다만 의료기관이 없는 산간벽지 및 가까운 의료기관에서 거리가 편도 16km를 넘거나 소아과 진료와 같이 환자에게 요구되는 전문진료가 제공할 수 없는 등의 조건에 해당하는 경우 가산으로 보상함

○ (최근 개정 동향) 2024년도 진료보수 개정을 통해 환자가 입원하지 않고도 지역사회에서 지속적으로 의료와 요양 서비스를 받을 수 있는 체계를 강조함(2024 진료보수 개정 개요, 2024)

- (정보연계 강화) ICT 기반의 정보연계, 말기환자 지원, 기관 간 협업을 강조함

• **재택의료정보 연계 가산 100점**
  - (산정요건) 의사가 타 보험의료기관 등이 ICT를 통해 기록한 환자 의료·케어 정보를 활용하여 계획적인 의학관리를 실시한 경우 산정
  - (포함 정보) 다음 방문진료 예정일, 치료방침 변경유무 및 변경 개요, 의료·케어 시의 유의사항(필요 시), 생애말기 의료·케어와 급성악화기 치료방침 등에 대한 환자 의향
• **왕진 시 의료정보연계 가산 200점**
  - (산정요건) 재가요양지원진료소 또는 재가요양지원병원이 연계된 다른 보험의료기관의 계획적인 의학적 관리 하에, 주치의로서 정기적으로 방문진료 중인 환자에게 왕진을 실시하는 경우
• **재택의료 DX정보활용 가산 10점**
  - 건강보험법에 따른 전자자격 확인 등을 통해 얻을 수 있는 정보를 바탕으로 계획적인 의학관리에 따라 방문진료를 실시한 경우 월 1회에 한해 산정

- (중증 말기환자 관리 강화) 자택 임종 지원을 위한 수가를 신설함

• **재가 암환자 응급의료정보연계 지도료 200점**
  - (산정요건) 의사가 30일 이내 재택의료 정보연계가산을 산정한 말기 악성종양 환자의 급성악화기에 기록된 정보를 활용하여 환자 자택에서 요양상 필요한 지도를 실시한 경우 월 1회에 한하여 산정
  - 의사는 환자 이름, 기록 일, 취득 정보 및 실시한 지도의 요점을 기록해야 함
• **재택 말기요양 가산 최대 6,500점**
  - (산정요건) 임종가산(3,000점)과 사망진단 가산(200점) 등과 동시 산정 가능
  - (개정사항) 퇴원 시 공동 지도 실시 후 방문진료 또는 왕진을 실시하는 경우에도 산정할 수 있도록 함
• **간병비 가산 3,000점**
  - (산정요건) 사망 전 14일 이내 환자와 보호자의 충분한 동의와 설명하에 자택에서 간병지도를 실시한 경우

- (방문진료 적정성 평가 세분화) 방문횟수가 많은 기관에 대한 평가를 강화하고 단일 건물 내 환자 수와 임종실적 등에 관한 기준을 세분화함

- (재택의료 기능강화 의료기관 제도화) 병상 유무와 24시간 대응 체계를 갖춘 기능강화형 재택진료기관의 제도적 기반을 강화하고, 해당 기관은 진료보수를 차등함

- (방문간호와 영양지도 확대) 관리영양사의방문영양지도를 인정하고, 방문간호 스테이션 역할을 명확히 하며 정보 활용 가산을 신설함

나. 재택의료 수가 구성

○ 진료수가는 제1장 기본진료료와 제2장 특게(特揭)진료료[6]로 구분되며, 재택의료는 제2부로 특게진료료에 포함됨

○ 재택의료는 ①재택환자진료·지도료, ②재택요양지도관리료, ③약제료, ④특정보험의료재료료를 합산하여 산정하며, 부문별로 구체적인 항목과 조건에 따라 세분화됨

〈표 18〉 일본 의과 진료점수표 구성

구분	내용	
기본진료료	**1) 초진료**(의료기관 종별 구분 없음)	291점
	2) 재진료·외래진료료 - 재진료: 진료소 또는 일반병상 200병상 미만의 병원 - 외래진료료: 200병상 이상 병원	75점 76점
	3) 입원료 - 입원기본료, 입원기본료 등 가산, 특정입원료, 단기체재수술등기본료	
특게진료료	**1) 의학관리등**: ① 의학관리료등 ② 프로그램의료기기등의학관리가산 ③ 특정보험의료재료료	
	2) 재택의료 ① 재택환자진료·지도료 ③ 재택요양지도관리료(재택요양지도관리료, 재택요양지도관리재료가산) ④ 약제료 ⑤ 특정보험의료재료료	
	3) 검사 ① 검체검사료(검체검사실시료, 검체검사판단료) ② 삭제 ③ 생체검사료 ④ 진단穿刺·검체채취료 ⑤ 약제료 ⑥ 특정보험의료재료료	
	4) 화상진단 ① X선 진단료 ② 핵의학진단료 ③ 컴퓨터 단층촬영진단료 ④ 약제료 ⑤ 특정보험의료재료료	
	5) 투약 ① 조제료 ② 처방료 ③ 약제료 ④ 특정보험의료재료료 ⑤ 처방전료 ⑥ 조제기술기본료	
	6) 주사: ① 주사료(주사실시료, 무균제제처리료) ② 약제료 ③ 특정보험의료재료료	
	7) 재활(Rehabilitation): ① 재활(Rehabilitation)료 ② 약제료	
	8) 정신과전문요법: ① 정신과전문요법료 ② 약제료	
	9) 처치: ① 처치료 ② 처치의료기기등가산 ③ 약제료 ④ 특정보험의료재료료	
	10) 수술: ① 수술료 ② 수혈료 ③ 수술의료기기등가산 ④ 약제료 ⑤ 특정보험의료재료료	
	11) 마취: ① 마취료 ② 신경차단료 ③ 약제료 ④ 특정보험의료재료료	
	12) 방사선치료: ① 방사선치료관리·실시료 ② 특정보험의료재료료	
	13) 병리진단: ① 병리표본작제료 ② 병리진단·판단료	
	14) 기타: ① 간호직원처우개선평가료 ②베이스업평가료	

* 자료: 후생노동성. 2024년 진료보수점수표.
최경환, 일본 농촌지역의 재택의료 실태와 시사점. 한국농촌경제연구원. 2023.

6) 특게(特揭): 증상이나 처치법에 따라 그 대응이 크게 달라 기본 진료료의 포괄개념에 포함되지 않는 것으로서 개개의 행위에 대해 평가 산정하는 것을 말함

- (재택환자진료·지도료) 의사, 간호사, 약사, 영양사 등이 환자 자택에 직접 방문하여 진료, 간호, 재활, 상담 등을 수행한 행위에 대한 보상
- (재택요양지도관리료) 산소요법, 인공호흡, 인슐린 자가주사, 복막투석 등 특수 치료 및 장비 사용 환자를 위한 전문적 관리 지도에 대한 보상
- (약제료, 특정보험의료재료료) 재택 의료에 사용된 약제 및 특정 의료재료, 카테터, 영양관 등의 제공에 대한 보상

1) 재가환자진료·지도료

○ 재택환자진료·지도료는 방문의료에 관한 내용으로 '왕진료(C000)' 및 '재택환자 방문진료료(C000-1,2)'와 '의학종합관리료(C002, C003)', 방문진료 관련 지도·지시료(C004-C015)가 있음

- 환자 또는 보호자의 요청으로 비계획적·비정기적으로 방문은 '왕진'이며, 의사의 계획적인 의학적 관리 하에 정기적으로 환자에게 방문하면 '방문진료'로 구분함
- 왕진과 방문진료는 재택의료 제공 의료기관의 특성과 환자 상태, 방문횟수와 방법, 인원 수 등에 따라 세분화 됨(강주현 외, 2023)

가) 왕진료·방문진료료

○ (왕진료) 720점을 기본으로 하며, 이는 초진료(A000) 291점의 약 2.5배임. 환자 또는 가족 등의 직접 요청에 의해 비정기적으로 이루어지는 진료로 외래 진료 후, 귀가 후 증상이 악화되어 오후에 요청한 경우 외래진료료와 왕진료 동시 산정 가능함. 방문 시 추가 제공한 투약 및 주사, 의료적 처치, 검사 등에 대한 수가는 행위별 수가로 인정함

- (가산) 긴급, 야간·휴일, 심야 가산, 초과진료시간 가산, 재택 임종케어, 간호가산, 사망진단 등 8개의 가산 항목이 있음. 진료시간 가산과 재택 임종케어는 진료소 유형과 병상 유무 등 세부 기준에 따라 가산 규모가 달라짐

〈표 19〉 일본 건강보험 왕진료 및 가산항목

(단위: 1점 = 10엔 ≒ 100원)

항목	내용				점수 (점)
왕진료(C000)	• 환자 또는 그 가족 등으로부터의 직접적인 요구로 왕진한 경우 • 외래 초진·재진료 동시 산정 가능				720
(1) 진료시간 가산	기준		긴급 (8~13시)	야간·휴일 (18~8시)	심야 (22~6시)
	① 재택요양지원진료소·병원	병상 有	850	1,700	2,700
		병상 無	750	1,500	2,500
	② ① 외의 기관		650	1,300	2,300
	③ ①·② 외의 기관		325	650	1,300
	재택완화케어충실진료소·병원가산				100
	재가요양실적가산1				75
	재가요양실적가산2				50
(2) 초과시간 가산	진료시간 1시간 초과 시 30분마다 기본료에 가산				3,000
(3) 재택 임종케어 가산	① 재택요양지원진료소·병원	병상 有			6,500
		병상 無			5,500
	② 재택요양지원진료소·병원 이외의 시설[2]				4,500
	③ ①·② 외의 시설[3]				3,500
	재택완화케어충실진료소·병원가산				1,000
	재가요양실적가산1				750
	재가요양실적가산2				500
	암환자산소요법가산				2,000
(4) 간호 가산	왕진하고 재택에서 환자를 간호한 경우				3,000
(5) 사망진단 가산	환자 자택에서 사망진단을 실시한 경우				200
(6) 이동 거리	• 보험의료기관에서 환자자택까지의 거리가 편도 16km를 초과한 경우 또는 해로를 이용해서 왕진한 경우, 그 외 특수한 사정이 있었을 때의 왕진료는 별도로 후생노동대신이 정하는 바에 따라 산정함 • 그 외 왕진에 소요된 교통비는 환자자택에서 부담함				
(7) 왕진 시 의료정보 연계가산	재가요양지원진료소·병원이 연계된 다른 보험의료기관에 의해 계획적인 의학적 관리 하에, 주치의로서 정기적으로 방문진료 중인 환자에게 왕진을 실시하는 경우				200
(8) 개호보험 시설 등 연계 왕진가산	별도의 기준을 충족한 보험의료기관이 개호보험시설 등의 협력의료기관에 입소한 환자의 병세가 급변하여 왕진한 경우				200

* 자료: 후생노동성 고시 제 57호, 의료비 산정방법 일부 개정 안내. 2024

○ (방문진료료) 재택환자 방문진료료는 환자 자택(Ⅰ), 시설입소(Ⅱ)여부로, 자택인 경우 타기관 요청여부에 따라 1과 2로 구분됨

- 방문진료는 환자와 사전에 협의된 정기적·계획적 방문으로, 동일일 외래 진료와 동시에 산정할 수 없으며, 왕진일의 다음날 실시한 방문진료 비용도 인정하지 않음[7)]
- (재택환자 방문진료료Ⅰ-1) 통원이 어려워 자택 요양 중인 환자 동의하에 의사가 계획적인 의학적 관리를 하면서 정기적 방문진료 경우
  - 환자 1인당 주 3회까지 산정 가능하나 급성 악화 등으로 자주 방문이 필요하다고 판단할 경우, 월 1회에 한하여 해당 진료일로부터 14일 한도로 추가 가능
- (재택환자 방문진료료Ⅰ-2) 특정 요건[8)]을 충족하는 보험의료기관에서 환자를 볼 수 있는 진료과나 전문의가 없는 경우 등을 이유로 소개받은 환자의 동의를 받고 계획적 의학적 관리에 따라 정기적으로 방문진료한 경우 산정함
  - 환자 1인당 월 1회 6개월까지 산정 가능. 특정질환을 가진 환자에게 제공하는 보완적·전문적 성격의 방문진료료로, 기간이 6개월로 제한됨
- (재택환자 방문진료료Ⅱ) 유료 노인홈 등에 병설 보험의료기관이 입주 환자를 계획적인 의학적 관리에 따라 정기적으로 방문진료한 경우 산정함
- (가산) 6세 미만의 유아, 재택 임종케어, 진료시간 초과, 간호, 사망진단 등 크게 7가지 가산항목을 인정함
  - 왕진료는 긴급, 야간, 휴일, 심야에 대한 가산을 인정하나 방문진료료는 진료시간에 대한 별도 가산항목이 없음. 영유아 가산은 방문진료료에서만 인정됨
- (감산) 의학적으로 불가피한 사유로 동일 환자에게 같은 날 방문 시 두 번째 방문 이후 50% 감산, 명확한 사유 없이 동일 환자가 같은 날 2개 이상의 의료기관 방문진료를 받은 경우 두 번째 의료기관부터 50% 감산 등

7) 재가요양지원진료소·병원의 보험의사가 실시한 경우는 제외
8) C002 재택시의학종합관리료, C002-2에서 언급하는 시설입소시등 의학종합관리료, C003에서 언급하는 재가암의료종합진료료 산정요건을 충족하는 보험의료기관

〈표 20〉 일본 건강보험 재택환자 방문진료료 및 가감산 항목

(단위: 1점 = 10엔 ≒ 100원)

항목	내용		점수 (점)
재택환자 방문진료료 I (C001)	• 재택환자 방문진료료 I -1(일당) - 방문계획에 따라 정기적으로 방문진료를 실시한 경우 - 환자 1인당 주3회까지 산정가능		(동일건물 외) 888 (동일건물) 213
	• 재택환자 방문진료료 I -2(일당) - 다른 기관에서 소개받은 환자에게 계획적·정기적으로 방문진료를 실시한 경우 - 환자 1인당 6개월 한도로 월1회 산정가능		(동일건물 외) 884 (동일건물) 187
재택환자 방문진료료 II (C001-2)	• 재택환자 방문진료료 II(1일당) - '요료 노인홈 등'에 소속된 보험의료기관이 해당 시설 입주 환자에게 방문진료를 실시한 경우 - 환자 1인당 주 3회까지 산정가능. 타 기관 소개 시 환자 1인당 6개월 한도로 월 1회 산정가능		150
(1) 영유아 가산	6세 미만의 영유아에 대해 방문진료를 한 경우		400
(2) 초과진료시간 가산	진료시간 1시간 초과 시 30분마다 기본료에 가산		3,000
(3) 재택임종케어 가산	① 재택요양지원진료소·병원	병상 有	(방문진료료 I) 6,500 (방문진료료 II) 6,200
		病床 無	(방문진료료 I) 5,500 (방문진료료 II) 5,200
	② 재택요양지원진료소·병원 이외의 시설[2]		(방문진료료 I) 4,500 (방문진료료 II) 5,200
	③ ①·② 외의 시설[3]		(방문진료료 I) 3,500 (방문진료료 II) 3,200
	재택완화케어충실진료소·병원가산		1,000
	재가요양실적가산1		750
	재가요양실적가산2		500
	암환자산소요법가산		2,000
(4) 간호가산	왕진 또는 방문진료 후 재택에서 환자를 간호한 경우 * 재택환자 방문진료료(I -1, II)에 한함		3,000
(5) 사망진단가산	환자 자택에서 사망진단을 실시한 경우 * 간호가산과 동시산정 불가		200
(6) 재택의료DX정보활용가산	전자자격확인 등을 통해 얻을 수 있는 정보를 바탕으로 계획적인 의학관리 하에 방문진료를 한 경우		10
(7) 거리	• 보험의료기관에서 환자자택까지의 거리가 편도 16km를 초과한 경우 또는 해로를 이용해서 왕진한 경우, 그 외 특수한 사정이 있었을 때의 교통비는 별도로 후생노동대신이 정하는 바에 따라 산정함 • 그 외 방문진료에 소요된 교통비는 환자자택에서 부담함 * 재택환자 방문진료료(I)에 한함		
(8) 방문진료료 감산	• 재택환자 방문진료료 I -1에 대하여 재가요양지원진료소·병원이 별도로 후생노동대신이 정하는 기준에 적합하지 않게 된 경우 • 해당 기준에 적합하지 않게 된 후의 최근 1개월에 한하여, 동일 환자에 대하여 동일 월에 방문진료를 5회 이상 실시한 경우, 5회차 이후의 방문진료에 대해서는 소정점수의 50% 감산		

* 자료: 후생노동성 고시 제 57호, 의료비 산정방법 일부 개정 안내. 2024

나) 의학종합관리료

○ 의학적종합관리료는 환자의 전반적인 건강상태를 장기적으로 관리하는 경우 적용함. 질병의 악화를 방지하거나 입원율을 낮추기 위해 지속적이고 계획적인 관리가 필요한 환자를 대상으로 함

- 의사는 방문 시 환자의 건강상태를 확인하고 생활습관, 재활상태 등을 조언하며, 방문간호, 약사, 케어매니저 등과 연계함. 환자별로 작성한 종합적 재택의료 계획을 환자 및 가족, 간호사에게 설명하며, 핵심내용을 진료기록으로 기록함
- (감산) 진료비용과 투약비용은 점수에 포함하며, 재택의료 지원 진료소·병원으로 신고되지 않은 일반 병·의원에서 산정하는 경우 점수의 20%를 감산하며, 특정 진료항목에서 정해진 시설·ICT 요건을 충족하지 못할때는 40%를 감산함

〈표 21〉 일본 건강보험 의학종합관리료 세부기준

구분	재택 시 의학종합관리료 (C002)	시설 입주시 등 의학종합관리료 (C002-2)	재택 암 의료종합진료료 (C003)
대상 환자	통원이 어려운 자택에서 요양중인 환자	통원이 어려운 특정시설 (유료노인홈, 개호노인보건시설 등) 입주 환자	자택에서 요양중인 말기악성종양 환자
산정 기준	• (방문빈도) 월 1회, 월 2회 이상으로 구분 • (단일건물 진료환자 수) 같은 건물내 환자 수에 따라 점수 구분. 환자 수가 많아질수록 점수가 낮아짐 ① 1명 ② 2명~9명 ③ 10명~19명 ④ 20명~49명 ⑤ 그 외		• 1일 1회, 주 단위로 산정 • 시설기준, 병상유무와 처방전 교부 여부로 구분
	• (시설기준) 재택요양지원진료소·병원 지정 기관은 더 높은 점수 적용		

* 자료: 후생노동성 고시 제 57호, 의료비 산정방법 일부 개정 안내
후지재택진료소, 재택시의학종합관리료란-방문진료의 비용과 구조(2025.6.18.)

○ 환자의 자택 또는 시설에서 의학적 종합관리를 실시한 경우 월 1회 '재택 시 의학종합관리료' 또는 '시설 입소 시 의학종합관리료'를, 말기 악성종양 환자는 '재택암 의료종합진료료'를 산정함

- 재택 시 의학종합관리료는 재택환자를 시설 입소 시, 의학종합관리료는 유료노인홈, 치매 대응형 공동생활 개호사업소 등의 시설에 거주하는 환자를 대상으로 하며, 재택·시설 입주 시 종합관리료는 조기 재택이행, 빈번방문, 재택 데이터제출, 재택의료 정보연계 가산 등이 적용됨
- 방문 횟수를 1회와 2회 이상 등으로 구분하여 방문 횟수가 많으면 보상규모가 큼

- 후생노동성이 별도로 정하는 중증환자[9]도 보상수준을 달리함. 세부 내용은 다음과 같음
  - (특정질환) 말기 악성 종양 환자, SMON(스몬병) 등 특정 희귀질환 환자, 법률상 지정 난치병 환자
  - (특정 의료적 상태) 재택 자가 복막투석을 시행 중인 환자, 재택 혈액투석 환자, 재택 산소요법을 받고 있는 환자, 재택 중심정맥영양(TPN)을 시행 중인 환자, 재택 경관영양(성분영양)을 받고 있는 환자, 자가 도뇨를 시행해야 하는 환자, 재택 인공호흡기 사용 환자, 재택 지속적 양압호흡요법(CPAP 등)을 받는 환자, 인공항문 또는 인공방광 설치 환자, 진피를 넘어서는 욕창(심한 욕창)을 가진 환자, 드레인 튜브나 유치 카테터를 장착하고 있는 환자, 통증 관리(약물 주입 포함)가 필요한 환자, 폐고혈압으로 프로스타글란딘 제제를 투여 중인 환자
  - (기타 의료적 처치상태) 방문진료나 방문간호 시 주사, 흡인, 경관영양 등 지속적인 처치가 필요한 환자, 하루에 여러 차례, 또는 장시간 방문 간호가 필요한 환자, 여러 사업소(방문간호 스테이션 등)를 병용해야 하는 환자
- (재택 암 의료종합관리료) 재택에서 요양 중인 말기 악성종양 환자에게 종합적인 의료를 제공한 경우, 1일 1회 주 단위로 산정함. 처방전 발행 여부·기관 기준 충족 여부에 따라 점수가 달라지고, 사망진단, 소아, 재택데이터제출, 재택의료 DX정보활용 등의 가산항목이 적용됨

○ (정보통신기기(ICT)를 활용한 진료) 정보통신기기를 활용한 진료는 화상 기반의 실시간 진료를 의미하며, 반드시 대면진료를 원칙으로 하여 보완적인 역할로만 활용해야함. 월 2회 이상 방문진료 시 2회에 1회 인정, 월 1회 진료 시 2개월에 1회에 한해 ICT 진료로 대체할 수 있음

9) 후생노동성. 진료보수점수표 별표 제8의2. 2024.4.

〈표 22〉 일본 건강보험 의학종합관리료 수가 및 가산항목

(단위: 1점 = 10엔 ≒ 100원)

항목	내용	점수
재택 시 의학종합관리료 (C002)[1]	재택에서 요양 중인 환자에게 종합적인 의학관리를 실시한 경우. 방문횟수 및 단일건물 진료환자 수[2]에 따라 월 1회 산정	(중증환자) 1,315~5,385 (일반환자) 395~4,485 (ICT진료) 275~3,014
시설 입주 시 종합관리료 (C002-2)[1]	시설에 있는 통원이 곤란한 환자에 대해 종합적인 의료관리를 실시한 경우. 방문횟수 및 단일건물 진료환자 수에 따라 월 1회 산정	(중증환자) 1,315~3,885 (일반환자) 395~3,185 (ICT진료) 225~2,234
(1) 처방전 미발행 가산	처방전을 교부하지 않는 경우 적용. 환자가 약 처방 없이 관리만 받을 때의 보상	300
(2) 재택이행 초기가산	입원→재택 전환 후 3개월 이내 환자에 대해 월 1회 한해 가산. 단, 퇴원 후 1년 초과 환자에게는 적용 불가	100
(3) 재택요양 이행가산	입원 후 외래를 거쳐 재택으로 이행한 환자 관리 시, 기관의 24시간 대응체계, 방문간호 연계 여부 등 요건에 따라 점수 부여	
	재가요양 이행가산 1	316
	재가요양 이행가산 2	216
	재가요양 이행가산 3	216
	재가요양 이행가산 4	116
(4) 빈번 방문 가산	특별 관리 필요 환자에게 월 4회 이상의 왕진 또는 방문진료 시 적용, 환자 1명당 1회에 한해 산정가능	(최초) 800 (2회차 이후) 300
(5) 시설가산[2]	재택완화케어충실진료소·병원가산	75~400
	재가요양실적가산1	56~300
	재가요양실적가산2	38~200
(6) 포괄적 지원가산	고도관리 필요 환자에 대해 추가 지원 시 가산.	150
(7) 재택데이터제출가산	보험의료기관의 진료보수 청구상황, 진료내용에 관한 데이터를 지속적으로 후생노동성에 제출 시 월 1회 산정	50
(8) 재택의료정보연계가산	ICT를 활용해 타 기관·직종과 진료정보를 공유하고 연계 진료 시 적용. 정보 공유·기록 요건 필요.	100
재택 암 의료종합진료료 (C003)	재택 요양 말기 악성종양 환자에게 종합적 의학관리 시 주 단위로 청구. 시설, 병상기준과 처방전 교부로 구분	(처방전 교부) 1,493~1,798 (처방전 미교부) 1,685~2,000
(1) 사망진단가산	환자 자택에서 사망진단을 실시한 경우	200
(2) 소아가산	15세 미만의 소아를 대상으로 종합적인 의료를 제공한 경우, 주 1회 산정	1,000
(3) 시설가산[2]	재택완화케어충실진료소·병원가산	150
	재가요양실적가산1	110
	재가요양실적가산2	75
(4) 재택데이터제출가산	보험의료기관의 진료보수 청구상황, 진료내용에 관한 데이터를 지속적으로 후생노동성에 제출 시 월 1회 산정	50
(5) 재택의료DX정보활용가산	전자자격 확인 정보를 활용해 계획적 관리·방문진료	10
(6) 재택의료정보연계가산	환자 진료 관련 정보를 ICT로 공유·활용하며 관리한 경우, 월 1회 산정	100

* 주 1) 시설기준, 병상 유무, 단일건물 진료환자 수, 방문횟수, 정보통신기기 사용 여부에 따라 세분화됨
2) 단일건물 진료환자 수 ① 1명 ② 2명~9명 ③ 10명~19명 ④ 20명~49명 ⑤ 그 외 로 구분
3) 재택 시 의학종합관리료(C002)와 시설입주 종합관리료(C002-2)는 중복 산정 불가
* 자료: 후생노동성 고시 제57호. 진료보수 산정방법 일부 개정: 별표 제1 의과 진료보수 점수표. 후생노동성. 2024.

○ 방문진료에 대한 지도·지시료는 의사 외 의료인력의 서비스와 다직종 협력 보상임. 구급 이송·진료료, 방문간호 관련 지도·지시료, 재활·약물·영양 관리에 대한 지시·지도료, 특수관리 및 응급상황 대응, 연계 및 협력에 대한 지도료가 있음

- (구급 이송·진료료) 구급이송진료료(C004), 구급환자연계이송료(C004-2)로, 구급차로 의료기관 이송 시 의료진이 동승하여 진료를 제공하는 경우나 응급외래 진료 후 다른 의료기관으로의 연계 이송 시 적용함. 두 수가는 동시에 산정 불가함
- (방문간호 관련 지도·지시료) 재택환자방문간호·지도료(C005), 방문간호지시료(C007)로, 재택요양환자에게 방문간호를 제공하는 경우와 의사가 방문간호의 필요성을 인정하고 지시서를 교부한 경우 산정함
- (재활·약물·영양 관리에 대한 지시·지도료) 재택환자 방문재활지도관리료(C006)는 통원이 곤란한 환자에게 의사 지시 하에 이학요법사, 작업치료사, 언어청각사가 방문하여 재활치료를 제공하는 경우, 재택환자 방문약제관리지도료(C008)는 약사가 환자의 재택에 방문하여 약학적 지도를 한 경우, 재택환자 방문영양식사지도료(C009)는 관리영양사가 방문하여 영양관리 지도를 제공하는 경우 산정함
- (특수관리 지도·지시료) 개호직원등 객담흡인등지시료(C007-2), 재택환자 방문욕창관리지도료(C013)로, 의사가 개호 직원의 객담 흡인 등의 필요성을 인정하고 지시서를 교부한 경우와 의사, 관리영양사, 간호사가 공동으로 욕창관리에 대한 계획적 지도를 제공하는 경우 산정함
- (연계 및 협력 지도료) 재택환자연계지도료(C010), 재택환자긴급시등 콘퍼런스료(C011), 재택환자공동진료료(C012), 외래재택공동지도료(C014), 재택암환자 긴급시 의료정보 연계지도료(C015)로 의사를 포함하여 타 의료기관, 의료진과 함께 협력하여 진료를 제공함

〈표 23〉 일본 건강보험 방문진료 관련 지도·지시료 내용 및 점수

(단위: 1점 = 10엔 ≒ 100원)

항목	내용	점수 (점)
구급이송진료료 (C004)	환자를 구급차 등으로 이송 시, 의사가 동승하여 진료한 경우	1,300
구급환자연계이송료 (C004-2)	• 응급외래 환자를 다른 병원으로 연계 이송 시 산정 (의사·간호사·구급구명사 동승 필요) - C004와 동시에 산정 불가	600~1,800
재택환자방문간호·지도료 (1일당) (C005)	• 통원이 곤란한 재택 요양 환자에게 간호사 등이 방문하여 간호 또는 요양에 필요한 지도를 한 경우 • 환자의 상태, 방문시간, 횟수 등에 따라 점수 세분화 - (준간호사) 530~630 - (보건사·조산사·간호사) 580~680 - (전문 교육 이수 간호사*) 1,285 * 악성종양 환자에 대한 완화케어, 욕창케어 또는 인공항문케어 및 인공방광케어에 관한 전문연수를 받은 간호사	530~1,285
동일건물거주자 방문간호·지도료(1일당) (C005-1-2)	동일 건물 내 복수 환자 대상 간호·지도 - (준간호사) 268~630 - (보건사·조산사·간호사) 293~680 - (전문 교육 이수 간호사*) 1,285	268~1,285
재택환자 방문점적주사관리지도료(1주당) (C005-2)	재택에서 주 3일 이상 점적 주사가 필요한 환자에게 간호사 또는 준간호사에게 필요한 관리 지도를 한 경우, 주 1회에 한해 산정	100
재택환자 방문재활지도관리료(1단위) (C006)	통원이 곤란한 재택 요양 환자에게 의사의 지시를 받은 이학요법사, 작업치료사, 언어 청각사 등이 방문하여 재활 치료를 한 경우	(동일건물 외) 300 (동일건물) 255
방문간호지시료 (C007)	의사가 진료에 따라 방문 간호의 필요성을 인정하고, 환자 동의를 얻어 방문 간호 지시서를 교부한 경우, 월 1회에 한해 산정	300
개호직원등객담흡인등지시료 (C007-2)	의사가 진료에 따라 개호 직원 등의 객담 흡인 등 필요성을 인정하고, 지시서를 교부한 경우, 3개월에 1회에 한해 산정	240
재택환자 방문약제관리지도료 (C008)	• 통원이 곤란한 재택 요양 환자에게 약사가 방문하여 약학적 관리 지도를 한 경우 산정 • 단일건물 내 진료환자 수에 따라 환자 1명당 월 4회 한정. 약사 한 명당 주 40회에 한하여 산정 가능함 * 말기 암 환자 및 중심 정맥 영양법 대상 환자는 주 2회, 월 8회까지)	290~650
재택환자 방문영양식사지도료 (C009)	통원이 곤란한 재택 요양 환자에게 관리영양사가 방문하여 영양 관리 지도를 한 경우, 월 2회에 한해 산정	420~530
재택환자연계지도료 (C010)	재택에서 요양하는 통원이 곤란한 환자에게 의사가 치과, 약국, 방문간호 스테이션 등과 정보 공유 후 요양에 필요한 지도를 한 경우, 월 1회에 한해 산정	900

(단위: 1점 = 10엔 ≒ 100원)

항목	내용	점수 (점)
재택환자긴급시등 콘퍼런스료 (C011)	방문의사가 환자의 상태 급변 등에 따라, 치과의사, 약제사, 보건사, 간호사 등 방문진료인력과 함께 콘퍼런스를 실시 또는 참가하여 요양상 필요한 지도를 실시한 경우, 월 2회에 한하여 산정	200
재택환자공동진료료 (C012)	• 재택요양후방지원병원*이 통원이 곤란한 재택 요양 환자에게 다른 재택 의료기관의 요청에 따라 공동으로 왕진 또는 방문진료를 한 경우 * 재택으로 요양을 실시한 환자를 긴급 시에 수용하는 병원이며, 별도로 후생노동대신이 정하는 시설기준에 적합한 것으로 지방후생국장 등에 신청한 자를 말함. 허가병상수가 400개 미만인 병원에 한함 • 산정일로부터 1년 이내 총 2회 한정(특정 질환은 총 12회까지)	(왕진) 1,500 (방문진료) 240~1,000
재택환자 방문욕창관리지도료 (C013)	• 욕창관리가 필요한 재택요양환자에게 의사, 관리영양사, 간호사 등이 공동으로 욕창 관리에 대한 계획적인 지도 관리를 한 경우 • 최초 컨퍼런스일로부터 6개월 이내 총 3회 한정 * 재택환자 방문진료료, 방문간호·지도료, 방문영양식사 지도료와 중복 산정 불가(컨퍼런스 시 제외)	750
외래재택공동지도료 (C014)	• 환자의 재택 요양을 담당하는 의료기관의 의사와 외래 진료를 담당하는 의사가 협력하여 재택 요양에 필요한 설명 및 지도를 제공 시 산정, 환자 1인당 1회에 한함 • 외래재택공동지도료1은 재택 요양을 담당하는 의료기관이, 외래재택공동지도료2는 외래 진료를 담당하는 의료기관이 산정 – 외래재택공동지도료2는 초진료, 재진료, 외래 진료료, 왕진료, 재택환자 방문진료료와 중복 산정 불가	(외래재택 공동지도료1) 400 (외래재택 공동지도료2) 600
재택암환자 긴급시의료정보연계지도료 (C015)	말기 암 환자의 병상 급변 시 의사가 다른 의료기관 등과 연계하여 환자 관련 최후 단계 의료·케어 정보 등을 취득한 후 요양에 필요한 지도를 한 경우, 월 1회에 한해 산정	200

* 자료: 후생노동성 고시 제 57호, 의료비 산정방법 일부 개정 안내. 2024

2) 재택요양지도관리료

○ 병세가 안정된 환자에게 자택에서 특정한 의료행위를 지속적으로 수행할 필요가 있는 경우 재택요양 지도관리료 산정 대상이 됨(Noda M., 2017)[10]

○ 인공호흡기, 중심정맥영양 등 고난도·특수의료기기를 사용하는 재택환자에게 전문적 사용법 지도와 지속적인 관리를 제공하는 항목임. 환자와 보호자에게 기기 사용법, 합병증 예방, 위생관리, 응급상황 대응 등을 교육하고, 정기적인 상태평가 등을 실시함

○ 재택요양지도관리료는 기본 관리료와 재료·기기 가산으로 구성됨. 기기 설치·사용법

10) 야전. 재택의료 진료보수 및 개호보험(발표자료). 히가시 나고야 의료센터. 2017.3.25.

교육, 이상 대응 지도, 소모품 관리, 감염예방 지도, 주기적 모니터링 등을 제공해야 하며, 초기 적응 단계는 대면을 원칙으로 하고 안정기에는 비대면 제공이 가능함

〈표 24〉 일본 건강보험 재택요양지도 관리료 목록

Ⅱ-1. 재택요양지도관리료		Ⅱ-2. 재택요양지도관리재료 가산	
C100	퇴원 전 재택요양지도관리료	C150	혈당자기측정기가산
C101-2	재택소아저혈당증환자 지도관리료	C151	주입기가산
C101-3	재택임신당뇨병환자 지도관리료	C152	간헐 주입 시린지 펌프 가산
C101	재택자기주사 지도관리료	C152-2	지속혈당측정기가산
C102	재택자기복막관류 지도관리료	C152-3	경장투약용 펌프가산
C102-2	재택혈액투석 지도관리료	C152-4	지속피하주입시린지 펌프 가산
C103	재택산소요법 지도관리료	C153	주입기용 주사침가산
C104	재택중심정맥영양법 지도관리료	C154	자외선살균기기가산
C105	재택성분영양경관영양법 지도관리료	C155	자동복막관류장치가산
C105-2	재택소아경관영양법 지도관리료	C156	투석액공급장치가산
C105-3	재택반고형영양경관영양법 지도관리료	C157	산소봄베가산
C106	재택자기도뇨 지도관리료	C158	산소농축장치가산
C107	재택인공호흡 지도관리료	C159	액화산소장치가산
C107-2	재택지속양압호흡요법 지도관리료	C159-2	호흡동조식 디맨드 밸브가산
C107-3	재택하이플로우 테라피 지도관리료	C160	재택중심정맥영양법용 수액세트가산
C108	재택마약 등 주사 지도관리료	C161	주입펌프가산
C108-2	재택종양화학요법주사 지도관리료	C162	재택경관영양법용 영양관세트가산
C108-3	재택강심제지속투여 지도관리료	C163	특수카테터가산
C108-4	재택악성종양환자공동 지도관리료	C164	인공호흡기가산
C109	재택 거동불편환자처치 지도관리료	C165	재택지속양압호흡요법용 치료기가산
C110	재택자기동통관리 지도관리료	C166	휴대형일회용주입펌프가산
C110-2	재택진전 등 자극장치치료 지도관리료	C167	동통 등 관리용 송신기가산
C110-3	재택미주신경전기자극치료 지도관리료	C168	휴대형 정밀수액펌프가산
C110-4	재택천골신경자극요법 지도관리료	C168-2	휴대형 정밀네블라이저가산
C110-5	재택설하신경 전기자극요법 지도관리료	C169	기관절개환자용 인공 코 가산
C111	재택폐고압증증환자 지도관리료	C170	배담보조장치가산
C112	재택기관절개환자 지도관리료	C171-2	재택지속양압호흡요법재료가산
C112-2	재택후두적출환자 지도관리료	C171-3	재택하이플로우 테라피재료가산
C113	삭제	C171	재택산소요법재료가산
C114	재택난치성피부질환처치 지도관리료	C172	재택 법과 관련된 자기세장용 재료가산
C115	삭제	C173	횡격신경전기자극장치가산
C116	재택체내삽입형 보조인공심장(비박동) 지도관리료	C174	재택하이플로우 테라피 장치가산
C117	재택경장투약 지도관리료	C175	재택항균약흡입요법용네블라이저가산
C118	재택종양치료전장요법 지도관리료		
C119	재택경항문적 자기세장 지도관리료	-	-
C120	재택중이가압요법 지도관리료		
C121	재택항균약흡입요법 지도관리료		

* 자료: 후생노동성 고시 제 57호, 의료비 산정방법 일부 개정 안내. 2021.3.31.

다. 비대면 모니터링

○ 입원상태가 아닌 환자에게 전화 등의 정보통신기기를 이용한 의학관리나 원격 모니터링에 대한 수가는 환자환자 상병이나 상태에 따라 재택의료에 포함되기도 하며 일반 의학관리료로 독립적으로 제공되기도 함

- 정보통신기기를 활용한 의학관리의 경우 동일 조건의 대면수가에서 감산한 대체 점수를 산정하며, 원격모니터링의 경우 추가 의료행위로 가산하여 보상함
- 원격모니터링은 대면진료 사이의 공백을 보완하기 위한 역할로 기기가 측정한 데이터를 원격으로 확인하고 관리하는 행위를 의미함. 인공심장박동기, 자동복막투석, 산소요법, CPAP와 같이 특정 기기 치료환자를 대상으로 원격 모니터링 가산을 인정하고 있음

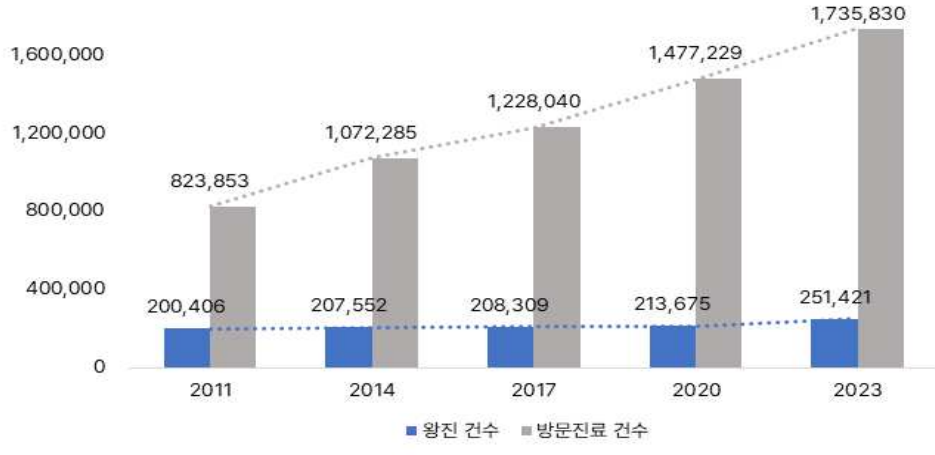
〈표 25〉 일본 건강보험 비대면 모니터링

구분 (코드)		서비스 내용	대상질환	보상방법
의학 관리료	특정질환치료 관리료 (B001)	정보통신기기를 활용한 의학관리	소아과 요양, 뇌전증, 난치병, 피부과질환, 영양관리, 소아 악성종양, 암성통증완화(마약성 진통제 사용), 암환자, 완화의료, 장기 및 조혈모세포 이식, 투석위험이 높은 당뇨병, 신장대체요법, 만성신장병 투석	대면수가 감산
		원격 모니터링	인공심장박동기	(Pacemaker) 260점 (ICD/CRT 등) 480점 11개월 한도로 가산
재택의료	재택자기주사 지도관리료(C101)	정보통신기기를 활용한 지도관리	주사약으로 자가주사 실시 비입원 환자	대면수가 감산
	재택자기복막관류 지도관리료(C102)	원격모니터링	자동복막투석 및 재택혈액투석 환자	+115점 (월 1회 한도)
	재택산소요법 지도관리료(C103)		재택산소요법 환자	+150점 (대면 이후 2개월 한도)
	재택인공호흡 지도관리료(C107)	정보통신기기를 활용한 지도관리	재택지속양압호흡요법 환자	대면수가 감산
		원격모니터링		+150점 (대면 이후 2개월 한도)

* 자료: 후생노동성 고시 제 57호, 의료비 산정방법 일부 개정 안내. 2024

라. 재택의료 현황

○ (재택의료 건수) 왕진은 매년 유사한 수준을 유지하며, 방문진료는 지속적으로 증가함



[그림 10] 일본 왕진, 방문진료 건수 추이

* 주: 연도별 수치는 병원과 일반진료소의 총합계
* 자료: 후생노동성. 의료시설조사. 2011, 2014, 2017, 2020, 2023.

○ (재택의료 환자 수) 방문진료 환자 수는 2008년 5만 7천 명에서 2023년 16만 6천 명으로 연평균 약 7.3% 증가함. 의사, 치과의사 외의 방문서비스도 꾸준히 증가함



[그림 11] 일본 재택의료 환자 수 연간 추이

* 주: 의사, 치과의사 외의 방문은 의사, 치과의사 이외의 진료진이 재택의료를 받는 환자를 대상으로 정기적으로 방문하여 계획된 의료관리를 실시하는 것을 의미함
* 자료: 후생노동성. 환자조사. 2023.

○ (연령별 이용 현황) 재택의료 이용 환자 수는 2011년 약 11만 명에서 2023년 약 24만 명으로 2배 이상 증가함. 65세 이상이 차지하는 비율은 2011년 85%에서 2023년 92%로 증가하여 방문진료 환자의 약 90%는 65세 이상 고령자임

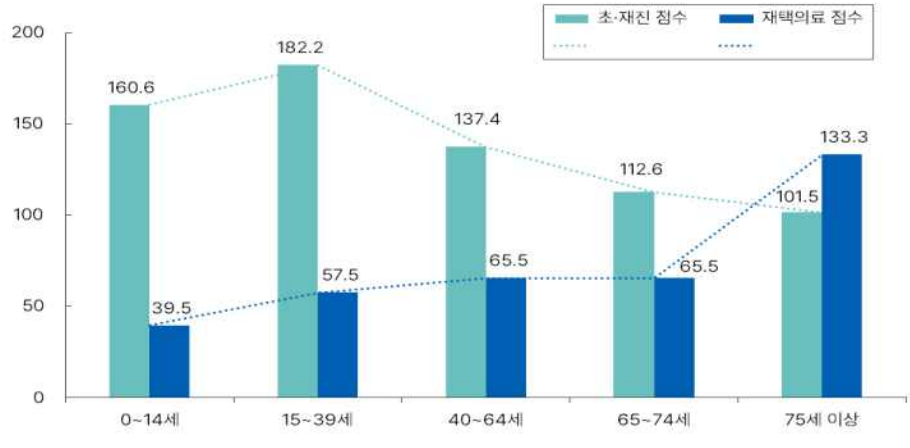
○ 초·재진 점수는 15~39세에서 가장 높으며, 재택의료 수가는 연령이 증가할수록 높아져 75세 이상에서는 65세~74세 대비 2배 이상 점수가 높음

〈표 26〉 일본 연령별 재택의료 이용 현황

(단위: 천 명)

연도	2011	2014	2017	2020	2023
0–14세	1.0	0.4	0.3	0.4	0.9
15–34세	2.5	3.3	1.8	1.8	3.3
35–64세	13.2	15.3	11.3	11.2	14.5
65세 이상	93.7	137.1	166	159.6	220
합계	110.7	156.4	180.1	173.6	239

* 자료: 후생노동성. 의료시설조사. 2011, 2014, 2017, 2020, 2023.



[그림 12] 일본 연령별 재택의료 점수(2024.6월 기준)

* 자료: 후생노동성. 사회의료진료행위별 통계. 2025.

○ (방문진료 대상 질환) 순환기계 질환(49.8%)이 가장 많음. 이어서 치매(41.9%), 뇌혈관질환(21.5%), 골절·근골격계 질환(18.5%), 당뇨병(14.6%) 순으로 나타남

〈표 27〉 일본 재택의료 환자의 주요 질환 (2024년)

질병	비율
순환기계 질환(고혈압, 심부전 등)	49.8%
치매	41.9%
뇌혈관질환(뇌경색, 뇌출혈 등)	21.5%
골절·근골격계 질환	18.5%
당뇨병	14.6%
기타	10.9%
호흡기계 질환	8.9%
정신계 질환	8.6%
악성신생물	8.1%
피부질환(욕창 등)	6.8%
난치병(신경계 질환)	6.5%
신경계 질환	4.9%
난치병(신경계 이외)	2.1%
COPD	2.1%
안과 질환	1.9%
무응답	1.6%
척수 손상	0.9%
이비인후과 질환	0.8%

* 주: 「의료기관조사」의 조사대상 시설 직원이 기관당 방문진료 환자 2명, 방문간호 환자 2명을 추출하여 조사실시
조사기간: 2024.12.17.~2025.1.31., 응답 수: 방문진료 환자 1,065명, 방문간호 환자 256명
* 자료: 후생노동성. 2024년도 진료수가 개정 결과 검증에 관한 특별조사 — 재택의료, 재택치과의료, 재택방문약제관리 및 방문간호의 실시 상황 조사. 2025.

○ (연령) 80세 이상이 전체의 74.3%, 평균 연령 84세로 나타나 고령 환자가 대부분이며, 여성이 절반 이상(66%)을 차지함

○ (방문진료 장소) 절반 이상이 자택(57.3%)에서 진료를 받고 있으며, 유료 노인홈(23.1%), 그룹홈(7.2%) 등이 주요 비중을 차지함

○ (참여 경로 및 이유) 가장 많은 비율은 타 의료기관 소개(42.2%), 외래(29.0%) 또는 입원(6.9%) 순으로 높음. 방문진료의 주된 사유는 신체기능 저하로 통원 자체가 곤란(74.6%). 보조 확보 곤란(24.8%) 순으로 높음

〈표 28〉 일본 재택의료 환자조사 결과 (2024년)

구분	세부 항목	비율(%)
성별	남성	33.9
	여성	66.0
	무응답	0.1
연령	70세 미만	7.3
	70~79세	17.5
	80~89세	36.2
	90세 이상	38.1
	무응답	0.9
방문진료 장소 (중복응답)	단독주택·아파트 등	57.3
	유료노인홈(시설)	23.1
	치매노인그룹홈	7.2
	그룹홈(공동생활지원)	2.1
	특별양호노인홈(시설)	2.4
	특정시설 입주자 생활개호	4.4
	기타	5.1
	양호노인홈	0.8
	경비노인홈(저비용주거)	0.7
	무응답	0.7
방문진료 시작 계기	외래에서 전환	29.0
	입원에서 전환	6.9
	타 의료기관 소개	42.2
	의료기관 외 소개	19.2
	무응답	2.8
방문진료 이유 (중복응답)	신체기능 저하로 통원 곤란	74.6
	도움 있으면 통원 가능하나 확보 곤란	24.8
	의사의 처치 필요	12.0
	의사가 거주환경 확인 필요	16.0
	기타	3.7
	무응답	0.8

* 주: 「의료기관 조사」의 조사대상 시설 직원이 기관당 방문진료 환자 2명, 방문간호 환자 2명을 추출하여 조사실시
조사 기간: 2024.12.17.~2025.1.31., 응답 수: 방문진료 환자 1,065명, 방문간호 환자 256명

* 자료: 후생노동성. 2024년도 진료수가 개정 결과 검증에 관한 특별조사 — 재택의료, 재택치과의료, 재택방문약제관리 및 방문간호의 실시 상황 조사. 2025.

○ (방문진료 제공 현황) 진료 횟수는 대부분 월 2회 이상(55.2%) 실시하고 있으며, 2회 이상 실시 이유에 대해서는 의학적 필요도와 외래 방문 곤란이 주 이유로 나타남. 방문진료 시간은 절반가량이 10~20분 미만으로 나타남. 최근 6개월간 비정기적 왕진은 0회가 대부분을 차지함

〈표 29〉 일본 재택의료 횟수 및 시간

구분	세부항목	비율(%)
1개월 간 방문진료 횟수	1회 이하	27.8
	2회	55.2
	3회 이상	10.2
	무응답	6.8
월 2회 이상 방문 이유 (n=697, 복수응답)	의학적으로 필요(처치가 잦음 등)	41.9
	시설 직원 등이 외래 동반 곤란	28.1
	환자·가족의 요청	16.2
	방문간호 등 타 서비스에서 필요 제안	9.3
	특별한 이유 없음	4.3
	기타	8.6
	무응답	9.5
방문진료 시간	10분 미만	11.6
	10~15분 미만	24.3
	15~20분 미만	23.6
	20~30분 미만	17.2
	30분 이상	16.2
	무응답	7.1
최근 6개월간 왕진 횟수	0회	68.2
	1회	11.3
	2~4회	8.3
	5회 이상	7.3
	무응답	5.0

* 주: 「의료기관조사」의 조사 대상 시설 직원이 기관당 방문진료 환자 2명, 방문간호 환자 2명을 추출하여 조사 실시
조사 기간: 2024.12.17.~2025.1.31., 응답 수: 방문진료 환자 1,065명, 방문간호 환자 256명
* 자료: 후생노동성. 2024년도 진료수가 개정 결과 검증에 관한 특별조사 — 재택의료, 재택치과의료, 재택방문약제관리 및 방문간호의 실시 상황 조사. 2025.

○ (의학관리료 산정 현황) 가장 많이 산정된 것은 재택 시 의학종합관리료(월 2회 이상)(29.8%), 포괄적 지원가산(28.3%)이었으며, 재택 마약 주사 관리료, 개호보험시설 등 연계 왕진가산 등은 거의 산정되지 않음

〈표 30〉 일본 재택의료 의학관리료 산정 현황

주요 관리료	비율(%)	가산 및 특수 관리료	비율(%)
재택 시 의학종합관리료(월 2회 이상)	29.8	재택의료 정보연계가산	10.5
포괄적 지원가산	28.3	터미널케어 가산	2.1
시설 입주 시 등 의학종합관리료(월 2회 이상)	23.4	임종 케어 가산	1.5
재택 시 의학종합관리료(월 1회)	20.1	사망 진단 가산	1.3
재택환자 방문진료료(Ⅰ)-2	14.3	왕진 시 의료정보 연계가산	0.6
재택환자 방문진료료(Ⅱ)	3.1	재택 암환자 긴급 시 의료정보 연계지도료	0.4
재택 시 의학종합관리료(중증환자)	6.9	재택 강심제 지속투여 지도관리료	0.1
시설 입주 시 등 의학종합관리료(월 1회)	5.4	재택 요양 이행가산 1~4	0.5
시설 입주 시 등 의학종합관리료(중증환자)	2.7	개호보험시설 등 연계 왕진가산	0.0
빈번 방문가산	2.1	재택 마약 등 주사 지도관리료(1, 2, 3)	0.0
산정안함			7.7
무응답			3.5

* 주: 「의료기관조사」의 조사 대상 시설 직원이 기관당 방문진료 환자 2명, 방문간호 환자 2명을 추출하여 조사실시
조사기간: 2024.12.17.~2025.1.31., 응답 수: 방문진료 환자 1,065명, 방문간호 환자 256명

* 자료: 후생노동성. 2024년도 진료수가 개정 결과 검증에 관한 특별조사 — 재택의료, 재택치과의료, 재택방문약제관리 및 방문간호의 실시 상황 조사. 2025.

2. 미국 건강보험 재택의료 제도

가. 메디케어 재택의료(Medicare Home health care)[11][12][13]

○ 숙련된 간호와 재활치료 중심인 재택의료(Home health care)는 환자의 회복과 자립을 목표로 하는 가정기반 의료·사회 서비스를 의미함. 의사의 진단과 처방 하에 의사 외 전문 인력이 환자 자택에 방문하여 필요한 서비스를 제공함. 메디케어 Part A, B에서 제공되며 공제액이나 본인부담금이 없음(Medicare Rights Center, 2025)

- 메디케어 Part B는 입원여부와 무관하게 환자가 집에서 숙련된 치료가 필요한 경우에 해당하며, Part A는 입원이나 전문요양시설 치료 이후 이용할 수 있음

○ (대상자) 의사 또는 간호사, 임상 전문 간호사, 의사보조원(PA)과 같은 의료전문가로부터 이동이 쉽지 않은 칩거(Homebound) 상태이면서 간헐적으로 전문간호나 치료가 필요하다고 문서로 인정된 환자

- (칩거상태) ①질병이나 부상으로 인해 집을 떠나는 것이 어렵고 외출 시 목발, 휠체어 보조 장비 또는 타인의 도움 필요, ②정상적 외출이 어렵고 외출 시 상당한 노력필요 요건을 모두를 충족해야 함

- (간헐적 전문간호) 주 7일 미만, 하루 8시간 미만의 방문을 최대 21일 동안 제공하는 것으로 정의하며 예외적 상황으로 인정될 경우 연장 가능함

- (문서 인증) 서비스 시작 전 90일 이내 또는 시작 후 30일 이내 의료진의 대면진료가 있어야 하며, 의사 또는 허용된 의료 전문가의 서명이 필요함. 담당 의사는 60일마다 재평가함. 칩거상태로 판단한 근거와 필요한 재택 간호·치료의 유형, 방문빈도, 기간 등을 포함한 구체적 진료계획(Plan of care)이 기술됨

○ (제공 기관) 재택의료기관(HHA: Home Health Agency)은 환자 거주지에서 간호 및 기타 치료 서비스를 제공하는 공공 또는 민간조직임

- 메디케어는 ① 간호 및 치료서비스를 위한 의사 1명 이상과 전문 인력 1명 이상으로

11) Centers for Medicare & Medicaid Services. (2022, November 4). Medicare Program; Calendar Year (CY) 2023 Home Health Prospective Payment System Rate Update
12) Medicare Payment Advisory Commission. (2024, 1). Home health care services payment system. Medicare Payment Advisory Commission
13) The CMS Medicare Claims Processing Manual (Pub. 100-04), chapter 10

구성된 그룹의 운영정책 수립, ② 숙련된 간호, 물리·언어·작업치료 중 최소 한 가지 이상 제공이라는 조건을 갖춘 기관의 서비스만 보상함

○ (제공 서비스) 전문간호, 숙련된 물리·언어·작업치료, 요양보호, 의료사회 서비스를 제공하며 특정 의료용품과 의료장비를 보장함

○ (제공횟수 및 본인부담률) 메디케어 가입자는 재택의료 방문횟수 제한이 없음. 대부분 본인부담금은 없으나 휠체어, 보행기 등 의료장비는 20%의 본인부담금이 적용됨

〈표 31〉 미국 메디케어의 재택의료 제공서비스

항목	내용
전문간호 (Skilled nursing services)	• 부상이나 질병 치료를 위한 자격을 갖춘 간호사나 인증된 간호사의 감독하에 제공되는 서비스 • 주사 및 자가 주사 방법 교육, 경관영양, 상처 드레싱 교체, 처방약·당뇨 관리 교육 등의 서비스 • 하루 8시간, 주당 28시간 이하를 한도로 하며, 특정 상황에서는 주당 35시간까지 보장함
숙련된 치료 (Skilled therapy services)	• 물리치료, 언어치료, 작업치료를 면허가 있는 치료사가 제공함
요양보호 (Home health aide)	• 전문간병이나 숙련된 치료가 필요한 경우, 요양보호사(Home health aide)에 대한 비용 전액 지급 • 24시간 간병, 가사 서비스, 식사 배달, 개인 돌봄 등 개인간병이 필요한 경우는 메디케어에 포함하지 않음 • 하루 8시간, 주당 28시간 이하를 한도로 하며, 특정 상황에서는 주당 35시간까지 보장함
의료사회 (Medical social services)	• 질병과 관련된 사회·정서적 문제 해결을 위한 상담이나 지역사회 연계 등 의사가 지시한 비용 전액 지급
의료용품 및 의료장비 (Durable medical equipment & Medical supplies)	• 인증된 재택의료기관(HHA)에서 제공하는 상처 드레싱, 카테터 등 특정 치료재료에 대한 비용 지급 • 휠체어, 보행기 등의 특정 의료장비 금액의 80% 보상(20% 본인부담)

* 자료. Medicare Rights Center. Home health basics. Medicare Interactive. 2025, May 1.

○ (OASIS: Outcome and Assessment Information Set) 재택의료 환자를 위한 표준화된 임상 평가 도구로, CMS가 환자의 상태를 평가하고 지불·품질평가에 활용하기 위해 개발함. 2023년 1월 OASIS-E 버전으로 개정함[14]

14) Outcome and Assessment Information Set OASIS-E Manual. CMS. 2024.1.1. update.

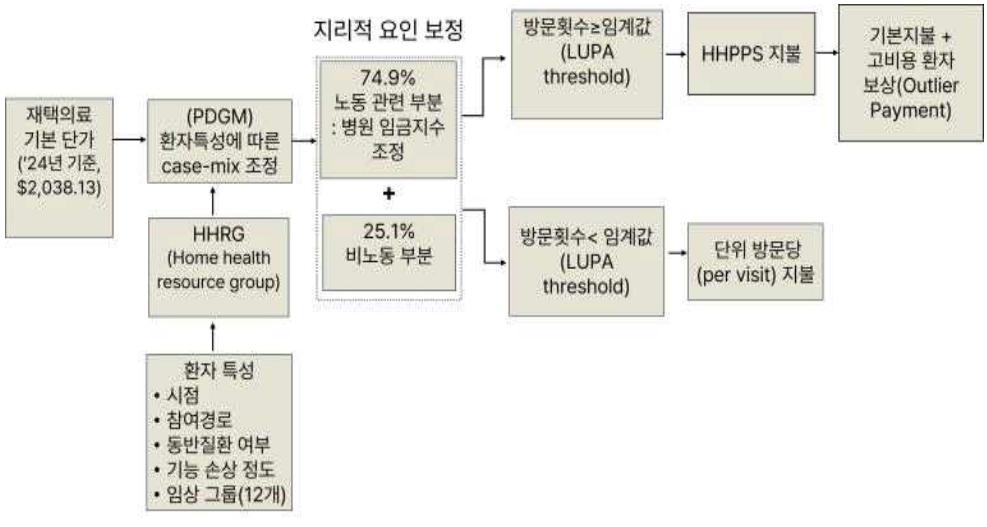
- (대상자) 메디케어, 메디케이드 수급자 중 만 18세 이상의 환자. 산전·후 서비스 이용 환자와 개인간호, 가사도우미 또는 일상지원 업무만을 이용하는 경우 데이터 수집 및 제출요건에서 제외됨
- (평가 시점) 치료 시작, 퇴원 후 치료재개(퇴원 이후 2일 이내), 추적 관찰(60일 재평가 주기의 마지막 5일, 또는 환자 상태의 중대한 변화 발생 이후 2일 이내), 입원 시설로 이송(인지한 날로부터 2일 이내), 사망 혹은 대상자 제외(사망 혹은 대상자 제외 이후 2일 이내)

〈표 32〉 미국 CMS OASIS 평가항목

구분	세부 항목
A. 일반정보	• 공급자 식별번호, CMS인증번호 • 환자ID, 진료 시작일, 치료 재개일, 의뢰일, 환자 이름, 환자 거주 지역(State), 메디케어·메디케이드 번호, 성별, 생년월일, 민족, 인종, 보험종류, 사용언어 • 평가자의 전문분야, 평가완료일, 평가 사유, 퇴원/전원/사망일 • 환자의 이동수단(교통편) • 입원시설, 응급치료 및 사유, 복용 약물
B. 청각, 언어, 시각	• 청력상태, 시각상태, 건강정보 이해력
C. 인지	• 간이정신상태평가(BIMS) 실시 필요 여부, 검사결과, 세 단어 반복 가능 여부, 시간 인지(연도, 월, 일), 기억력, 섬망 징후 및 증상, 인지기능, 혼란상태, 불안 상태
D. 기분	• 기분 인터뷰(PHQ-2~9), 중증도 점수, 사회적 고립
E. 행동	• 인지, 행동 및 정신과적 증상, 방해 행동 증상 빈도
F. 일상생활	• 일상적 활동에 대한 선호도, 지원 유형 및 출처(ADL)
G. 기능상태	• 몸단장, 상의 및 하의 입기 능력, 목욕, 화장실 이동, 배변위생, 보행 및 이동
GG. 기능상태 및 목표	• 이전 일상활동 기능, 이전 기기사용, 자기관리, 이동성
H. 대장과 방광	• 최근 14일 이내 요로감염치료 경험, 요실금 또는 요도 카테터 삽입, 배변실금 빈도, 장루
I. 활동성	• 주 진단 및 기타 진단, 동발질환 및 완치여부
J. 건강상태	• 입원 위험, 통증, 통증이 수면에 미치는 영향, 치료에 통증이 미치는 영향, 일상생활에 통증이 미치는 영향, 낙상여부와 횟수, 호흡곤란
K. 삼킴·영양	• 신장, 체중, 영양관리, 자기식사 능력
M. 피부질환	• 치유되지 않은 욕창 및 손상, 압박성 궤양, 정맥 울혈성 궤양, 정지성 궤양, 수술 상처
N. 약물	• 고위험 약물 사용과 적응증, 약물요법 검토, 약물 추적관리, 약물 중재, 고위험 약물 교육, 경구약물 관리, 주세제 관리
O. 특별치료 및 시술	• 특별치료 내역, 인플루엔자 백신 접종, 치료 필요성
Q. 평가 및 목표	• 중재 개요

* 자료. Outcome and Assessment Information Set OASIS-E Manual. CMS. 2024.1.1. update.

○ (지불제도) 환자의 상태와 필요 서비스에 따라 30일 단위로 표준화된 금액을 사전에 정해진 요율에 따라 지급하는 묶음지불제(Bundled payment) 방식인 재택의료 전향적 지불제도(HHPPS: Home Health Prospective Payment System)를 적용함. 재택의료 전향적 지불제도를 적용받기 위해서는 환자 특성별 방문 횟수 기준을 충족해야 함. 기준 횟수 이하(2~6회)로 방문하면 LUPA(Low Utilization Payment Adjustment)에 따라 방문당 금액(per-visit payment)으로 보상함



[그림 13] 2024년 재택의료 전향적 지불제도(HHPPS) 체계

* 자료: Medicare Payment Advisory Commission. Home health care services payment system. Medicare Payment Advisory Commission. 2024. 재구성

- 최종 지불액은 환자 특성과 진단정보를 반영한 사례혼합(case-mix) 기반 지불모델인 PDGM(Patient-Driven Groupings Model)에 따라 산정됨. 환자는 5가지 기준을 조합한 총 432개의 환자군(HHRG: Home Health Resource Group)중 하나로 분류되어 서로 다른 가중치를 적용받으며, 해당 가중치와 환자 거주 지역별 임금지수(Wage Index)[15]등을 적용하여 최종 수가가 결정됨
- 환자가 속한 그룹은 5자리의 영문과 숫자 조합으로 구성된 청구코드(HIPPS: Health Insurance Prospective Payment System codes)로 나타냄. CMS는 매년 코드별 가중치와 최소 방문횟수(LUPA) 기준을 포함한 지불 체계를 업데이트함

15) 노동부분 76.1%, 비노동 부분 23.9%로 구분하여 적용. 노동비용 부분은 병원 임금지수(hospital wage index)를 이용해 지역별 차이를 보정함

- 재택의료 이용 경험 2개(이전 30일 내 이용 여부 따라 초기/후기)
- 참여 경로 2개 구분(지역사회/의료기관)
- 주 진단에 따른 임상그룹 12개 구분(A~L)

〈표 33〉 미국 메디케어 임상그룹(Clinical grouping) 세부내용

임상그룹(Clinical grouping)	내용
A. 약물관리·교육·평가(MMTA) – 기타	위 범주에 포함되지 않는 기타 의학적 관리
B. 신경/뇌졸중 재활(Neuro Rehab.)	신경계 질환 및 뇌졸중 후 재활
C. 상처 관리(Wounds)	수술 후 상처 관리, 피부 및 비수술적 상처 치료
D. 복합 간호 중재(Complex Nursing Interv.)	집중적이고 복합적인 간호 (정맥영양, 드레싱 등)
E. 근골격계 재활(Musculoskeletal Rehab.)	근골격계 질환·수술 후 재활
F. 행동 건강 관리(Behavioral Health)	정신건강, 행동·인지장애 관련 서비스
약물관리·교육·평가(MMTA, Medication Management Teaching and Assessment)	
G. 수술 후 관리(Surgical Aftercare)	외과적 수술 후 추적 관리
H. 심혈관계(Cardiac & Circulatory)	심장질환 관련 의학적 관리
I. 내분비(Endocrine)	내분비 질환 관련 관리
J. 소화기/비뇨기계(GI/GU)	위장관·비뇨기 질환 관련 관리
K. 감염/종양/혈액질환(Infectious Disease)	감염, 암, 혈액질환 관련 관리
L. 호흡기(Respiratory)	호흡기 질환 관련 관리 (COPD, 천식 등)

* 자료: Centers for Medicare & Medicaid Services. Definition and Uses of Health Insurance Prospective Payment System (HIPPS) Codes. Version 10. CMS. 2022.

- 기능 장애 수준 3개구분(낮음(A), 중간(B), 높음(C))
- 동반질환 조정 3개구분(없음(1), 낮음(2), 높음(3))

〈표 34〉 미국 CMS 전향적 지불제도 건강보험 청구코드(HIPPS)별 세부기준 예시

HIPPS	재택의료 이용경험 – 참여 경로	임상범주– 기능 장애수준	동반질환조정	사례복합 가중치	방문 기준 횟수 (LUPA)
1FC11	초기 × 지역사회(1)	행동건강(F) – 높음(C)	없음(1)	1.0912	4
2DC11	초기 × 의료기관(2)	복합간호(D) – 높음(C)	없음(1)	1.1944	3
3FA21	후기 × 지역사회(3)	행동건강(F) – 낮음(A)	낮음(2)	0.5868	2
4GC31	후기 × 의료기관(4)	수술 후 관리 교육 및 평가(G) – 높음(C)	높음(3)	1.4789	4

* 주: 괄호는 HIPPS 코드에 쓰이는 기호를 나타냄
* 자료: CMS. Home health PPS case-mix weights. Centers for Medicare & Medicaid Services. 2025

○ (가산) 가산항목으로는 농어촌 지역 가산과 고비용 환자에 대한 추가 보상이 있었으나, 농어촌 지역가산은 2023년 폐지되어 현재 고비용 환자에 대한 추가 보상만 가능함

- (농어촌 지역 가산) 인구밀도가 낮은 지역 소재 재택의료기관은 전향적 지불제도 금액의 1~3%를 가산함. 2021년 기준 농어촌과 도시지역의 재택의료 이용률과 서비스 공급 수준이 비슷하고 농어촌 메디케어 평균 마진이 25.2%로 도시지역 24.8%보다 높은 것으로 확인되어 2023년 가산 제도를 폐지함(MedPAC, 2023)
- (고비용 이상치) 환자 건강상태 등으로 시간과 비용이 많이 소요된 경우 기준액과 실제 지출한 비용의 차액의 80%에 해당하는 금액을 추가로 보상함. 이 금액은 연간 지급액의 최대 2.5% 범위에서 적용함

○ (의료질 관리) QRP(Pay-for-Reporting), HHVBP(Value-Based Purchasing)를 통해 품질데이터 보고를 의무화하고 성과기반 인센티브를 적용함. HHA는 OASIS 정보, 환자경험조사인 HHCAHPS(Home Health Care Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)와 청구자료를 품질보고 프로그램(QRP)에 따라 의무적으로 제출해야 하며 해당 정보로 성과기반 지불제도(HHVPB) 지불조정이 이뤄짐

〈표 35〉 미국 메디케어 HHVBP 모델 구성요소 (2023-2024 성과연도)

구분	주요 내용
품질지표 데이터	• OASIS, 청구자료, HHCAHPS • 충분한 데이터가 있는 지표가 최소 5개 이상 있어야 TPS 산정 가능 – OASIS: 최소 20개 이상의 에피소드 – 청구자료: 최소 20건 이상 – HHCAHPS 설문: 최소 40부 이상 설문 응답
총 성과점수(TPS)	• HHA 성과를 종합 점수화. 달성도, 개선도를 평가하여 둘 중 더 높은 점수를 반영하여 산출함 – 달성도(achievement): 같은 코호트 다른 기관과 비교한 상대적 성과 – 개선도(improvement): 기관의 기준연도 대비 얼마나 개선했는지
중간성과보고서(IPR)	• 성과점수·달성·개선도, TPS 예비값을 분기별로 기관에 제공. 15일 내 재산정 요청 가능
연간성과보고서(APR)	• 매년 8월 예비 보고, 9~10월 최종 APR 제공. 재산정·재심 요청 가능
지불조정비율(APP)	• TPS 결과를 반영해 지불연도 Medicare 지불액을 ±5% 범위에서 조정 (청구 시 자동 반영)

* 주: TPS: Total Performance Score, IPR: Interim Performance Report, APR: Annual Performance Report, APP: Adjusted Payment Percentage

* 자료: CMS. Expanded Home Health Value-Based Purchasing (HHVBP) Model Resource Index. 2024.

- (QRP) 재택의료기관이 CMS에 품질데이터를 의무 제출하도록 하는 프로그램으로 정해진 기간 내에 자료를 제출하지 않으면 연간 지불인상률의 2%를 삭감함
- (HHVBP) 재택의료기관의 질과 성과를 반영하여 HHPPS의 최종 지불액에서 ±5%를 가감하는 성과기반 지불제도로 성과연도(Performance year)에 OASIS, HHCAHPS, 청구자료 기반 총 12개 지표를 평가하여 2년 뒤 지불연도(Payment year)의 성과에 따른 지불조정이 이루어짐
  - OASIS(5개): 환자 이동성 기능 개선 정도(위험도 보정 적용), 환자 자기관리 기능 개선 정도 (위험도 보정 적용), 퇴원 시 환자 기능 점수(종합적 기능 수준), 재택의료 시작 후 60일 이내 급성기 입원율, 응급실 이용률(입원으로 이어지지 않은 경우)
  - HHCAHPS(5개): 환자 돌봄에 대한 전반적 경험, 의료진과 환자의 의사소통, 약물·치료 설명의 명확성 등, 재택의료 전반적 만족도, 해당 기관을 추천할 의향
  - 청구자료(2개): 재택의료 중 입원 발생률, 재택의료 중 응급실 이용률
- CMS는 기관에 중간성과보고(IPR)와 연간성과보고(APR)를 제공하여 재산정·재심절차를 통해 이의를 제기할 수 있도록 함

〈표 36〉 미국 메디케어 재택의료 등록 및 보상절차

단계	절차	내용
1	환자 등록 및 자격 확인	• 환자의 메디케어 자격 확인 • 의료진의 Home Health Plan of Care를 통한 대상자 승인
2	초기평가·OASIS 작성	• OASIS 평가를 통한 환자 기능 상태, 진단, 동반질환 등 기록
3	청구 데이터 생성	• 진단코드(ICD-10-CM) 및 서비스 내역 입력 • HIPPS 코드 생성: PDGM 기반 432개 그룹 분류
4	30일 지불 단위 산정	• HIPPS 코드별 가중치 적용: 전국 표준화 30일 단가 × Case-mix 가중치 × 지역 임금지수(Wage Index)
5	지불 금액 조정	• 방문횟수 기준 미달 시 방문 당 단가 지급(LUPA) • PEP(Partial Episode Payment): 환자 전원·재입원 시 부분 지불 • Outlier Payment: 고비용 사례 추가 보상
6	CMS 지급 결정	• 청구 검토 후 지급 확정 • 품질보고(QRP) 미제출 시 2% 삭감
8	사후조정	• 청구자료 모니터링 • HHVBP 성과 기반 인센티브 및 패널티 적용

* 자료: Centers for Medicare & Medicaid Services. Home health prospective payment system (HHPPS). CMS. 2024, September 10.

- 2016년 9개 주에서 시행한 시범사업 결과 의료질 저하 없이 1억 4,100만 달러를 절감하는 효과를 확인함에 따라 2023년부터 전국 확대함

○ 진료 분야별 방문의료에 대한 세부 사항은 HCPCS G-코드를 사용하며, 전문가 별 15분 단위 방문당 단가를 의미함

○ 최종적으로 CMS는 청구데이터와 OASIS를 대조하여 자격·코드·기간을 검증한 후 환자 그룹(PDGM)에 따른 가중치와, 지역별 병원 임금지수 보정(Hospital Wage Index)과 추가조정을 통해 금액을 보정한 총 지불액을 산정하여 HHA에 지급함

〈표 37〉 미국 메디케어 서비스 행위별 코드 내용

구분	HCPC 코드	내용	방문당 금액[1] (USD)
물리치료	G0151	자격을 갖춘 물리 치료사가 가정 건강 또는 호스피스 환경에서 수행하는 서비스	$184.03
작업치료	G0152	자격을 갖춘 작업 치료사가 가정 건강 또는 호스피스 환경에서 수행하는 서비스	$185.29
언어치료	G0153	자격을 갖춘 언어 치료사가 가정 건강 또는 호스피스 환경에서 수행하는 서비스	$200.04
전문간호[1]	G0162	자격증을 소지한 간호사(RN만 해당)가 제공하는 숙련된 서비스. 치료계획의 관리 및 평가를 15분단위로 실시 (환자의 기저 질환이나 합병증으로 인해 RN 필요)	$168.37
	G0299	가정 또는 호스피스 환경에서 등록 간호사(RN)의 직접적인 전문 간호 서비스	
	G0493	등록 간호사(RN)의 숙련된 서비스로 환자 상태 관찰/평가,	
	G0495	환자 또는 가족의 훈련 또는 교육에 대한 RN의 숙련된 서비스	
의료사회	G0155	가정 건강관리 계획에 따른 임상 사회복지사의 서비스	$269.87
요양보호	G0156	가정 건강 관리 계획에 따른 가정 요양보호서비스	$76.23
서비스 제공 장소	Q5001	환자의 거주지에서 제공되는 호스피스 또는 가정 건강관리	-
	Q5002	보조 생활시설에서 제공되는 호스피스 또는 가정 건강관리	
	Q5009	기타 장소에서 제공되는 호스피스 또는 가정 건강관리	
원격모니터링	G0320	실시간 양방향 오디오 및 비디오 통신 시스템을 통해 제공되는 동기식 원격 진료를 활용한 가정 건강 서비스	-
	G0321	실시간 대화형 오디오 전용 통신 시스템을 통해 제공되는 원격 진료를 활용한 가정 건강 서비스	
	G0322	환자가 가정 건강 기관에 디지털 방식으로 저장·전송하는 생리학적 데이터 수집	

* 자료: CMS. CY 2024 per-visit payment amounts for home health agencies (HHAs) [Table 3 & Table 4]. In MLN Matters: MM13411. 2023, CGS Medicare. Home health billing codes. Home Health & Hospice. 2025.

* 주1. 품질보고(QRP)에 따른 데이터 제출 완료 기준 단가, 미제출 시 2% 감액됨

2. RN (Registered Nurse, 등록간호사), LPN (Licensed Practical Nurse, 면허실무간호사)를 의미하며, RN은 전반적인 간호계획을 수립하고 조정하며 LPN은 RN또는 의사의 감독 하에서만 환자 돌봄을 수행할 수 있음

나. 메디케어 재택방문(Medicare Home visits)

○ 메디케어 재택방문(home visits)은 의사(MD) 또는 의료전문가(non-physician practitioner)가 환자의 거주지(자택, 요양 주거시설, 그룹홈 등)에 방문하여 진료하는 것을 의미함. 간호와 재활치료 중심인 재택의료와는 달리 의사가 직접 환자의 집에 방문하여 외래진료와 같은 의료행위를 수행한다는 점에서 차이가 있음

○ (대상자) 신체적·정신적 제약으로 의료기관을 직접 방문하기 어려운 상태가 객관적으로 입증되어야 하고 환자나 의사의 단순 편의를 위한 방문은 허용되지 않음

○ (서비스 제공자) 메디케어에 등록된 의사나 간호사(NP), 의사보조원(PA)과 같은 자격을 의료전문가(QHP, Qualified Health Professional)만이 제공 할 수 있음. 재택방문 시 직접 환자 상태를 평가하고, 진단·치료 계획을 수립해야 하며, 의무기록으로 문서화해야 함

○ (제공 서비스) 일반 외래 진료와 유사하나, 환자의 생활환경과 돌봄 필요성을 함께 고려함. 주요 서비스는 간단한 시술이나 검사, 만성질환 관리, 급성 증상 대응, 약물 조정, 환자 및 가족교육 등이 있으며, 필요시 사전 돌봄계획과 다른 의료전문가와의 협업·의뢰를 조정함

○ (제공 횟수 및 본인부담률) 방문 횟수 제한은 없으나 재택방문의 의학적 타당성이 반복적으로 입증되어야 함. 본인부담률은 Part B 기준 20%(20% coinsurance + annual deductible)가 적용됨

○ (청구) 의료기관은 CPT(Current Procedural Terminology)코드 기반으로 청구하며, 행위별수가에 해당하는 의사 수가표(Physician Fee Schedule) 중 평가 및 관리(E/M: Evaluation & Management) 범주에 해당하는 비용을 지급함. 재택방문은 재택의료와는 별도의 서비스로 동일 환자에게 같은 목적의 중복 청구는 인정되지 않음

- (평가 및 관리) 환자를 대면하여 병력 확인, 일반 건강상태 검사, 의학적 의사결정 등에 관한 행위로 외래, 입원, 응급실, 재택 방문 등에서 의사가 환자를 평가하고 관리하는 전체 과정이 이에 해당함

  • 평가 및 관리 중 재택방문에 해당하는 CPT 코드는 ①서비스 제공 장소(요양시설 서비스/가정 및 거주서비스), ②신규 환자 여부, ③진료시간, ④의학적 의사결정

(MDM)의 난이도(단순/ 낮음/ 중간/ 높음)에 따라 수가가 차등 책정되며 진료를 위한 이동시간은 고려되지 않음

- 의학적 의사결정(MDM: Medical Decision Making)은 CPT 기본진료료와 유사한 평가 및 관리(E/M)의 수가 수준을 결정하는 핵심지표로 환자를 위해 해결해야할 문제의 수와 복잡성, 검토할 자료의 양과 난이도, 환자 관리와 관련된 위험도를 종합적으로 반영함(AMA, 2023)

- (가산) 진료시간과 환자 상태의 복잡성에 따라 가산이 적용됨. CPT 코드에 규정된 기준 시간을 초과하는 경우 15분 단위로 가산(G0318)하며, 환자가 장기적으로 복합적 관리가 필요한 상태로 주치의 역할이 강조되는 경우 가산(G2211)함

〈표 38〉 미국 메디케어 재택방문 관련 CPT 코드

구분	코드	환자유형	시간	의학적 의사결정(MDM)	방문당 금액) (USD)
Home Services (평가 및 관리)	99341	신규환자	20분	초기 단순 방문	$44.98 - $64.32
	99342		30분	복잡도 높음	$71.79 - $103.08
	99344		60분	복잡한 문제, 포괄적 관리	$128.90 - $184.28
	99345	기존환자	75분 이상	고난이도 환자	$181.43 - $258.08
	99347		15분	단순 추적관리	$41.19 - $58.77
	99348		25분	중등도 문제	$69.61 - $99.14
	99349		40분	복잡 문제, 지속 관리	$114.71 - $163.06
	99350		60분 이상	중증·복합질환	$166.76 - $237.47

다. 비대면 모니터링

○ 미국 보건복지부(HHS)는 원격 환자 모니터링(RPM: Remote Patient Monitoring)을 의료 제공자와 환자 간의 실시간 상호작용이 필요하지 않은 시간 차 원격 진료의 한 형태로 정의하며, 디지털 기기를 사용하여 환자가 의료기관이 아닌 장소, 특히 자택에 있을 때 데이터를 수집하고 의료제공자에게 전송하여 치료·관리에 활용하는 것을 말함(AHRQ, 2023, HRSA, 2025)[16]

○ 원격 환자 모니터링은 치료 성격과 필요 자원에 따라 원격 생체정보 모니터링(RPM: Remote Physiological Monitoring)과 원격 치료 모니터링(RTM: Remote Therapeutic Monitoring)으로 구분함. RPM은 일반적으로 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 관리에 사용되며 RTM은 재활·행동치료와 관련하여 환자의 치료순응도, 기능상태 파악을 위해 사용됨

- (RPM) 스마트 체중계, 연속혈당측정기 등 디지털 기기를 통해 자동으로 수집된 환자의 혈압, 혈당, 체중, 산소포화도 등 생리학적(Physiological) 지표를 기반으로 환자의 건강상태를 관리하며 주로 의사와 보조인력(PA, NP)이 제공됨.
- (RTM) 환자의 치료 행태, 기능 상태, 증상, 복약 순응도 등을 중점으로 모니터링하며, 의사와 보조인력 외에 재활·물리·언어치료사가 서비스를 제공할 수 있음

○ 원격 모니터링 제공은 ① 환자교육, ② 기기제공, ③ 치료관리 3가지 주요 구성요소 이루어져 있음(CMS, 2025)[17].의료진은 환자 데이터를 정기적으로 검토, 관리하고 필요시 환자에게 연락 등의 조치를 취하며, 환자 상태 모니터링, 악화 방지 및 입원 예방에 목적이 있음

○ RPM과 RTM은 동시에 청구할 수 없으며, 메디케어에서 허용하는 CPT, HCPCS 코드에 나열된 서비스 내에서 제공해야함. 30일 중 최소 16일 동안 데이터를 수집해야 하며 제공자 1인당 환자 1명에 한해 30일 주기로 청구 가능함. 단, 만성질환 관리, 전환기 관리, 정신·행동건강 통합관리, 주요 질환 관리, 만성 통증 관리에 대해서는 중복 청구 가능함

16) AHRQ PSNet. Remote Patient Monitoring. Colton Hood, Neal Sikka, Cindy Manaoat Van, Sarah E. Mossburg. Agency for Healthcare Research and Quality, (2023.3.15.)
17) Centers for Medicare & Medicaid Services. Remote patient monitoring. Medicare telehealth. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cms.gov/medicare/coverage/telehealth/remote-patient-monitoring

○ (메디케어 재택의료) CMS는 2023년 HCPCS-G-코드(G0320~G0322)를 신규 도입하여 재택의료기관의 원격통신기술 사용 여부를 청구 시 의무 보고 항목에 포함함. 원격통신기술 사용 시작일과 모니터링 기간을 입력해야 하며, 치료계획에 해당 기술이 목표달성에 어떠한 기여를 했는지 진료기록으로 문서화해야 함

- HCPCS-G-코드는 지불 목적이 아닌 데이터 수집·보고를 위해 도입되어 비대면 모니터링만으로는 별도 보상하지 않음. 다만 치료계획 수정을 명시하고 서비스를 제공한 경우, 장비 구매. 설치, 서비스에 대한 행정비용 처리는 가능함

〈표 39〉 미국 메디케어 비대면 모니터링 관련 CPT 코드

항목	코드	내용	금액 (USD)
원격 생체정보 모니터링 (RPM)	99453	• 장비 초기설치 및 환자 교육 • 초기 16일 모니터링 후 1회 청구 가능	$19.73
	99454	• 매월 환자 데이터 수집 및 전송 • 30일 동안 최소 16일 이상 사용	$43.03
	99457	• 매월 환자, 데이터 해석·관리, 의사-환자 쌍방향 소통 • 초기 20분	$47.88
	99458	• 의사-환자 쌍방향 소통 추가 시간, 99457과 요건 동일 • 추가 20분, 최대 60분/월	$38.50
	99091	• 전문가의 데이터 수집·해석 • 30분 이상	$52.71
원격 치료 모니터링 (RTM)	98975	• 장비 초기설치 및 환자 교육 • 초기 16일 모니터링 후 1회 청구 가능	$19.73
	98976	• 호흡기 모니터링용 장치 제공 • 30일 동안 최소 16일 이상 데이터 수집	$43.02
	98977	• 근골격계 모니터링용 장치 제공 • 30일 동안 최소 16일 이상 데이터 수집	$43.02
	98978	• 인지행동치료(CBT) 장치 제공 • 30일에 1회 청구	-
	98980	• 데이터 기반 치료관리, 환자와 최소 1회 상호작용(전화, 영상 등) 필요 • 초기 20분	$50.14
	98981	• 98980과 요건 동일 • 추가 20분	$39.14
메디케어 재택의료	G0320	실시간 양방향 오디오 및 비디오 통신 시스템을 통해 제공되는 원격 진료	-
	G0321	실시간 대화형 오디오 전용 통신 시스템을 통해 제공되는 원격 진료	
	G0322	환자가 재택의료기관에 디지털 방식으로 저장·전송하는 원격 생체정보 모니터링	

* 자료: Centers for Medicare & Medicaid Services. (2025.4.). Telehealth & remote patient monitoring (MLN901705). Medicare Learning Network

라. 재택의료 현황 및 성과

○ (이용현황) 2020~2024년 동안 전체 30일 진료 에피소드 건수는 연평균 약 13% 감소하였으며, 수혜자 수는 2020년 대비 2024년 약 12% 감소함. 이에 따라 1인당 평균 진료 에피소드 수는 2020년 2.95건 이후 증가해 2024년 3.10건으로 증가함

〈표 40〉 미국 메디케어 재택의료 이용현황

(단위: 명, 건)

항목	2020	2021	2022	2023	2024
환자 수	2,850,916	3,017,464	2,831,138	2,715,010	2,620,520
30일 진료 에피소드 건수	8,423,688	9,269,971	8,593,266	8,319,064	8,118,120
환자 당 평균 30일 에피소드 건수	2.95	3.07	3.04	3.06	3.1

* 자료. CMS, CY 2026 HH PPS Proposed Rule (FR 2025-12347).

○ (LUPA) LUPA 비율은 2020년 8.7% 이후 감소 추세에 있으며, 평균 방문 횟수는 2회 미만임

〈표 41〉 미국 메디케어 재택의료 LUPA 비율 및 평균 방문 수 (2020~2024)

항목	2020	2021	2022	2023	2024
LUPA 비율(%)	8.7	7.9	7.8	6.9	6.9
LUPA 평균 방문 수	1.84	1.79	1.81	1.61	1.63

* 자료. CMS, CY 2026 HH PPS Proposed Rule (FR 2025-12347).

○ (서비스 제공자별 평균 방문 횟수) 서비스 제공자별 평균 총 방문 횟수는 2020년 8.6회에서 2024년 7.9회로 약 9% 감소함. 특히 전문간호와 요양보호 방문횟수는 2020년 이후 지속적으로 감소함

〈표 42〉 미국 메디케어 서비스 제공자별 연평균 방문 횟수

(단위: 건)

직종	2020	2021	2022	2023	2024
전문간호	4.35	4.05	3.9	3.87	3.84
물리치료	2.7	2.74	2.77	2.77	2.73
작업치료	0.79	0.78	0.77	0.76	0.73
언어치료	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13
요양보호	0.54	0.48	0.43	0.42	0.39
사회복지	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04
합계	8.59	8.25	8.06	8.01	7.86

* 자료. CMS, CY 2026 HH PPS Proposed Rule (FR 2025-12347).

○ (분야별 평균 비용) 환자당 30일 단위 서비스 분야별 총지불 비용은 2021년 $1,420.35에서 2022년 소폭 하락하였으나 이후 증가 추세를 보임. 전문간호와 물리치료가 전체 비용에서 가장 큰 비중을 차지하며, 전문간호 분야는 다른 분야에 비해 큰 폭으로 비용이 증가함

〈표 43〉 미국 메디케어 서비스 분야별 환자당 30일 단위 평균 추정 비용

(단위: USD)

분야	2021	2022	2023	2024
전문간호	678.82	676.69	748.92	770.06
물리치료	508.18	502.04	542.15	541.18
작업치료	142.11	139.28	145.30	143.78
언어치료	31.40	29.00	31.22	29.79
요양보호	16.21	13.63	15.74	16.42
의료사회복지	43.63	41.63	43.90	47.15
합계	1,420.35	1,402.27	1,527.23	1,548.39

* 주 1. LUPA와 PEP는 제외되었으며, 소모품 비용은 별도 계산됨
2. 2023년 HHA 비용보고서(CMS Form 1728-20) 기반으로 인력별 방문당 평균 비용을 산출한 뒤, 2024년 지불 업데이트율(3%)과 인력별 평균 방문 횟수를 적용하여 30일 주기 총비용을 추정함

* 자료: CMS, CY2023-2026 HH PPS Proposed Rule-2022-13376(87 FR 37600), 2023-14044(88 FR 43654),2024-14254(89 FR 55312), 2025-12347 (90 FR 29108)

○ (원격 기술 사용 현황) 2024년은 전체 청구 건수 약 812만 건 중 약 2% 정도가 원격 기술 사용을 보고 하였으며, 대부분이 전문간호 영역에서 사용된 것으로 나타남

〈표 44〉 미국 메디케어 재택의료 원격진료, 원격모니터링 현황 (2024년)

직종	원격진료(Telemedicine)				원격모니터링(RPM)			
	청구건수	방문횟수	환자 수	제공자 수	청구건수	방문횟수	환자 수	제공자 수
전문간호	139,730	284,854	96,535	1,087	38,513	679,102	20,786	455
물리치료	26,362	43,189	20,950	566	694	11,266	535	108
작업치료	5,422	8,805	4,303	325	76	1,253	68	26
언어치료	1,470	2,312	1,045	166	124	2,143	79	14
요양보호	1	1	1	1	29	596	23	13
사회복지	4,675	5,337	4,137	285	176	4,148	117	7

* 자료. CMS, CY 2026 HH PPS Proposed Rule (FR 2025-12347).

〈표 45〉 미국 메디케어 재택의료 임상군별(Clinical group) 분포

(단위: %)

그룹	2020	2021	2022	2023	2024
근골격 재활	19.4	19.8	20.8	21.2	21.4
신경계	10.5	10.9	11.0	10.9	10.8
상처 관리	14.2	13.9	13.7	14.0	14.0
MMTA-내분비	7.2	6.9	6.8	7.0	7.1
MMTA-심혈관	18.9	18.5	17.9	17.5	17.1
MMTA-호흡기	7.8	8.0	7.8	7.2	7.0
MMTA-기타	3.1	3.6	3.5	3.7	3.8
MMTA-감염	4.8	4.6	4.6	4.7	4.8
MMTA-GI/GU	4.7	4.7	4.9	5.0	5.2
MMTA-수술후	3.6	3.4	3.4	3.5	3.5
복합간호	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1
정신건강	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1

* 자료. CMS, CY 2026 HH PPS Proposed Rule (FR 2025-12347).

○ (임상군별 분포) PDGM에 따라 환자는 청구서에 보고된 주 진단에 기반하여 12개의 임상그룹 중 하나로 분류되며, 2024년 근골격 재활 21.4%, MMTA-심혈관 17.1%, 상처관리 14.0%를 차지함

○ CMS는 새로운 지불제도 도입 시, 예산 중립(budget neutrality) 을 유지해야 하는 법적 의무에 따라 PDGM 지출을 과잉지불(overpayment)로 규정하고 매년 일정 비율의 감액을 적용함[18]. 최근 수년간 감액률은 2023년 -3.925%, 2024년 -2.890%, 2025년 -1.975% 등으로 매년 누적되고 있으며, 2026년에는 -6.4% 감액이 예고됨[19]

18) www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/calendar-year-cy-2025-home-health-prospective-payment-system-final-rule-fact-sheet-cms-1803-f

* 19) https://www.aota.org/advocacy/advocacy-news/2025/cms-proposing-significant-payment-cut-for-home-health-agencies-in-2026

3. 소결

○ 일본과 미국은 모두 건강보험 재택의료 대상자를 자력 이동이 곤란한 자와 같이 상병이 아닌 상태로 명시함. 미국은 칩거상태의 환자가 전문간호 등의 필요가 있음을 문서로 인증함. 다직종 서비스 제공을 보장한다는 공통점도 확인됨. 일본은 의사, 간호사, 약사, 영양사, 재활전문가 등이 미국은 간호, 물리·작업·언어 치료뿐만 아니라 요양보호, 사회서비스 등이 포함되는 포괄적 서비스를 인정함. 비대면 모니터링은 포괄적 서비스를 제공하는 재택의료에 포함되기도 하고 재택의료와 무관하게 단독 사업으로 수행되기도 함. 단독 사업인 경우 비대면 환자 모니터링이나 원격 모니터링 등의 용어를 사용함

○ 일본과 미국 건강보험 재택의료의 차이점은 다음과 같음

- (보상 방식) 일본은 행위별 수가제 중심으로 왕진, 방문진료, 재택요양지도관리료 등 항목별 세부 점수로 구성되어 제공되는 서비스에 따라 보상규모를 달리하고 야간, 심야, 임종환자, 정보연계 등 다양한 가산과 감산 기준이 있음. 미국은 포괄적 관리를 하는 환자에게 30일 단위 묶음지불제로 환자 상태와 필요에 따른 432개 그룹으로 구분하여 보상액에 차이를 둠
- (대상자 재평가) 일본은 급성악화 환자 등 일부 대상자에게 제한된 기간(14일) 동안 재택의료를 제공하도록 명시하고 나머지 환자의 경우 의사의 판단에 따름. 이에 반해 미국은 60일 간격의 재평가를 기본으로 함
- (제공 기관) 일본은 모든 의료기관이 재택의료를 제공할 수 있으며 재택요양지원기관이나 기능강화형과 같이 특화 병원으로 인정된 경우 추가 금액을 더 보상받으나 미국 메디케어는 인증된 재택의료기관(HHA)에 자격을 부여함
- (질 관리) 제공 기관에 따라 역할과 보상 규모를 다르게 부여하는 방식으로 의료질에 편차를 두며 최근 재택의료 DX 가산을 통해 ICT 기반 관리를 강화하고자 함. 미국은 품질보고프로그램(QRP)과 성과기반 보상(HHVBP) 체계를 보상체계와 연동하여 인센티브를 적용함

〈표 46〉 일본과 미국의 재택의료 제도

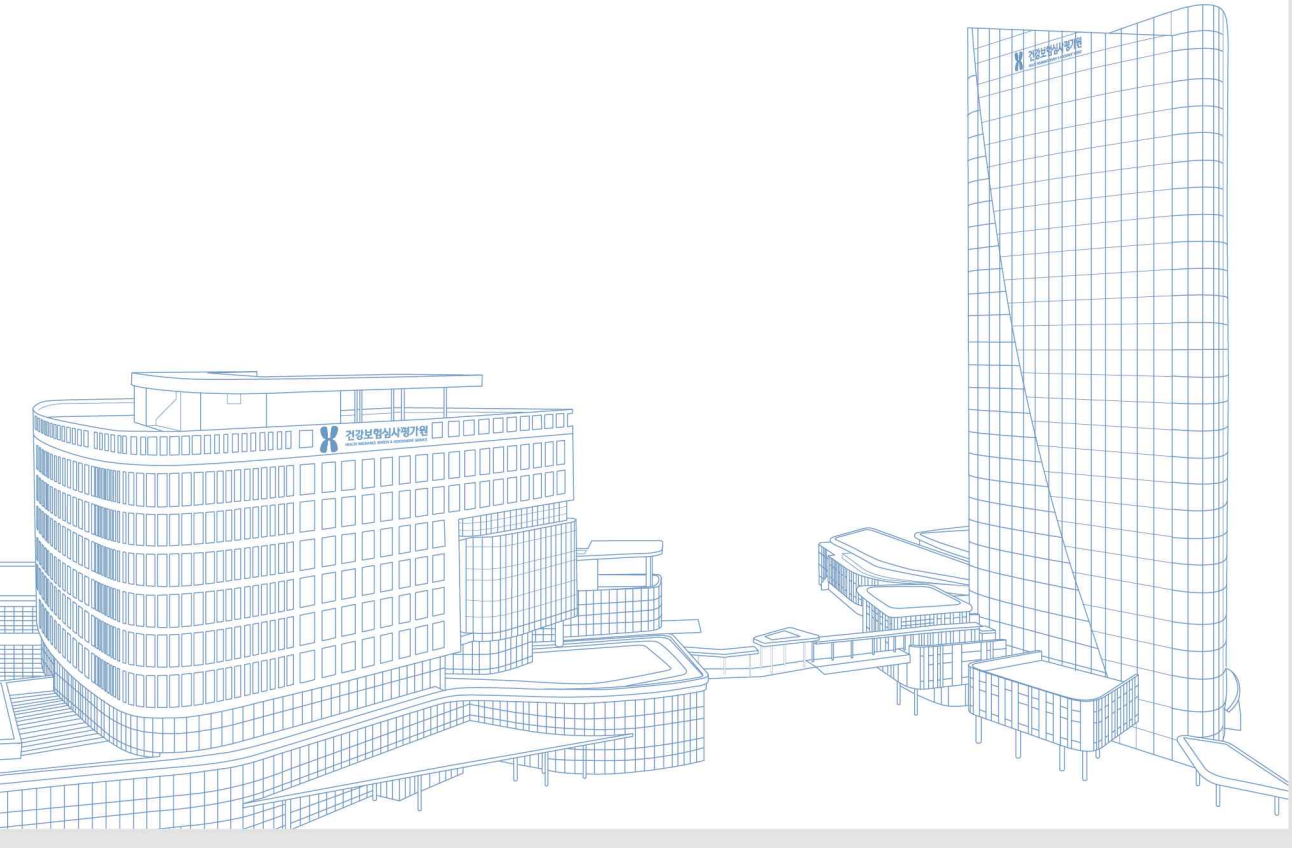
구분	일본 건강보험	미국 메디케어
대상자	• 재택요양 중인 통원 곤란자	• 이동이 어려운 상태임을 의료인에게 인정받은 자 • 표준화된 임상평가 도구 OASIS 사용 • 60일 간격이나 퇴원 등 이벤트 발생 시 환자 상태 재평가
제공기관	• 모든 진료소, 병원 제공 • 인력구성 및 인프라 구축에 따라 기관 단위 가산	• 재택의료기관으로 제한
제공 서비스	• 전문 인력별 방문의료, 평가, 치료계획 등 통합관리 • 비대면 모니터링, 다직종, 다기관 협력 등	• 전문 인력별 방문의료, 평가, 치료계획 등 통합관리 • 의료용품 및 장비, 요양보호 등
지불제도	• 행위별수가	• (지속관리) 월단위 묶음수가 • (일시적 방문) 행위별수가
가산기준	• 긴급, 야간, 휴일, 심야, 초과진료시간, 임종케어 등	• 60일 이내 이용 여부, 지역사회 거주, 임상범주(중증도), 동반질환, 기능 장애수준 등에 따라 묶음수가 수준 차등
감산기준	• 동일일 방문, 2개 이상의 의료기관이 동일 환자 방문 등	
의료질 평가	-	• QRP, HHVBP로 품질데이터 보고를 의무화하고 성과기반 인센티브 적용
의료와 돌봄의 역할	• 질병 치료와 증상 악화방지 목적은 건강보험, 생활지원과 기능유지 목적은 개호보험 적용 • 동일·유사 서비스는 개호보험 우선 적용	• 메디케어에서 의료와 요양 동시 제공

* QRP: Pay-for-Reporting, HHVBP: Home Health Value-Based Purchasing

○ 일본과 미국 재택의료 제도 고찰에 따른 시사점은 다음과 같음. 재택의료 대상자 기준은 상병이 아닌 일상생활 수행능력과 이동성 등 환자 상태 중심으로 전환하고, 의사, 간호사 등 다직종 협업기반의 통합서비스를 마련해야 함. 의료기관의 역량이나 환자의 건강결과 향상 등 성과에 따른 다양한 보상 방안을 모색해야 함. 또한 일본 기능강화형 재택요양지원기관과 미국 인증재택의료기관(HHA) 사례와 같이 의료기관별 역할을 명확히 하고 ICT 기반의 모니터링과 데이터 관리를 병행한 재택의료 전달 체계를 고려해야 함

제4장

건강보험 재택의료 제공 및 이용 현황 분석



제4장 건강보험 재택의료 제공 및 이용 현황 분석

1. 분석 개요

○ (분석 대상) 2025년 5월 기준, 의사, 간호사, 물리·작업치료사 등이 제공하는 방문의료가 있거나, 사업명에 '재택'을 포함하는 15개 시범사업과 2개 수가 사업 내역을 심사평가원 건강보험 청구자료를 활용하여 분석함

○ (분석기간) 분석 대상 중 최초로 시행된 시범사업인 장애인 건강주치의 시범사업 시작일인 2018년 5월부터 2024년 12월(심사년월 기준 2017년 5월~2025년 3월)을 분석 기간으로 함

○ (분석방법) 서비스별 수가코드와 시범사업 청구 시 기재해야 하는 특정기호를 활용하여 추출하였으며, 환자식별번호(pat_hpin), 요양기호, 종별, 주상병 코드, 요양개시일 및 종료일, 진료비 총금액, 수가코드, 특정기호 등의 정보를 활용함

- (15개 시범사업 특정기호) 장애인건강주치의 시범사업(S010), 중증소아 재택의료 시범사업(S014), 정신질환자 지속치료 지원 시범사업(S018, S019), 재활의료기관 시범사업(S043), 치매관리주치의 시범사업(S045), 질환군별 재택의료(복막투석 S016, 1형 당뇨병 S021, 가정용 인공호흡기 S022, 심장질환자 S026, 재활환자 S034, 결핵환자 S037, 암환자 S038, 암환자(요루) S040), 일차의료 방문진료 수가 시범사업(S017), 일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업(S035)

- (2개 수가코드) 가-13 가정간호 기본방문(AN200, AN300, AN400, AN500, 13200, 13300, 13400, 13500), 완-11,12 가정형 호스피스(AP180, AP280, AP380, AP480, AP181, AP281, AP381, AP481, AP170, AP270, AP370, AP470, AP190, AP290, AP390, AP490, AP130, AP230, AP330, AP430)

○ 분석 프로그램은 SAS Enterprise Guide 7.1을 사용함

2. 일반 현황

○ 분석 기간 동안 건강보험 재택의료 참여 기관은 1,960개소이며 일차의료 한의 방문진료 참여 기관이 48.3%로 가장 많음. 중증소아 재택의료는 4개 기관이 참여함. 이용 환자는 255,097명이며 가정간호 기본방문 환자 140,692명(55.2%)으로 가장 많음. 2022년 12월부터 시행한 암환자(요루) 재택의료 환자가 338명(0.1%), 중증소아 재택의료 830명(0.3%)로 적음

- 평균 기관당 환자 수가 가장 많은 사업은 404.3명인 가정간호 기본방문이며, 가장 적은 사업은 13.0명인 일차의료 한의 방문진료임
- 분석 기간 동안 청구된 진료비가 가장 많은 건강보험 재택의료는 가정간호 기본방문으로 3,180억 원이며, 가장 적은 사업은 49백만 원인 암환자(요로) 재택의료임

〈표 47〉 건강보험 재택의료 참여 기관 및 환자 수

(단위: 개소, 명, 백만 원, %)

건강보험 재택의료		도입시기	기관수		환자수		기관당 환자수	진료비
장애인 건강주치의		2018.5.	254	(13.0)	8,117	(3.2)	32.0	9,935
중증소아 재택의료		2019.1.	4	(0.2)	830	(0.3)	207.5	4,151
정신질환자 지속치료 지원		2020.1.	46	(2.3)	5,442	(2.1)	118.3	14,566
재활의료기관 수가		2023.1.	36	(1.8)	1,838	(0.7)	51.1	11,424
치매관리주치의		2024.7.	30	(1.5)	2,442	(1.0)	81.4	194
질환군별 재택의료 시범사업	복막투석	2019.12.	85	(4.3)	8,506	(3.3)	100.1	5,527
	1형 당뇨병	2020.1.	58	(3.0)	7,017	(2.8)	121.0	3,420
	가정용 인공호흡기	2020.5.	21	(1.1)	1,192	(0.5)	56.8	429
	심장질환자	2020.10.	38	(1.9)	7,045	(2.8)	185.4	2,905
	재활환자	2020.12.	65	(3.3)	11,506	(4.5)	177.0	1,679
	결핵환자	2021.10.	81	(4.1)	7,980	(3.1)	98.5	1,588
	암환자	2021.12.	42	(2.1)	6,052	(2.4)	144.1	1,045
	암환자(요로)	2022.12.	15	(0.8)	338	(0.1)	22.5	49
일차의료 방문진료 수가		2019.12.	339	(17.3)	32,783	(12.9)	96.7	17,336
일차의료 한의 방문진료 수가		2021.8.	946	(48.3)	12,330	(4.8)	13.0	17,552
가정간호		2001.1.	348	(17.8)	140,692	(55.2)	404.3	318,016
가정형 호스피스		2020.9.	45	(2.3)	14,904	(5.8)	331.2	24,575
전체			1,960	(100)	255,097	(100)	130.2	434,392

○ 재택의료 이용 환자는 여성이 59.3%, 건강보험 환자가 84.6%이며 평균연령은 69.5세임

- 1형 당뇨병 재택의료(95.4%) 와 중증소아 재택의료(95.2%) 참여자의 건강보험 환자 비율이 높으며, 장애인 건강주치의(51.4%)와 일차의료 한의 방문진료(36.7%) 환자가 의료급여 비율 가장 높음

- 일차의료 방문진료 환자의 평균연령이 81.5세로 가장 높으며 치매관리 주치의(80.9세), 일차의료 한의 방문진료(78.4세) 순임. 중증소아 재택의료 환자가 7.1세로 가장 어리며, 1형 당뇨병 40.3세, 정신질환 지속치료지원 41.9세임

〈표 48〉 건강보험 재택의료 이용 환자 일반현황

(단위: 명, 세, %)

건강보험 재택의료		성별				의료보장				평균 연령
		남성		여성		건강보험		의료급여		
장애인 건강주치의		4,606	(56.7)	3,511	(43.3)	4,108	(50.6)	4,169	(51.4)	59.9
중증소아 재택의료		434	(52.3)	396	(47.7)	790	(95.2)	50	(6.0)	7.1
정신질환자 지속치료 지원		2,688	(49.4)	2,754	(50.6)	3,894	(71.6)	1,666	(30.6)	41.9
재활의료기관 수가		731	(39.8)	1,107	(60.2)	1,678	(91.3)	164	(8.9)	71
치매관리주치의		791	(32.4)	1,651	(67.6)	2,038	(83.5)	407	(16.7)	80.9
질환군별 재택의료	복막투석	5,048	(59.3)	3,458	(40.7)	7,556	(88.8)	1,247	(14.7)	57.7
	1형 당뇨병	3,241	(46.2)	3,776	(53.8)	6,696	(95.4)	387	(5.5)	40.3
	가정용 인공호흡기	766	(64.3)	426	(35.7)	955	(80.1)	269	(22.6)	47.3
	심장질환자	3,511	(49.8)	3,534	(50.2)	6,474	(91.9)	663	(9.4)	71.3
	재활환자	3,203	(27.8)	8,303	(72.2)	10,678	(92.8)	862	(7.5)	71.6
	결핵환자	5,010	(62.8)	2,970	(37.2)	7,347	(92.1)	716	(9.0)	63.9
	암환자	3,682	(60.8)	2,370	(39.2)	5,628	(93.0)	497	(8.2)	63.2
	암환자(요루)	248	(73.4)	90	(26.6)	311	(92.0)	30	(8.9)	71.1
일차의료 방문진료 수가		12,102	(36.9)	20,681	(63.1)	25,050	(76.4)	7,915	(24.1)	81.5
일차의료 한의 방문진료 수가		3,899	(31.6)	8,431	(68.4)	7,874	(63.9)	4,531	(36.7)	78.4
가정간호		53,093	(37.7)	87,599	(62.3)	120,910	(85.9)	20,917	(14.9)	70.4
가정형 호스피스		7,874	(52.8)	7,030	(47.2)	14,047	(94.2)	890	(6.0)	71.7
전체		106,334	(41.7)	151,158	(59.3)	215,810	(84.6)	41,682	(16.3)	69.5

* 주. 의료보장별 환자수는 자격변동을 포함한 값으로 각 비율의 합이 100을 초과할 수 있음

○ 건강보험 재택의료 제공 기관의 소재지를 수도권(서울, 경기, 인천)과 비수도권으로 구분한 현황을 확인함. 재택의료 제공 기관의 50.2%가 수도권에 위치하여 전체 환자의 63.5%, 청구건수의 57.5%를 담당함

- 수도권 소재 기관 비율이 높은 재택의료는 중증소아 재택의료(75.0%)와 암환자(요루) 재택의료(73.3%) 순임. 수도권 환자 비율이 높은 재택의료는 암환자(요루) 재택의료(85.5%), 가정용 인공호흡기 환자 재택의료(84.3%), 1형 당뇨병 재택의료(82.1%) 순임
- 비수도권 소재 기관 비율이 높은 재택의료는 치매관리주치의(66.7%), 정신질환자 지속치료 지원(63.0%), 재활의료기관 수가(61.1%) 순임. 비수도권 환자 비율이 높은 재택의료는 재활환자 재택의료(60.3%), 치매관리 주치의(59.0%)순임

〈표 49〉 건강보험 재택의료 제공기관 소재유형별 일반 현황

(단위: 개소, 명, 건, %)

건강보험 재택의료		기관소재	기관수		환자수		청구건수	
장애인 건강주치의		수도권	139	(54.7)	3,943	(48.6)	41,627	(49.6)
		비수도권	115	(45.3)	4,176	(51.4)	42,357	(50.4)
중증소아 재택의료		수도권	3	(75.0)	551	(66.4)	24,467	(78.4)
		비수도권	1	(25.0)	279	(33.6)	6,751	(21.6)
정신질환자 지속치료 지원		수도권	17	(37.0)	2,546	(46.8)	29,479	(43.7)
		비수도권	29	(63.0)	2,900	(53.3)	37,963	(56.3)
재활의료기관 수가		수도권	14	(38.9)	1,165	(63.4)	11,756	(50.4)
		비수도권	22	(61.1)	673	(36.6)	11,585	(49.6)
치매관리주치의		수도권	10	(33.3)	1,002	(41.0)	1,876	(46.7)
		비수도권	20	(66.7)	1,440	(59.0)	2,138	(53.3)
질환군별 재택의료	복막투석	수도권	45	(52.9)	4,982	(58.6)	108,116	(58.8)
		비수도권	40	(47.1)	3,562	(41.9)	75,672	(41.2)
	1형 당뇨병	수도권	32	(55.2)	5,762	(82.1)	69,881	(82.2)
		비수도권	26	(44.8)	1,288	(18.4)	15,174	(17.8)
	가정용 인공호흡기	수도권	12	(57.1)	1,005	(84.3)	10,101	(75.4)
		비수도권	9	(42.9)	193	(16.2)	3,298	(24.6)
	심장질환자	수도권	24	(63.2)	3,057	(43.4)	42,005	(42.2)
		비수도권	14	(36.8)	3,991	(56.7)	57,603	(57.8)
	재활환자	수도권	36	(55.4)	4,575	(39.8)	11,820	(36.0)
		비수도권	29	(44.6)	6,939	(60.3)	20,982	(64.0)

(단위: 개소, 명, 건, %)

건강보험 재택의료		기관소재	기관수		환자수		청구건수	
질환군별 재택의료	결핵환자	수도권	40	(49.4)	3,532	(44.3)	22,162	(42.6)
		비수도권	41	(50.6)	4,459	(55.9)	29,917	(57.4)
	암환자	수도권	27	(64.3)	4,948	(81.8)	21,887	(73.0)
		비수도권	15	(35.7)	1,106	(18.3)	8,088	(27.0)
	암환자(요루)	수도권	11	(73.3)	289	(85.5)	1,153	(86.3)
		비수도권	4	(26.7)	49	(14.5)	183	(13.7)
일차의료 방문진료 수가		수도권	183	(54.0)	22,214	(67.8)	76,755	(62.9)
		비수도권	156	(46.0)	10,627	(32.4)	45,356	(37.1)
일차의료 한의 방문진료 수가		수도권	445	(47.0)	5,494	(44.6)	65,437	(36.3)
		비수도권	501	(53.0)	6,837	(55.5)	114,656	(63.7)
가정간호		수도권	208	(59.8)	98,456	(70.0)	1,434,503	(59.7)
		비수도권	140	(40.2)	42,796	(30.4)	966,924	(40.3)
가정형 호스피스		수도권	22	(48.9)	8,128	(54.5)	69,837	(49.8)
		비수도권	23	(51.1)	6,785	(45.5)	70,269	(50.2)
전체		수도권	984	(50.2)	161,936	(63.5)	2,042,834	(57.5)
		비수도권	976	(49.8)	94,120	(36.9)	1,508,899	(42.5)

○ 건강보험 재택의료는 참여 기관 중 의원(한의원 포함)이 78.4%로 가장 많은 비중을 차지하며, 상급종합병원 이용 환자 수와 청구 건수가 각각 36.9%, 37.3%로 가장 많음. 이는 상급종합병원에서 제공하는 질환군별 재택의료 이용 환자 수가 많은 영향임

- 장애인 건강주치의는 모든 종별구분에서 제공할 수 있으나 참여 기관의 85.0%가 의원이며, 의원을 통해 서비스를 받는 환자는 전체의 95.4%임. 치매관리 주치의는 의원의 비율이 63.3%로 높지만 병원과 종합병원도 각각 20.0%, 16.7%를 차지하며 종합병원 이용 환자 비율이 비교적 높다는 특징이 있음
- 정신질환자 지속치료 지원과 재활의료기관 수가는 각각 65.2%와 100%가 병원에서 제공됨

○ 가정간호 기본방문은 모든 종병이 비교적 고르게 참여하지만 전체의 8.9%인 상급종합병원 이용환자가 41.1%로 높은 수준임

〈표 50〉 건강보험 재택의료 제공 기관 종별 일반 현황

(단위: 개소, 명, 건, %)

건강보험 재택의료		종별구분	기관수		환자수		청구건수	
장애인 건강주치의		의원	216	(85.0)	7,045	(95.4)	81,845	(97.5)
		병원	21	(8.3)	228	(3.1)	1,579	(1.9)
		종합병원	16	(6.3)	86	(1.2)	522	(0.6)
		상급종합병원	1	(0.4)	27	(0.4)	38	(0.0)
중증소아 재택의료		상급종합병원	4	(100.0)	835	(100.0)	31,218	(100.0)
정신질환자 지속치료 지원		병원	30	(65.2)	4,799	(87.3)	60,130	(89.2)
		종합병원	5	(10.9)	64	(1.2)	582	(0.9)
		상급종합병원	11	(23.9)	634	(11.5)	6,730	(10.0)
재활의료기관 수가		병원	36	(100.0)	1,804	(100.0)	23,341	(100.0)
치매관리주치의		의원	19	(63.3)	1,124	(46.3)	1,948	(48.5)
		병원	6	(20.0)	421	(17.3)	837	(20.9)
		종합병원	5	(16.7)	883	(36.4)	1,229	(30.6)
질환군별 재택의료	복막투석	병원	39	(45.9)	2,429	(28.7)	42,290	(23.0)
		종합병원	5	(5.9)	4	(0.0)	17	(0.0)
		상급종합병원	41	(48.2)	6,028	(71.2)	141,481	(77.0)
	1형 당뇨병	병원	5	(8.6)	3	(0.0)	8	(0.0)
		종합병원	26	(44.8)	1,023	(15.0)	11,092	(13.0)
		상급종합병원	27	(46.6)	5,807	(85.0)	73,955	(86.9)
	가정용 인공호흡기	종합병원	7	(33.3)	37	(3.1)	73	(0.5)
		상급종합병원	14	(66.7)	1,148	(96.9)	13,326	(51.7)
	심장질환자	종합병원	14	(36.8)	1,230	(17.4)	12,454	(48.3)
		상급종합병원	24	(63.2)	5,821	(82.6)	87,154	(80.0)
	재활환자	병원	33	(50.8)	3,393	(29.5)	12,035	(11.1)
		종합병원	14	(21.5)	4,045	(35.1)	9,721	(8.9)
		상급종합병원	18	(27.7)	4,074	(35.4)	11,046	(28.4)
	결핵환자	병원	7	(8.6)	34	(0.5)	268	(0.7)
		종합병원	54	(66.7)	3,781	(53.1)	27,539	(70.9)
		상급종합병원	20	(24.7)	3,299	(0.0)	24,272	(78.1)
	암환자	병원	5	(11.9)	1	(0.0)	5	(0.0)
		종합병원	14	(33.3)	1,346	(22.2)	6,796	(21.9)
		상급종합병원	23	(54.8)	4,703	(77.7)	23,174	(98.6)

(단위: 개소, 명, 건, %)

건강보험 재택의료		종별구분	기관수		환자수		청구건수	
	암환자(요루)	종합병원	5	(33.3)	83	(25.5)	338	(1.4)
		상급종합병원	10	(66.7)	243	(74.5)	998	(0.8)
일차의료 방문진료 수가		의원	339	(100.0)	31,299	(100.0)	122,111	(99.2)
일차의료 한의 방문진료		한의원	946	(100.0)	6,750	(100.0)	180,093	(100.0)
가정간호 기본방문		의원	136	(39.1)	35,232	(23.5)	430,410	(17.9)
		병원	110	(31.6)	25,664	(17.1)	503,565	(21.0)
		종합병원	71	(20.4)	27,312	(18.2)	611,067	(25.4)
		상급종합병원	31	(8.9)	61,466	(41.1)	856,385	(35.7)
가정형 호스피스		의원	8	(17.8)	1,951	(13.0)	16,571	(11.8)
		병원	4	(8.9)	1,204	(8.0)	9,811	(7.0)
		종합병원	21	(46.7)	6,489	(43.1)	59,937	(42.8)
		상급종합병원	12	(26.7)	5,419	(36.0)	53,787	(38.4)
전체		의원	589	(30.1)	70,979	(26.7)	652,853	(18.4)
		한의원	946	(48.3)	12,330	(4.6)	180,093	(5.1)
		병원	231	(11.8)	35,298	(13.3)	611,593	(17.2)
		종합병원	147	(7.5)	49,116	(18.5)	783,636	(22.1)
		상급종합병원	47	(2.4)	98,108	(36.9)	1,323,558	(37.3)

○ 분석 기간을 2024년으로 제한하여 시범사업별 기관 수, 환자 수, 청구 건수를 확인함. 일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업 청구기관이 전체의 53.3%로 가장 많음. 환자 수는 가정간호 기본방문료 이용 환자와 청구 건수가 각 39.5%, 60.4%로 가장 많고 암환자(요루) 재택의료 시범사업 이용 환자와 청구 건수가 0.2%, 0.02%로 가장 적음

〈표 51〉 건강보험 재택의료 일반현황 (2024년 기준)

(단위: 개소, 명, 건, %)

건강보험 재택의료		기관수		환자수		청구건수	
장애인 건강주치의 시범사업		120	(8.7)	5,520	(5.5)	5,748	(5.5)
중증소아 재택의료 시범사업		4	(0.3)	524	(0.5)	1,317	(1.3)
정신질환자 지속치료 지원 시범사업		37	(2.7)	3,173	(3.2)	6	(0.0)
재활의료기관 수가 시범사업		34	(2.5)	1,080	(1.1)	6,155	(5.9)
치매관리주치의 시범사업		30	(2.2)	2,442	(2.5)	194	(0.2)
질환군별 재택의료	복막투석	72	(5.2)	4,596	(4.6)	1,191	(1.1)
	1형 당뇨병	48	(3.5)	447	(0.4)	960	(0.9)
	가정용 인공호흡기	8	(0.6)	544	(0.5)	85	(0.1)
	심장질환자	26	(1.9)	4,219	(4.2)	640	(0.6)
	재활환자	43	(3.1)	3,414	(3.4)	506	(0.5)
	결핵환자	56	(4.1)	2,952	(3.0)	431	(0.4)
	암환자	29	(2.1)	2,544	(2.6)	370	(0.4)
	암환자(요루)	14	(1.0)	214	(0.2)	25	(0.0)
일차의료 방문진료 수가 시범사업		258	(18.8)	19,736	(19.8)	9,821	(9.4)
일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업		731	(53.3)	8,238	(8.3)	9,586	(9.2)
가정간호 기본방문료		207	(15.1)	39,348	(39.5)	62,819	(60.4)
가정형 호스피스		39	(2.8)	2,588	(2.6)	4,165	(4.0)
총합계		1,372	(100)	99,618	(100)	104,019	(100)

○ 건강보험 재택의료 사업별로 참여환자의 상위 5개 주상병을 확인함. 알츠하이머에서의 치매가 15,486명(6.1%)으로 가장 많았으며, 본태성(원발성) 고혈압 11,945명, 만성 신장병 11,042명 순임. 상병이 특정되지 않은 일차의료 (한의)방문진료 환자 중 거동 불편에 영향을 미칠 것으로 예상되는 상병은 근골격계질환(등통증, 관절장애 등), 뇌경색증, 척추질환 등이 있음

〈표 52〉 건강보험 재택의료 사업별 주상병 (상위 5개)

(단위: 명, %)

건강보험 재택의료		주상병	환자수 (명)		주상병	환자수 (명)	
장애인 건강주치의		본태성(원발성) 고혈압	1,409	(17.4)	뇌경색증	360	(4.4)
		2형 당뇨병	707	(8.7)	전반발달장애	358	(4.4)
		하반신마비 및 사지마비	485	(6.0)	-		
중증소아 재택의료		뇌전증	159	(19.2)	신생아의 호흡곤란	71	(8.6)
		달리 분류되지 않은 호흡부전	89	(10.7)	심장중격의 선천기형	44	(5.3)
		뇌의 기타 장애	76	(9.2)	-		
정신질환자 지속치료 지원		조현병	1,609	(29.6)	우울에피소드	822	(15.1)
		알코올사용에 의한 정신 및 행동장애	1,153	(21.2)	조현정동장애	229	(4.2)
		양극성 정동장애	887	(16.3)	-		
재활의료기관 수가		대퇴골의 골절	612	(33.3)	편마비	107	(5.8)
		뇌경색증	466	(25.4)	근육의 기타 장애	62	(3.4)
		뇌내출혈	163	(8.9)			
치매관리주치의		알츠하이머병에서의 치매	2,342	(95.9)	달리 분류된 기타 질환에서의 치매	13	(0.5)
		상세불명의 치매	39	(1.6)	알츠하이머병	11	(0.5)
		혈관성 치매	33	(1.4)	-		
질환군별 재택의료	복막 투석	만성 신장병	8,422	(99.0)	복막염	48	(0.6)
		투석을 포함한 치료	244	(2.9)	2형 당뇨병	38	(0.4)
		기타 내부 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증	106	(1.2)	-		
	1형 당뇨병	1형 당뇨병	6,955	(99.1)	2형 당뇨병	29	(0.4)
		상세불명의 당뇨병	63	(0.9)	이식된 기관 및 조직의 상태	22	(0.3)
		췌장의 악성 신생물	36	(0.5)	-		
	가정용 인공 호흡기	달리 분류되지 않은 호흡부전	838	(70.3)	기타 만성 폐쇄성 폐질환	41	(3.4)
		근육의 원발성 장애	302	(25.3)	척주측만증	36	(3.0)
		척수성 근위축 및 관련 증후군	231	(19.4)	-		
	심장 질환자	방실차단 및 좌각차단	2,301	(32.7)	심방세동 및 조동	970	(13.8)
		기타 심장부정맥	2,234	(31.7)	심근병증	749	(10.6)
		심장 및 혈관 삽입물 및 이식편의 존재	1,050	(14.9)	-		

(단위: 명, %)

건강보험 재택의료		주상병	환자수		주상병	환자수	
질환군별 재택의료	재활환자	무릎관절증	4,052	(35.2)	뇌경색증	994	(8.6)
		대퇴골의 골절	3,083	(26.8)	골괴사	660	(5.7)
		기타 관절증	2,045	(17.8)	-		
	결핵환자	세균학적 및 조직학적으로 확인된 호흡기결핵	4,315	(54.1)	폐의 진단영상검사상 이상소견	128	(1.6)
		세균학적으로나 조직학적으로 확인되지 않은 호흡기결핵	3,429	(43.0)	좁쌀결핵	67	(0.8)
		기타 기관의 결핵	371	(4.6)	-		
	암환자	직장의 악성 신생물	3,403	(56.2)	난소의 악성 신생물	259	(4.3)
		결장의 악성 신생물	932	(15.4)	의심되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가, 배제된	209	(3.5)
		직장구불결장접합부의 악성 신생물	327	(5.4)	-		
	암환자 (요루)	방광의 악성 신생물	266	(78.7)	결장의 악성 신생물	8	(2.4)
		전립선의 악성 신생물	19	(5.6)	기타 및 상세불명의 비뇨기관의 악성 신생물	8	(2.4)
		직장의 악성 신생물	13	(3.8)	-		
일차의료 방문진료 수가		알츠하이머병에서의 치매	6,016	(18.4)	2형 당뇨병	1,695	(5.2)
		본태성(원발성) 고혈압	4,540	(13.8)	뇌경색증	1,308	(4.0)
		상세불명의 치매	1,736	(5.3)	-		
일차의료 한의 방문진료 수가		등통증	3,377	(27.4)	달리 분류되지 않은 기타 관절장애	991	(8.0)
		요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장	1,496	(12.1)	기타 척추병증	849	(6.9)
		달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	1,196	(9.7)	-		
가정간호		알츠하이머병에서의 치매	7,442	(5.3)	수분, 전해질 및 산-염기균형의 기타 장애	5,339	(3.8)
		2형 당뇨병	6,853	(4.9)	기관지 및 폐의 악성 신생물	4,634	(3.3)
		본태성(원발성) 고혈압	6,419	(4.6)	-		
가정형 호스피스		기관지 및 폐의 악성 신생물	2,475	(16.6)	간 및 간내 담관의 악성 신생물	1,394	(9.4)
		췌장의 악성 신생물	1,766	(11.8)	결장의 악성 신생물	1,271	(8.5)
		위의 악성 신생물	1,430	(9.6)	-		
전체		알츠하이머병에서의 치매	15,486	(6.1)	2형 당뇨병	9,065	(3.6)
		본태성(원발성) 고혈압	11,945	(4.7)	무릎관절증	8,824	(3.5)
		만성 신장병	11,042	(4.3)	-		

* 주. 환자는 하나 이상의 주상병을 가질 수 있어 비율의 합은 100을 초과할 수 있음

3. 재택의료 제공 및 이용 현황

가. 제공 및 이용 현황

○ (재택의료 참여 개수별 환자 현황) 재택의료 사업 개수에 따른 이용 현황을 분석함. 분석 기간 동안 1개 재택의료만 이용한 환자가 전체의 97.4%로 가장 많았음. 2개의 재택의료 이용은 4.3%, 3개 이용 0.2% 순임

- 분석 대상인 17개 재택의료가 모두 시행된 2024년에는 전체의 94.7%(94,296명)가 1개의 재택의료 서비스만을 이용함

〈표 53〉 연간 건강보험 재택의료 이용 현황별 환자 수

(단위: 명, %)

연도	건강보험 재택의료 이용 개수										합계	
	1개		2개		3개		4개		5개			
2018	14,086	(99.6)	57	(0.4)	-	-	-	-	-	-	14,143	(100)
2019	20,793	(99.4)	120	(0.6)	-	-	-	-	-	-	20,913	(100)
2020	42,991	(98.0)	862	(2.0)	27	(0.1)	1	(0.0)	-		43,881	(100)
2021	54,683	(97.1)	1,600	(2.8)	50	(0.1)	2	(0.0)	-	-	56,335	(100)
2022	67,711	(96.8)	2,172	(3.1)	91	(0.1)	4	(0.0)	-	-	69,978	(100)
2023	77,024	(95.6)	3,393	(4.2)	158	(0.2)	3	(0.0)	-	-	80,578	(100)
2024	94,296	(94.7)	5,034	(5.1)	275	(0.3)	12	(0.0)	1	(0.0)	99,618	(100)
합계	241,837	(97.4)	10,848	(4.3)	520	(0.2)	18	(0.0)	1	(0.0)	255,097	(100)

* 주. 총합계 환자 수는 중복제거 값으로 시범사업과 가정간호, 호스피스 사업을 모두 포함함

○ (단일사업 이용 환자) 2024년 1개 사업 이용 환자는 가정간호 기본방문(35,372명, 37.5%), 일차의료 방문진료 수가 시범사업(15.587명, 16.5%) 등 순으로 많이 이용함

〈표 54〉 재택의료 단일 이용환자의 참여 사업 현황 (2023년, 2024년)

(단위: 명, %)

건강보험 재택의료		2023		2024	
		환자수		환자수	
장애인 건강주치의 시범사업		2,241	(2.9)	4,351	(4.6)
중증소아 재택의료 시범사업		411	(0.5)	510	(0.5)
정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리		1,940	(2.5)	3,171	(3.4)
재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활		840	(1.1)	909	(1.0)
치매관리주치의 시범사업		-	-	2,329	(2.5)
질환군별 재택의료 시범사업	복막투석 환자	4,675	(6.1)	4,537	(4.8)
	1형 당뇨병 환자	3,797	(4.9)	4,445	(4.7)
	가정용 인공호흡기 환자	543	(0.7)	419	(0.4)
	심장질환자	4,859	(6.3)	4,177	(4.4)
	재활환자	3,026	(3.9)	3,248	(3.4)
	결핵환자	3,427	(4.4)	2,932	(3.1)
	암환자	2,955	(3.8)	2,372	(2.5)
	암환자(요루)	166	(0.2)	183	(0.2)
일차의료 방문진료 수가 시범사업		8,496	(11.0)	15,587	(16.5)
일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업		3,669	(4.8)	7,466	(7.9)
가정간호		33,814	(43.9)	35,372	(37.5)
가정형 호스피스		2,165	(2.8)	2,288	(2.4)
총계		77,024	(100.0)	94,296	(100.0)

○ (2개 사업 이용 환자) 2024년 2개 사업 이용환자 5,034명이 가장 많이 참여한 사업 조합은 가정간호 기본방문과 일차의료 방문진료 수가 시범사업으로 2,490명(49.5%)이 이용함. 두 번째로 많은 조합은 일차의료 방문진료 수가 시범사업과 장애인 건강주치의 시범사업 동시 이용으로 대상 환자는 654명임

- 재택의료를 제공한 의료기관 수에 따라 단일기관, 2개 기관, 3개 이상으로 구분함
- 가정간호 기본방문과 일차의료 방문진료 이용환자의 57.6%를 하나의 의료기관에서 제공함. 이러한 기관 수는 25개소임. 환자 수를 기준으로 동일 환자에게 2개의 재택의료를 2개 기관에서 제공하는 비율은 38.5%, 3개 이상의 의료기관인 경우는 3.9%임
- 의사 단독방문인 일차의료 방문진료와 의사 방문이 포함된 장애인 건강주치의를 동시에 이용하는 환자는 645명임. 이 중 95.1%에게 한 기관에서 제공하며 이러한 기관 수는 51개소임
- 가정간호 기본방문과 간호사 등 동반인력 가산 기준이 없는 일차의료 한의 방문진료를 하나의 기관에서 동시 제공받는 환자는 없으며, 91.6%가 2개 기관을 이용함

〈표 55〉 2024년 2개 사업 이용 환자 조합별 현황

(단위: 개소, 명, %)

사업조합			환자수		제공 형태			
					제공기관 유형	기관수	환자수	
가정간호	x	일차의료 방문진료	2,490	(49.5)	단일기관	25	1,435	(57.6)
					2개 기관	229	959	(38.5)
					3개 이상	120	96	(3.9)
일차의료 방문진료	x	장애인 건강주치의	654	(13.0)	단일기관	51	622	(95.1)
					2개 기관	28	31	(4.7)
					3개 이상	3	1	(0.2)
가정간호	x	일차의료 한의 방문진료	357	(7.1)	단일기관	-	-	-
					2개 기관	218	327	(91.6)
					3개 이상	54	30	(8.4)
가정간호	x	장애인 건강주치의	311	(6.2)	단일기관	14	110	(35.4)
					2개 기관	108	186	(59.8)
					3개 이상	32	15	(4.8)
일차의료 방문진료	x	일차의료 한의 방문진료	242	(4.8)	단일기관	-	-	-
					2개 기관	166	230	(95.0)
					3개 이상	31	12	(5.0)
가정간호	x	가정형 호스피스	221	(4.4)	단일기관	15	72	(32.6)
					2개 기관	76	141	(63.8)
					3개 이상	19	8	(3.6)

(단위: 개소, 명, %)

사업조합			환자수		제공 형태			
					제공기관 유형	기관수	환자수	
재활의료기관	x	재활환자 재택의료	127	(2.5)	단일기관	10	124	(97.6)
					2개 기관	6	3	(2.4)
					3개 이상	–	–	–
가정간호	x	암환자(장루) 재택의료	118	(2.3)	단일기관	15	75	(63.6)
					2개 기관	41	41	(34.7)
					3개 이상	5	2	(1.7)
가정간호	x	가정용인공호흡기 재택의료	89	(1.8)	단일기관	2	27	(30.3)
					2개 기관	35	59	(66.3)
					3개 이상	5	3	(3.4)
일차의료 방문진료	x	치매관리주치의	72	(1.4)	단일기관	2	56	(77.8)
					2개 기관	17	15	(20.8)
					3개 이상	3	1	(1.4)
일차의료 방문진료	x	가정형 호스피스	31	(0.6)	단일기관	–	–	–
					2개 기관	38	31	(100)
					3개 이상	–	–	–
일차의료 한의 방문진료	x	장애인 건강주치의	29	(0.6)	단일기관	–	–	–
					2개 기관	24	28	(96.6)
					3개 이상	3	1	(3.4)
가정간호	x	복막투석 재택의료	21	(0.4)	단일기관	10	17	(81.0)
					2개 기관	7	4	(19.0)
					3개 이상	–	–	–
가정간호	x	치매관리주치의	21	(0.4)	단일기관	1	1	(4.8)
					2개 기관	12	20	(95.2)
					3개 이상	–	–	–
암환자(요루) 재택의료	x	암환자(장루) 재택의료	17	(0.3)	단일기관	8	17	(100)
					2개 기관	–	–	–
					3개 이상	–	–	–
가정간호	x	재활환자 재택의료	16	(0.3)	단일기관	2	4	(25.0)
					2개 기관	17	12	(75.0)
					3개 이상	–	–	–
가정간호	x	재활의료기관	14	(0.3)	단일기관	–	–	–
					2개 기관	17	12	(85.7)
					3개 이상	7	2	(14.3)
가정간호	x	심장질환자 재택의료	14	(0.3)	단일기관	7	9	(64.3)
					2개 기관	10	5	(35.7)
					3개 이상	–	–	–
암환자(요루) 재택의료	x	가정형 호스피스	14	(0.3)	단일기관	1	1	(7.1)
					2개 기관	16	13	(92.9)
					3개 이상	–	–	–
일차의료 방문진료	x	재활의료기관	13	(0.3)	단일기관	–	–	–
					2개 기관	15	13	(100)
					3개 이상	–	–	–
기타 49개 조합			163	(3.2)	–	–	–	–
합계			5,034	(100)	–	–	–	–

* 주. 제공 서비스에 중복이 있는 사업별 조합은 밑줄로 표기함

○ 환자 수가 가장 많은 상위 2개 조합의 청구현황을 확인함. 가정간호 기본방문과 일차의료 방문진료를 동시에 이용한 2,490명은 2024년 1년간 평균 가정간호 기본방문 15.4회, 일차의료 방문진료 3.9회를 청구함. 최대 가정간호 기본방문 353회, 일차의료 방문진료 66회 청구한 사례도 확인됨. 의사방문 서비스에 중복이 있는 일차의료 방문진료와 장애인 건강주치의는 평균 일차의료 방문진료 5.7회, 장애인 건강주치의 9.4회를 이용함

〈표 56〉 2024년 2개 사업 이용 환자 조합별 청구현황

(단위: 회)

사업조합			평균	최대	중위	최소
가정간호	x	일차의료 방문진료	15.4 x 3.9	353 x 66	2 x 6	1 x 1
일차의료 방문진료	x	장애인 건강주치의	5.7 x 9.4	267 x 34	2 x 7	1 x 1

* 주. 제공 서비스에 중복이 있는 사업별 조합은 밑줄로 표기함

○ 환자 특성에 따른 이용 파악을 위해 재활 서비스 이용, 암·치매 환자의 재택의료 중복이용 현황을 제한적으로 확인함

- (재활필요 환자) 장애인 건강주치의, 재활의료기관, 재활 재택의료 시범사업 참여자를 재활필요 환자로 정의함. 전체 현황과 상위 5개 조합 중 장애인 건강주치의-일차의료 방문진료와 장애인 건강주치의-가정간호 조합이 일치함

〈표 57〉 2024년 재활필요 환자 2개 사업 이용 조합별 현황

(단위: 개소, 명, %)

사업조합			환자수		제공 형태			
					제공기관 유형	기관수	환자수	
장애인 건강주치의	x	일차의료 방문진료	654	(57.5)	단일기관	51	622	(95.1)
					2개 기관	28	31	(4.7)
					3개 이상	3	1	(0.2)
장애인 건강주치의	x	가정간호	311	(27.4)	단일기관	14	110	(35.4)
					2개 기관	108	186	(59.8)
					3개 이상	32	15	(4.8)
재활환자 재택의료	x	재활의료기관 수가	127	(11.2)	단일기관	10	124	(97.6)
					2개 기관	6	3	(2.4)
					3개 이상	-	-	-
장애인 건강주치의	x	일차의료 한의 방문진료	29	(2.6)	단일기관	-	-	-
					2개 기관	24	28	(96.6)
					3개 이상	3	1	(3.4)
재활환자 재택의료	x	가정간호	16	(1.4)	단일기관	2	4	(25.0)
					2개 기관	17	12	(75.0)
					3개 이상	-	-	-

- (암환자) 주·부상병으로 1회 이상 암(C00-C97, D00-D47)으로 청구한 이력이 있는 환자로 정의함. 전체 현황과 상위 5개 조합 중 가정간호-일차의료 방문진료, 가정간호-일차의료 한의 방문진료 2개 조합이 일치함

〈표 58〉 2024년 암환자 2개 사업 이용 조합별 현황

(단위: 개소, 명, %)

사업조합			환자수		제공 형태			
					제공기관 유형	기관수	환자수	
가정간호	x	일차의료 방문진료	481	(54.0)	단일기관	23	227	(47.2)
					2개 기관	115	187	(38.9)
					3개 이상	44	17	(3.5)
가정간호	x	가정형 호스피스	220	(24.7)	단일기관	15	72	(32.7)
					2개 기관	75	140	(63.6)
					3개 이상	19	8	(3.6)
가정간호	x	암환자(장루) 재택의료	118	(13.2)	단일기관	15	75	(63.6)
					2개 기관	41	41	(34.7)
					3개 이상	5	2	(1.7)
가정간호	x	일차의료 한의 방문진료	41	(4.6)	단일기관	-	-	-
					2개 기관	49	37	(90.2)
					3개 이상	10	3	(7.3)
일차의료 방문진료	x	가정형 호스피스	31	(3.5)	단일기관	-	-	-
					2개 기관	38	31	(100)
					3개 이상	-	-	-

- (치매환자) 주·부상병으로 1회 이상 치매(F00-F03, G30-G31)로 청구한 이력이 있는 환자로 정의함. 전체 현황과 상위 5개 조합 중 가정간호-일차의료 방문진료, 일차의료 방문진료-장애인 건강주치의, 일차의료 방문진료-일차의료 한의 방문진료 3개 조합이 일치함

〈표 59〉 2024년 암환자 2개 사업 이용 조합별 현황

(단위: 개소, 명, %)

사업조합			환자수		제공 형태			
					제공기관 유형	기관수	환자수	
가정간호	x	일차의료 방문진료	915	(74.6)	단일기관	21	537	(58.7)
					2개 기관	161	341	(37.3)
					3개 이상	68	37	(4.0)
일차의료 방문진료	x	장애인 건강주치의	91	(7.4)	단일기관	22	82	(90.1)
					2개 기관	6	8	(8.8)
					3개 이상	3	1	(1.1)
일차의료 방문진료	x	일차의료 한의 방문진료	77	(6.3)	단일기관	-	-	-
					2개 기관	83	74	(96.1)
					3개 이상	9	3	(3.9)
일차의료 방문진료(의과)	x	치매관리주치의 시범사업	72	(5.9)	단일기관	2	56	(77.8)
					2개 기관	17	15	(20.8)
					3개 이상	3	1	(1.4)
가정간호	x	일차의료 한의 방문진료	71	(5.8)	단일기관	-	-	-
					2개 기관	56	61	(85.9)
					3개 이상	26	10	(14.1)

○ (재택의료 참여 개수별 의료기관 현황) 재택의료 제공 의료기관은 분석대상인 17개 재택의료 중 1개만 제공한 기관이 2024년 기준 전체의 85.9%(1,178개)로 가장 많았음. 2023년 하나의 의료기관이 10개 재택의료를 제공한 사례가 확인됨. 해당 기관은 종합병원으로 가정간호-장애인 건강주치의 시범사업-7개의 질환군별 재택의료 시범사업(1형당뇨, 결핵환자, 복막투석, 심장질환자, 암환자 요루, 암환자 장루, 재활환자)-가정형 호스피스를 제공함

〈표 60〉 연간 건강보험 재택의료 제공 현황별 의료기관 수

(단위: 개소)

연도	건강보험 재택의료 제공 개수										합계
	1개	2개	3개	4개	5개	6개	7개	8개	9개	10개	
2018	219	17	-	-	-	-	-	-	-	-	236
2019	235	36	-	-	-	-	-	-	-	-	271
2020	261	64	21	7	4	-	-	-	-	-	357
2021	571	42	35	12	11	7	2	1	-	-	681
2022	687	61	29	16	11	5	7	1	1	0	818
2023	1,021	100	34	11	10	5	4	5	-	1	1,191
2024	1,178	115	40	15	12	3	3	3	3	-	1,372
(비율)	(85.9)	(8.4)	(2.9)	(1.1)	(0.9)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	-	(100.0)
총합계	1,711	147	50	13	18	8	6	1	3	1	1,960
(비율)	(87.3)	(7.5)	(2.6)	(0.7)	(0.9)	(0.4)	(0.3)	(0.1)	(0.2)	(0.1)	(100.0)

* 총합계는 중복제거 기관 수로 시범사업과 가정간호, 호스피스 사업을 모두 포함

○ (단일사업 제공 의료기관) 2024년 기준 1개 재택의료 제공 의료기관은 일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업이 713개소(60.5%)로 가장 많음

〈표 61〉 2024년 1개 재택의료 제공 현황 및 기관 수

(단위: 개소, %)

건강보험 재택의료	기관수	비율
일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업	713	(60.5)
일차의료 방문진료 수가 시범사업	175	(14.9)
가정간호	117	(9.9)
기타 10개 사업	173	(14.7)
합계	1,178	(100.0)

○ (2개 사업 제공 의료기관) 2개 재택의료 제공 기관은 일차의료 방문진료와 장애인 건강주치를 함께 제공한 경우가 54개소(47.0%)로 가장 많았으며, 가정간호-일차의료 방문진료 시범사업 제공 기관 10개소(8.7%), 가정간호-질환군별 재택의료 시범사업(결핵환자) 8개소(7.0%) 순임

〈표 62〉 2024년 2개 재택의료 제공 현황 및 기관 수

(단위: 개소, %)

사업조합	기관수	비율
일차의료 방문진료 x 장애인 건강주치의	54	(47.0)
가정간호 x 일차의료 방문진료	10	(8.7)
가정간호 x 결핵환자 재택의료	8	(7.0)
기타 20개 사업조합	43	(37.4)
합계	115	(100.0)

○ (3개 사업 제공 의료기관) 가정간호-일차의료 방문진료-장애인 건강주치의를 함께 제공한 경우가 15개소(37.5%)로 가장 많았으며, 재활의료기관 수가-1형 당뇨 재택의료-재활환자 재택의료 2개소(5.0%), 가정간호-복막투석환자 재택의료-심장질환자 재택의료 2개소(5.0%) 순임

〈표 63〉 2024년 3개 재택의료 제공 현황 및 기관 수

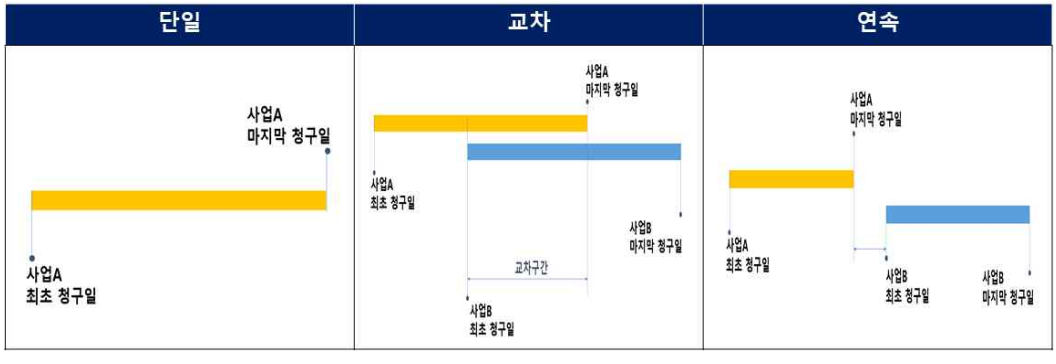
(단위: 개소, %)

사업조합	기관수	비율
가정간호 x 일차의료 방문진료 x 장애인 건강주치의	15	(37.5)
가정간호 x 복막투석 재택의료 x 심장질환자 재택의료	2	(5.0)
재활의료기관 수가 x 1형당뇨 재택의료 x 재활환자 재택의료	2	(5.0)
기타 21개 사업조합	21	(52.5)
합계	40	(100.0)

나. 재택의료 이용 및 제공 유형

○ 2018년 5월부터 2024년 12월까지 재택의료 시범사업별 최초 청구일부터 마지막 청구일을 하나의 에피소드로 하여 에피소드 중첩이 있는 경우는 '교차이용' , 중첩이 없는 경우는 '연속이용'으로 정의하여 현황을 확인함

- (단일) 전체 기간 동안 1개 재택의료 서비스 이용
- (교차) 기간의 중첩이 있는 연간 2개 이상 재택의료 서비스의 이용
- (연속) 기간의 중첩이 없는 연간 2개 이상 재택의료 서비스의 이용



[그림 14] 재택의료 단일, 교차, 연속 이용 정의

○ (유형별 일반 현황) 단일 사업 이용을 제외한 모든 환자는 사업 조합별로 교차, 연속 사례를 모두 경험할 수 있음. 단일 이용 환자가 전체의 94.6%로 가장 많으며, 연속 이용 환자 2.7%, 교차 이용 환자 2.6% 순임. 유형별 에피소드 수 또한 환자 수와 동일하게 단일, 연속, 교차 순으로 확인됨

- 재택의료 사업을 단일 이용하는 환자의 평균연령이 69.9세로 가장 적으며, 교차/연속 이용 환자의 연령은 각각 75.5세, 75.3세로 단일 이용 환자보다 유사하게 많음
- 재택의료 사업 이용 시 청구된 다빈도 주상병 상위 5개를 이용 유형별 확인한 결과, 교차 이용 환자의 경우 2형 당뇨병, 등통증, 본태성(원발성) 고혈압, 뇌경색증, 척수성 근위축 및 관련 증후군 순으로 나타남. 이 중 거동불편에 영향을 미칠 것으로 여겨지는 상병은 무릎관절증, 뇌경색, 척수근위축 및 관련 증후군 등임

〈표 64〉 재택의료 이용 및 제공 유형별 일반현황

(단위: 명, 건, 세, %)

구분	환자수		에피소드 수		평균 연령	다빈도 주상병
단일	241,837	(94.6)	241,837	(88.1)	69.9	등통증(22.8%), 만성 신장병(20.9%), 2형 당뇨병(20.0%), 무릎관절증(18.7%), 본태성 고혈압(17.6%)
교차	6,690	(2.6)	16,202	(5.9)	75.3	2형 당뇨병(23.8%), 등통증(23.0%), 본태성 고혈압(19.2%), 뇌경색증(18.6%), 척수 근위축 및 관련 증후군(15.4%)
연속	6,988	(2.7)	16,350	(6.0)	75.5	등통증(24.5%), 2형 당뇨병(23.7%), 원태성 고혈압(19.1%), 뇌경색증(17.7%), 기관지 및 폐의 악성신생물(15.0%)
총합계	255,097	(100.0)	274,839	(100.0)	70.2	-

* 총합계 환자 수는 중복제거 값
* 평균 연령은 환자별 마지막 청구 기준 산출

○ (교차, 연속 유형별 사업) 교차, 연속 이용에 해당하는 상위 5개 건강보험 재택의료는 교차, 연속 이용 모두 가정간호 기본방문, 일차의료 방문진료 수가 시범사업, 일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업, 가정형 호스피스, 장애인 건강주치의 시범사업임

- 가정형 호스피스는 교차이용보다 연속이용 사례가 많으며, 가정간호 기본방문과 일차의료 방문진료 수가 시범사업은 교차, 연속 이용 모두에서 상위에 해당하여 동시 혹은 종료 이후 유기적으로 제공되고 있는 것으로 확인됨

〈표 65〉 재택의료 교차, 연속 이용 유형별 관여 사업 (상위 5개)

교차		연속	
건강보험 재택의료	에피소드 건수	건강보험 재택의료	에피소드 건수
가정간호	6,327	가정간호	6,295
일차의료 방문진료 수가 시범사업	5,333	일차의료 방문진료 수가 시범사업	4,432
장애인 건강주치의 시범사업	1,649	가정형 호스피스	1,750
일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업	1,011	장애인 건강주치의 시범사업	1,178
가정형 호스피스	390	일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업	1,082

* 주. 에피소드 수(예시): A사업과 B사업 이용 기간에 중첩이 발생한 경우 A사업과 B사업 각각 교차 에피소드 1건 씩 발생한 것으로 계산

○ (단일 이용) 가정간호 기본방문 이용 환자가 전체의 53.7%로 가장 많았으며, 일차의료 방문진료 수가 시범사업, 가정형 호스피스, 재활환자 재택의료 시범사업 순임

〈표 66〉 단일 재택의료 이용 환자의 사업별 참여 현황

(단위: 명, %)

사업	환자수	
가정간호	129,804	(53.7)
일차의료 방문진료 수가 시범사업	24,476	(10.1)
가정형 호스피스	12,957	(5.4)
재활환자 재택의료 시범사업	11,053	(4.6)
일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업	10,793	(4.5)
복막투석 재택의료 시범사업	8,297	(3.4)
결핵환자 재택의료 시범사업	7,853	(3.2)
심장질환자 재택의료 시범사업	6,898	(2.9)
1형 당뇨 재택의료 시범사업	6,897	(2.9)
장애인 건강주치의 시범사업	6,199	(2.6)
암환자(장루) 재택의료 시범사업	5,506	(2.3)
정신질환자 지속치료 지원 시범사업	5,423	(2.2)
치매관리주치의 시범사업	2,300	(1.0)
재활의료기관 수가 시범사업	1,570	(0.6)
가정용 인공호흡기 재택의료 시범사업	808	(0.3)
중증소아 재택의료 시범사업	727	(0.3)
암환자(요루) 재택의료 시범사업	276	(0.1)
총계	241,837	(100.0)

○ (교차 이용) 재택의료 교차 이용 시, 유사 서비스 및 상호보완적 서비스 이용 현황을 확인함. 교차 이용환자 6,690명은 평균적으로 약 6개월 (182.6일) 교차 이용 함

- 최소 2개~최대 4개 사업을 교차 이용하며, 상위 15개 교차 이용 사례가 전체의 92.6%로 대부분을 차지함. 2개 교차 이용 시 일차의료 방문진료 수가 시범사업과 가정간호 기본방문 조합인 환자가 51.8%로 가장 많으며, 교차 기간 동안 평균 12.7일 간격으로 서비스를 이용함
- 의사가 방문이 포함된 일차의료 방문진료 수가 시범사업과 장애인 건강주치의 조합이 두 번째로 많이 이용되었으며, 평균 11.9일 간격으로 서비스를 이용함

〈표 67〉 교차 재택의료 이용 환자의 참여 사업 (상위 15개)

(단위: 명, 일, %)

사업	환자수		제공간격
일차의료 방문진료 x 가정간호	3,468	(51.8)	12.7
일차의료 방문진료 x 장애인 건강주치의	449	(6.7)	11.9
장애인 건강주치의 x 가정간호	397	(5.9)	8.4
일차의료 한의 방문진료 x 가정간호	341	(5.1)	3.8
재활환자 재택의료 x 일차의료 방문진료 x 가정간호	276	(4.1)	-
가정형 호스피스 x 가정간호	249	(3.7)	2.4
가정용 인공호흡기 재택의료 x 가정간호	220	(3.3)	10.2
암환자(장루) 재택의료 x 가정간호	168	(2.5)	5.0
일차의료 방문진료 x 일차의료 한의 방문진료	168	(2.5)	5.9
장애인 건강주치의 x 일차의료 한의 방문진료 x 가정간호	134	(2.0)	-
재활의료기관 수가 x 재활환자 재택의료	110	(1.6)	4.9
일차의료 방문진료 x 일차의료 한의 방문진료 x 가정형 호스피스	74	(1.1)	-
복막투석 재택의료 x 가정간호	58	(0.9)	13.1
재활환자 재택의료 x 가정간호	43	(0.6)	10.0
치매관리주치의 x 일차의료 방문진료	37	(0.6)	17.9
기타 77개 교차 이용 조합	422	(6.3)	-
총 합계	6,690	(100.0)	

* 주. 총 합계 환자수는 교차 이용만을 경험한 환자 수를 제공간격은 사업의 교차 기간 동안 사업별 서비스 간격을 의미

- 동일 환자에게 여러 기관이 재택의료를 제공할 수 있어 한 명의 환자에게 2개 이상 의료기관이 기관 수 이상의 재택의료 서비스를 제공하는 현황을 확인함. 교차 이용 환자 6,690명 중 4,851명(29.5%)이 단일기관으로부터 평균 1.6개 사업을 제공받으며, 나머지 72.5%(1,975명)가 다기관으로부터 평균2.2개 사업을 제공받음

〈표 68〉 이용 유형별 일반현황

(단위: 개, 명, %)

기관 유형	재택의료 사업 수	환자 수	
단일기관	1.6	4,851	(29.5)
다기관	2.2	1,975	(72.5)
총합계	-	6,690	(100.0)

* 주. 총합계 환자 수는 중복제거 값

○ (연속 이용) 연속 이용을 경험한 환자 6,988명임. 연속 이용 환자의 상위 10개 이용 사례가 전체의 92.8%로 대부분을 차지함

- 2개 사업 연속 이용 시 일차의료 방문진료 수가 시범사업과 가정간호 기본방문 조합 이용 환자 수가 전체의 40.7%이며, 평균 218.5일 간격을 두고 이용한 것으로 나타남
- 다음으로 가정간호 기본방문과 가정형 호스피스가 연속으로 많이 이용됨. 환자는 평균 130.9일의 간격을 두고 이용함

〈표 69〉 연속 이용 환자의 참여 사업 (상위 10개)

(단위: 명, %, 일)

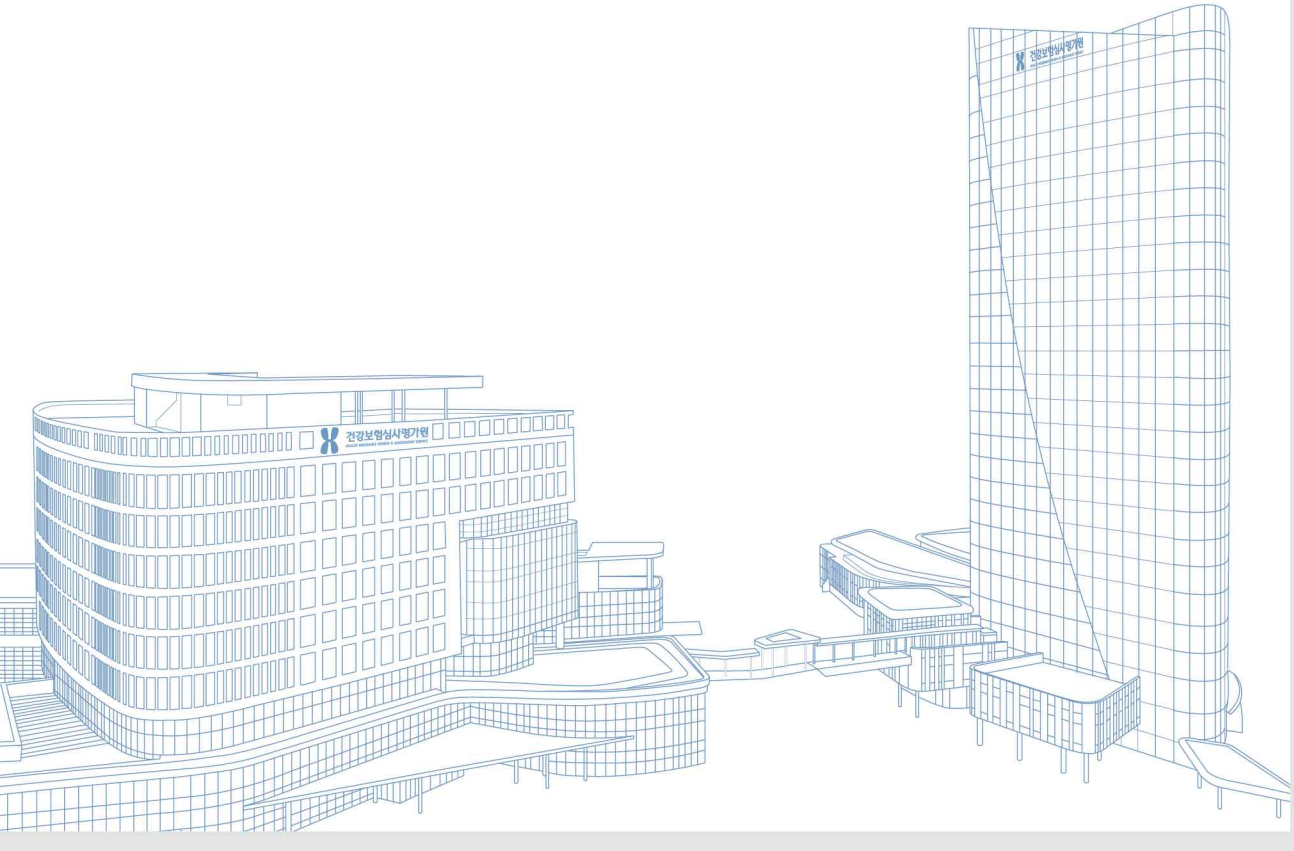
사업	환자수		제공간격
가정간호 x 일차의료 방문진료	2,842	(40.7)	218.5
가정간호 x 가정형 호스피스	1,503	(21.5)	130.9
일차의료 방문진료 x 장애인 건강주치의	528	(7.6)	130.1
가정간호 x 일차의료 한의 방문진료	463	(6.6)	427.3
일차의료 방문진료 x 일차의료 한의 방문진료	392	(5.6)	239.2
가정간호 x 장애인 건강주치의	283	(4.0)	586.2
가정간호 x 암환자(장루) 재택의료	208	(3.0)	201.1
일차의료 방문진료 x 호스피스	106	(1.5)	108.4
암환자(장루) 재택의료 x 호스피스	83	(1.2)	167.8
재활의료기관 x 재활환자 재택의료	75	(1.1)	56.1
기타 79개 연속 이용 조합	1,015	(7.2)	-
총합계	6,988	(100.0)	

* 주. 간격은 연속 사업 간 제공 간격을 의미

HIRA
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

제5장

건강보험 재택의료에 대한 인식 및 개선의견



제5장 건강보험 재택의료에 대한 인식 및 개선의견

1. 일대일 심층 면접(IDI) 방법

○ 건강보험 재택의료에 대한 다양한 이해관계자의 인식을 심층적으로 탐색하고 실효성 있는 정책적 시사점을 도출하기 위해 일대일 심층 면접(In-Depth Interview)을 수행함

- 본 심층 면접을 통해 현재 재택의료 제공 및 이용 현황을 파악하고, 서비스 개선 방안과 포괄모형에서 제안해야 할 서비스 수준, 수가 및 기준 마련에 대한 의견을 수렴하여 정책적 대안을 제시하고자 함

○ (기간 및 방법) 2025년 5월 29일부터 7월10일까지 연구책임자가 참여자와 1:1 대면 심층 면접을 실시함

○ (질문지 개발) 건강보험 재택의료 정책개발과 논의에 참여한 경험이 있는 전문가 2명에게 자문회의와 예비조사(Pilot test)를 실시하였고, 그 결과를 반영한 심층 면접 질문지를 개발함

○ (연구팀 구성) 연구팀은 총 4명으로 보건학과 경제학을 전공한 심사평가원 소속의 급여정책분야 연구자 3인과 의학교수 1인으로 구성함

○ (참여자) 면접 참여자는 건강보험 재택의료의 다양한 측면을 경험한 4개 집단의 이해관계자 11명을 대상으로 함. 건강보험 재택의료를 제공하는 의료기관의 의사(3명), 재택의료 분야 연구 경험이 있는 학계 전문가(3명), 정책 수립 및 집행 담당자(4명), 이용 환자(1명)를 포함함

- 환자군은 의식이 명료하며 장애인이 아닌 70대 완전 와상 환자로 일차의료 방문진료 수가 시범사업과 가정간호 기본방문, 장기요양 재택의료 센터 시범사업 이용 경험이 있음

- 특정 주제에 대한 전문지식과 현장 맥락에 대한 이해를 동시에 갖춘 중복적 성격의 참여자로 전문가 표집(expert sampling)과 핵심정보원 표집(key informant sampling)을 함께 적용하기 위해 관련 학회와 협회에서 추천 받은 참여자를 선정함.

초기 추천자에게 추가 적합자를 연결받는 방식으로 스노우볼 표집(snowball sampling)을 일부 병합하여 참여자 다양성과 이론적 포화(Theoretical Saturation)를 강화함(Patton MQ, 2015). 내부 규정에 따라 정책 담당자를 제외한 참여자들에게는 소정의 사례금을 지급함

- 환자군은 1명으로 구성되었으나, 주요 응답이 다른 그룹과 유사하여 새로운 주제나 범주가 도출되지 않음에 따라 전체 자료의 이론적 포화에 도달한 것으로 판단함

○ (자료 수집 방법) 사전에 안내된 반구조화된 질문지를 이용하여 대면으로 수행함. 연구자와 참여자 간 긴밀한 상호작용과 의견 수집 시 관찰과 기록의 집중도를 높이고 인터뷰 내용의 유출을 막기 위한 소음 및 출입통제가 가능한 회의실에서 개별 면접을 실시하였으나, 거동불편 환자는 참여자와 보호자의 동의를 받아 자택에서 진행함

〈표 70〉 일대일 심층 면접 반구조화 질문지

구분	세부 질문
1. 참여 경험	- 참여하고 계신 재택의료 사업은 무엇인가요? - 재택의료 사업에 신청 및 참여한 동기는 무엇인가요?
2. 재택의료 효과 및 영향	- 재택의료 참여를 통해 직·간접적으로 경험한 긍정적인 효과와 제도적 한계는 어떤 것이었나요?
3. 재택의료 개선의견	- 제공 서비스에 따른 수가와 산정 기준은 적절하다고 생각하시나요? - 재택의료 유형에 따른 환자 선정기준이 적절한가요? · 현 기준으로 인한 발생하는 환자군의 공백과 중복에 대해 어떻게 생각하시나요? - 재택의료 시범사업에 따른 서비스 제공자 자격 기준이 적절한가요?
4. 재택의료 유형별 개념에 관한 의견	- 제공 서비스별 유형 구분과 이에 따른 개념에 대한 의견을 말씀해 주세요.
5. 재택의료 포괄모형 개발에 관한 의견	- 재택의료 서비스 특성과 제공 기간 등을 고려한 포괄모형 구분에 대한 의견이 있으신가요? - 재택의료 영역에서 장기요양과 건강보험의 적용 범위는 무엇을 기준으로 구분해야 한다고 생각하시나요?

- 응답자 동의 이후 녹취를 시작하였으며, 녹취록을 주요 분석 자료로 활용함. 참여자의 성명이나 소속은 보고서에 구체적으로 기재하지 않고, 의료, 학계, 정책, 환자로 분류하였으며, 익명으로 처리함

- 심층 면접은 사전에 안내된 반구조화된 질문지를 이용하여 건강보험 재택의료 참여 경험, 재택의료 효과 및 영향, 개선의견, 재택의료 유형별 개념, 포괄모형 개발 의견으로 구분함. 환자군의 특수성을 고려하여 참여경험과 재택의료 효과 및 영향에 관한 내용만 인터뷰함

○ (분석방법) 내용분석(Content Analysis)과 주제분석(Thematic Analysis)을 적용함. 심층 면접 후 녹취록을 정리하여 주요 내용을 주제별로 분류하고 자료의 유사한 의미단위를 묶어 구체적인 하위범주로 개념화함

○ (타당성 확보) 연구 결과의 타당성 확보를 위해 연구 참여자 2명에게 본인의 면접 내용이 결과에 잘 반영되었는지에 대해 검토 받은 결과 수정 의견 없음으로 회신됨. 이번 연구에 참여하지 않았지만 참여자 선정 기준에 부합한 2명도 연구 결과가 본인의 경험 및 생각과 유사하다고 응답함. 마지막으로 사례연구 방법론을 활용한 연구 경험이 풍부한 전문가에게 연구 설계와 방법론의 적합성, 결과 해석의 타당성에 관한 자문을 실시한 결과 이상 없음을 확인받음

2. 일대일 심층 면접(IDI) 결과

○ 인터뷰 텍스트를 반복적으로 읽고 코딩하는 과정을 통해 데이터 내에 내재된 주요 주제와 패턴을 식별함. 주제 분석법(Thematic Analysis)을 활용하여 검토결과 상위 범주(주제) 4개와 하위범주 11개를 도출함

〈표 71〉 심층 면접 범주

범주 (주제)	하위범주
건강보험 재택의료 경험	- 건강보험 재택의료 참여 경험 - 재택의료팀 구성 현황 및 필요성 - 재택의료의 효과 및 영향
재택의료 개념	- 재택의료 개념
건강보험 재택의료 개선 및 포괄모형 개발 의견	- 재택의료 포괄모형 - 수가 및 산정기준 - 재택의료 참여자 및 서비스 제공자의 자격 - 적정 본인부담률
기타의견	- 재택의료 참여자 선정 주체 - 재택의료의 역할 - 지불제도의 다양화

○ 내용 분석법(Content Analysis)으로 각 진술의 내용적 특성을 정량적으로 파악하기 위해 특정 키워드의 빈도를 측정함. 내용분석법은 텍스트 자료를 일정한 규칙에 따라 체계적으로 분류·코딩하고, 빈도나 맥락을 분석하여 의미를 해석하는 질적·양적 혼합 방법론임(Neuendorf, 2017)

- 분석 단위를 '단어'로 설정하였으며, 텍스트 전처리 단계에서 정규식 기반 토큰화(Regular Expression Tokenization) 기법을 사용함. 두 글자 이상의 한글 단어를 추출한 뒤, 조사·대명사 등 분석과 무관한 불용어를 제거함. 이후 단어별 빈도를 산출하여 상위 30개 단어를 필터링 전 후보군으로 설정하고, 연구 주제와의 관련성을 반영해 비연관 단어를 제외한 필터링 후 주요 키워드를 확정함
- 최종 키워드는 '환자(354회)', '의사(249회)', '수가(187회)', '간호사(181회)', '재택의료(140회)' 등이 높은 빈도로 언급되었으며, 상위범주에 따라 재분류하여 범주별 맥락 차이를 식별함

〈표 72〉 심층 면접 범주별 주요 키워드 언급 빈도

구분	키워드	언급 빈도
건강보험 재택의료 경험	재택의료	285 (9.5%)
	환자	246 (8.2%)
	방문진료	179 (6.0%)
	의사	174 (5.8%)
	장기요양	152 (5.1%)
	간호사	123 (4.1%)
	사회복지사	91 (3.0%)
	가정간호	88 (2.9%)
	장애인 건강주치의	44 (1.5%)
	호스피스	35 (1.2%)
재택의료 개념	재택의료	181 (6.0%)
	방문진료	75 (2.5%)
	환자	61 (2.0%)
	모니터링	44 (1.5%)
	의사	38 (1.3%)
	장기요양	34 (1.1%)
	원격의료/ 비대면	22 (0.7%)
	간호사	24 (0.8%)
	왕진	18 (0.6%)
건강보험 재택의료 개선 및 포괄모형 개발 의견	시범사업	272 (9.0%)
	수가	185 (6.2%)
	건강보험	134 (4.5%)
	일차의료	128 (4.3%)
	재택의료	74 (2.5%)
	장기요양	60 (2.0%)
	환자	47 (1.6%)
	방문진료	42 (1.4%)
	간호사	34 (1.1%)
	다학제 팀	29 (1.0%)
	중증도	27 (0.9%)
기타의견	판정·역할분담	19 (0.6%)
	질관리	16 (0.5%)
	통합돌봄	14 (0.5%)
	재택의료	6 (0.2%)
	방문진료	3 (0.1%)
	장기요양	2 (0.1%)
전체		3,006 (100.0%)

가. 건강보험 재택의료 경험

1) 건강보험 재택의료 참여 경험

○ (재택의료 제공자) 방문진료 등 재택의료에 대한 관심으로 자연스럽게 건강보험 재택의료에 참여함. 건강보험 재택의료뿐만 아니라 지자체 및 장기요양 사업에 동시 참여하고 있음

- (서비스 제공 내용) 의원은 장기요양 재택의료센터 기준에 따라 의사 월 1회, 간호사 월 2회를 기본으로 환자 상태에 따라 방문횟수를 가감함

> "아는 분의 추천을 받아 2018년 장애인 주치의 시작부터 했어요. 일차의료 방문진료와 장애인 건강주치의를 하고 있어요. 재택의료 센터와 가정간호, 촉탁의도 운영합니다. 2019년 말에 일차의료 방문진료로 장애인이 아닌 환자에게도 방문진료를 할 수 있게 되었고…" (의료1)
>
> "저희는 일차의료 방문진료 수가 시범사업이 제일 많고, 장기요양 등급자는 재택의료센터로 연계해서 주기적으로 운영하고 있어요. 중증장애인이면 장애인 건강주치의로 안내드리고, 본인부담이나 수가 측면에서도 그게 제일 유리해요…중앙호스피스센터 생애말기 시범사업이나 지역 건강주치의 같은 거요… 의사는 월 1회, 간호사는 재택의료센터 수가 요건 맞추려면 월 2회는 가야 해서, 등록된 분들은 간호사 선생님 일정 따로 조정해서 방문하고 있어요." (의료2)

- (환자 발굴) 초기 대상자는 외래환자 중심으로 운영하다 코로나19로 요양병원 퇴원 환자의 방문의료 수요가 늘어나 서비스 제공 대상이 확대됨

- (환자 특성) 고령의 복합질환자가 많아 서비스의 난이도가 높음. 말기암 임종기 환자는 중증도가 높고 통증이 심해 호스피스 전문기관 등에서 담당하는 것이 바람직함

> "처음엔 외래환자 몇 분 하다가 코로나 19로 요양원이나 요양병원에 있던 환자분들이 집으로 돌아오시게 되면서 수요가 늘어났어요. …고령에 복합질환 있는 분들이 많아서 쉽지 않아요. 말기암 환자는 호스피스 전문기관이 맡는 게 맞다고 봐요." (의료1)
>
> "치매, 우울증, 비뇨기 장애, 심부전 등 여러 문제가 함께 있는 분들이라 난이도 높고 문제도 복잡해서 어느 정도 역량이 있는 의사가 할 수 있어요." (의료2)
>
> "호스피스는 시범사업 단계에서 거의 말기암 환자 대상으로 범위가 좁아졌어요." (의료3)

○ (재택의료 이용자) 장기입원 후 재가생활 시작 초기에 인근 병원의 가정간호를 이용했으나 만족도가 낮음. 우연히 지역 신문에서 방문진료 제공 의원에 대한 기사를 보고 구청 등에 문의해 연계됨

- 이용 초기 월 2~3회 방문진료를 이용했고, 상태가 안정된 현재는 월 1회 수준임. 30~40분 머물면서 청진, 혈압 및 당 검사 등 일반적 건강상태를 확인함

"퇴원하고 장기요양센터에서 소개를 받아 지역병원에서 하는 간호사 선생님이 오시는 걸 했는데 소변줄을 끼우다 실수가 있었어요… 지역신문을 보는데 의사, 간호사가 집으로 오는 게 있다는 거예요. 그래서 구청에 전화를 해서…." (환자1)

"처음에는 상태가 안좋아서 자주 오셨는데 지금은 한달에 한두 번 정도 오세요. 청진하고 소화기능 이런거 다 봐주시고, 혈압, 당검사하고…" (환자1)

2) 재택의료팀 구성 현황 및 필요성

○ 의원은 의사 단독 방문진료만 하다 환자가 많아지고 요구가 다양해짐에 따라 재택의료팀의 필요성을 인지함. 재택의료팀은 병원 상황과 환자의 필요에 따라 의사, 간호사, 사회복지사, 작업치료사, 영양사 등으로 구성됨

"…장애인은 기존에 다니던 병원을 바꿀 이유가 없으니깐 대상자가 없었던 것 같아요. 병원을 못 오는 거동불편 환자를 찾으려면 방문진료를 해야할 것 같아서 팀을 꾸리기 시작했어요. …간호사, 사회복지사, 작업치료사도 팀에 들어오게 됐어요." (의료1)

"초기 평가는 의사, 간호사, 사회복지사가 함께 나가고, 이후 경과 관찰은 간호사가 혼자 나가요." (의료3)

"재택의료는 다학제 팀 기반 서비스 제공이 이상적이에요." (학계2)

3) 재택의료 효과 및 영향

○ (일차의료 중심 통합관리) 환자와 보호자의 높은 만족도와 입원 및 응급실 방문을 줄이는 효과가 있으며, 고령의 단기이용 환자 대상 효과평가 결과 외래와 가정간호 이용은 증가함. 환자 건강상태 개선과 환자·보호자의 안정감이 커지는 효과가 있음. 건강보험 환자 기준 본인부담은 높은 수준이 아님

"…어떤 분은 마지막 진료가 1년 전이고 피검사도 1년 전이에요. 약은 보호자가 그냥 가서 계속 똑같은 약만 받아오신 거죠. 지금은 먹지 말아야 할 약도 계속 드시고…저희가 직접 진료하면서 1시간 이상 의료뿐 아니라 돌봄까지 같이 보니까, 보호자도 싫어하는 분이 없어요." (의료1)

"만성질환·복합문제가 많은 노인환자 병원에 가기 힘든데 재택서비스가 없으면 응급실, 중환자실 떠돌다 비용만 쓰고 돌아가세요." (의료2)

"장기요양 재택의료센터 효과평가 연구에서 중증환자의 비용대비 효과가 크다는 것이 확인되었어요. 재택환자라 가정간호랑 외래는 늘더라구요." (정책1)

"…우리 집이 지금 계단이잖아요. 사설 응급차 타고 힘들게 병원 가면 진료받는 것도 오래 기다리고, 선생님 보는 시간도 짧았던 것 생각하면…더는 바라는 거 없어요." (환자1)

○ (질환군별 재택의료) 외래진료의 보조 수단으로 외래 횟수를 줄이거나 환자의 응급 상태를 빠르게 파악하는 데 도움을 줌. 효과평가 결과 상시 질환관리로 단기 의료이용은 증가하지만 중장기 비용효과가 있음이 확인됨. 환자와 의료진의 상시 연락망 구축에 대한 환자 만족도가 높게 나타남

"가장 큰 목적은 내원을 줄이는 거고, 나머지는 급격히 악화될 때 빨리 병원으로 보내는 거죠.…조기 발견으로 초기 합병증은 늘지만 장기적으로는 좋아져요. 문제 생기면 빨리 오라고 해서 외래 이용은 늘지만 입원은 줄면서 비용 효과는 좋아지는 거예요." (학계3)

"이전 효과평가 연구 결과를 봐도 병원에 덜 가게 되니까 의료비가 줄어요. 꾸준히 관리했더니 검사 수치가 안정되고 건강결과도 좋았어요." (정책2)

나. 재택의료 개념

○ 재택의료는 환자중심 용어로 환자가 집에서 받는 모든 의료서비스를 의미함. 대부분 재택의료는 방문의료를 필수적으로 포함해야 한다고 응답함

- 용어사용에 따른 상호 혼선을 줄이기 위해 비정기적 의사 방문은 '왕진', 정기적 의사 방문은 '방문진료', 의사 등 의료진이 가정과 시설(요양원 등)에 있는 환자에 통합적 의료서비스를 제공하는 것은 '재택의료'로 할 수 있음
- 엄격하게 구분하면 환자의 참여 의지도 고려 대상으로 강제 방문에 가까운 정신질환자 지속치료 지원 시범사업과 사전에 계획되지 않은 일시적 방문진료는 재택의료라고 볼 수 없다는 일부 의견이 확인됨

"재택의료는 병원에 올 수 없는 사람에게 의료진이 집으로 찾아가는 거예요. 의사와 간호사가 팀을 이뤄 방문하지 않는다면 재택의료란 말을 쓰지 말아야 한다고 생각해요.…재택의료, 방문진료, 왕진은 일본에서 구분하는 용어예요. 일본은 왕진 일회성, 방문진료 연속적 관리, 재택의료는 그 둘을 포함해서 더 포괄적인 개념으로 사용하고 있어요." (의료1)

"재택의료는 환자가 집에 있으면서 의사 등 의료 인력의 서비스를 직접 받는 것이고, 핵심은 '직접 방문'이라는 물리적 접촉이에요." (학계1)

"재택의료는 의사, 간호사 등 다양한 의료 인력이 환자의 집이나 시설에 찾아가서 돌봄과 의료를 함께 제공하는 걸 포괄적으로 말합니다. 왕진은 그냥 한 번 가는 거고, 방문진료는 지속적으로 관리하는 의료행위예요. 일본에서 말하는 재택은 집뿐 아니라 시설까지도 포함해요. 반면 우리나라는 장기요양 쪽에서 재택의료라는 용어를 먼저 써버려서 의미가 조금 굳어졌죠." (학계2)

"재택의료는 병원에 가기 힘든 환자가 원할 때 집에서 받는 의료서비스를 말해요. 정신질환자처럼 치료 의지가 없는 경우는 재택의료의 범주에 포함되기 어렵습니다." (학계3)

"…상시적 관리하거나 정기적 방문이 없는 건 재택의료로 보기 어렵죠." (정책4)

○ 질환군별 재택의료는 방문의료가 없어 재택의료가 아니라는 의견과 환자가 집에서 받는 모든 의료서비스는 재택의료에 포함한다는 의견이 모두 확인됨

- 건강정보 비대면 전송은 재택의료 하위 개념이 아닌 원격의료와 교집합임. 질환군별 재택의료는 원격의료 성격을 일부 포함하여 불필요한 오해를 막고자 시범사업 도입 시 재택의료라는 용어를 사용함
- 질환군별 재택의료가 재택의료를 대변하는 사업이 아니므로 비대면 질환관리, 비대면 모니터링, 원격 모니터링 비대면 환자관리 등으로 사업명 변경이 필요함

"환자 중심으로 보면, 원격이나 모니터링도 재택의료로 볼 수 있어요. 하지만 방문하는 재택진료와 비대면 모니터링 중심의 사업은 구분해서 볼 필요가 있다고 봐요." (정책2)

"비대면 모니터링이라는 표현이 가장 정확하고, 재택의료'라는 용어는 오히려 본질을 왜곡하는 표현이라고 생각해요." (학계2)

"재택의료가 공간적으로 집에서 이루어진다고는 할 수 있지만, 그 목적에 비춰보면 방문이 없는 건 재택의료로 보기 어렵죠. 이건 그냥 비대면이에요. 관리라기 보단 지원에 가까운 표현이어야 하고, 사실은 원격의료지만 애매하게 표현한 거죠." (학계3)

"재택의료는 의료기관 밖에서 의료인이 직접 의료행위를 하는 거예요. 핵심은 장소고, 대면이냐 비대면이냐는 다른 기준으로 구분해야 합니다." (정책1)

"질환군별 재택의료가 진짜 재택의료라고 보진 않아요. 그냥 비대면 교육·상담 시범사업이죠." (정책3)

"재택이라는 표현은 방문이 전제된 느낌을 주기 때문에 방문이 없는 사업에는 쓰지 않는 게 맞다고 생각해요.…비대면 환자 관리가 가장 명확하고 낫다고 봐요. 비대면 진료와도 구분돼야 하고, 의료인이 직접 가지 않는 이상 진료가 아닌 관리로 분류하는 게 맞죠." (정책4)

다. 건강보험 재택의료 개선 및 포괄모형 개발 의견

1) 재택의료 포괄모형

○ 일차의료 중심 재택의료는 다학제로 접근해야 하며 간호사 역할이 중요함. 의사는 초기 치료계획 등 의사결정 필요 시점에 개입하고, 간호사 등이 지속 관리해야 함

- 중증도가 높은 환자는 입원과 24시간 온콜(on-call) 시스템 구축이 용이한 종합병원 이상에서 제공하는 재택의료를 고려할 수 있으나 방문의료가 어렵고 제공 기간이 제한적이라는 한계가 있음. 종합병원은 지역 내 거점 병원 등의 역할이 적절함

○ (건강보험과 장기요양의 역할 구분) 재가 환자는 의료서비스 연계가 필수적임. 만성 복합질환이 있는 장기요양 등급자는 건강보험 환자와 명확히 구분하기 어려우나 건강보험은 급성기와 생애 말기 중증 환자를, 장기요양은 비교적 안정적 상태의 환자를 우선 적용해야 함. 이를 위해 장기요양보험도 방문간호 등 의료역량 강화가 필요함

○ (질 관리 방안) 가정의학과 노인의학 중심 일차의료 방문진료 매뉴얼 준비되었으나 한의원 등의 영역은 공백이 있음. 질 관리가 안되는 의료기관 퇴출기전이 필요함

- 질 평가는 환자 만족도 외에도 입원·외래 감소가 주요 지표임
- 환자 평가와 서비스 내용에 대한 자료제출 시스템을 구축해 모니터링할 수 있음. 다만, 의료기관 부담을 줄이기 위해 서식의 단순화와 시스템의 일원화가 필요함

○ (별도 관리체계 마련) 재택의료 시범사업 본 사업 시행 시 입원·외래와는 별도로 재택의료 '장(章)' 혹은 '편(篇)'으로 구분하고, 방문의료 포함 사업과 비대면 모니터링 단독 사업을 하위 그룹으로 분류하면 일관성 있는 수가적용이 가능함

"간호사 역할이 중요하고, 의사는 판단이 필요한 시점에만 개입하면 돼요. 일본도 의사가 세팅마다 판단하지 않아도 시스템이 돌아가고 있어요." (학계1)

"모니터링이 중요한 질환에선 간호사의 역할이 핵심이에요. 수치 변화도 민감하게 파악하고 대응할 수 있어야…" (정책2)

"병원급 재택의료는 의원과 경쟁하는 구조가 아니라, 의원에서 의뢰된 환자를 병원이 받아 응급 대응 후 다시 퇴원 계획을 세워 연계하는 모델이 맞다고 생각해요." (정책1)

"상급종합병원은 전문성이 있는 만큼 센터로서의 역할도 있겠지만, 지역 내 리더십 역할도 중요해요." (의료3)

"건강보험은 급성기나 특정 시기에 집중관리를 하고 장기요양은 쭉 안좋으신 분들 관리로 구분하면 되지 않을까 생각 하는데 이거는 찬반이 있어요. 건강보험 재원에서 의료가 필요한 모든 환자를 책임지는게 맞다라는 의견도 있어서…" (정책3)

"통합돌봄 취지를 보면 장기요양이든 건강보험이든 의료를 할 수 있게 해야…"(학계1)

"재택의료는 외래나 이런 게 적어지면 되는 게 아닌가라는 생각을 했어요. 서비스에 대한 만족도는 기본적인거고"(정책3)

"시범사업 자료제출 시스템 같은걸 활용해서 체크해야할 것들을 넣어주면 그걸 확인하는거 자체가 질관리가 되는거예요."(정책2)

"…이 전에 가정의학, 노인의학 하시던 분이 재택의료 매뉴얼에 대한 연구를 하신 적이 있거든요. 물론 한의원 재택의료는 공백이 될 수 있지만.. 질관리가 안되는 기관 퇴출하는 것도…" (정책1)

"저는 수가 별도 자리로 재택의료를 만들어야 깔끔한 것 같아요. 방문이 포함된 것과 포함되지 않은 것을 하위 그룹으로 구분하고…" (정책2)

"모니터링도 방문이 포함된 거랑 모니터링만 있는 것이 있잖아요. 이 두개만 명확히 구분해도 정리가 될 것 같아요." (정책3)

2) 수가 및 산정 기준

○ (수가 산정 원칙) 지속 또는 일시적으로 의료기관 방문이 어려운 환자가 재택의료를 이용할 수 있도록 산발적 운영되는 시범사업 개수를 줄이고 기본 수가에 조건별 가산하는 방식을 적용해야함. 지역 의료기관의 다학제 팀 방문진료를 기반으로 사업별 대상군(복합질환자, 임종기, 말기 암 환자 등)과 기관 역량(전일제 의사 수, 다학제팀 인력 구성 등), 성과(건강결과 등)에 따라 보상 수준을 가감해야 함

○ (수가 수준) 일본과 비교하면 비슷하거나 낮은 수준임. 다만 공급 부족 문제 해결을 위한 구조적 개선이 선행되지 않은 수가의 상향평준화와 다양한 가산 확대는 지나친 상업화와 건강보험 재정부담의 우려가 있음. 또한 건강보험 수가는 인하기전이 없고 유사 수가 인상에 영향을 줄 수 있어 신중하게 접근해야함

○ (중증도에 따른 수가 차등) 고난도 관리가 필요한 중증환자(루게릭·욕창환자, 비위관·

기관절개관 관리 등)는 고혈압·당뇨 등 일반적 건강관리 대상 환자보다 많은 시간과 자원이 필요해 추가 보상해야 함. 의원 제공 방문진료는 제공 서비스가 제한적으로 추가 진료가 필요한 경우 외래 또는 입원으로의 연계하는 것이 바람직함. 일부 질 높은 서비스 제공이 가능한 의원이 있더라도 이는 일반화하기 어려운 예외 사례로 현시점에서 추가 보상을 검토하는 것은 시기상조라는 의견도 있음

- 상병이 아닌 제공 서비스 종류와 난이도, 환자 상태를 고려한 수가 산정이 필요함. 임종기는 평생 1회 등의 기준을 고려할 수 있음
- 종합병원 이상은 이용 환자의 높은 중증도를 고려해 수가 수준을 높이고 횟수 기준을 확대해도 의료진 수익으로 직결되지 않아 환자 과다 이용의 우려가 적음

○ (재택의료팀) 다학제 팀 구성 및 운영을 위한 보상체계가 필요함. 간호사, 사회복지사, 물리·작업치료사 등 전문 인력별 별도 보상이 필요하다는 일부 의견이 있음

○ (온콜 시스템 보상) 상태가 급변하는 중증환자 대상 사업은 온콜(on-call) 시스템이 필수적으로 인에 대한 보상이 필요함

○ (교통비) 이동 거리와 소요 시간과 무관한 정액 교통비는 방문료에 포함해도 무방함

- 지속관리를 전제로 하는 재택의료 특성을 고려하면 원거리 환자에 대한 교통비 가산 적용은 사업 취지와 맞지 않음. 동일 세대, 동일 건물 감산 기준은 일괄 적용이 필요함

○ (방문진료 횟수 기준) 의사 혹은 의료기관당 등록체계가 아닌 경우 질 관리를 위해 의사 단위 제공 횟수 기준이 필요함. 다만 방문진료 전담 의사의 경우 일차의료 방문진료 월 100회 제한 기준은 부족한 수준으로 월 150~160회로 확대해야 함

○ (서비스 제공 기간) 거동불편으로 의료적 필요가 있는 환자에게 서비스 제공 기간을 한정하는 것은 의료이용 제한으로 바람직하지 않음. 기간이 아닌 환자 대상 제공 횟수 기준으로 이용 수준을 조절해야 함

○ (묶음수가 적용) 장기적으로 지속관리가 필요한 만성환자의 포괄케어는 제공 서비스 편차가 적어 묶음수가를 고려할 수 있으나, 과보상에 대한 우려 해소와 질 관리 방안이 마련되어야 함

○ (질환군별 재택의료) 질환군 별로 상이한 서비스 제공 시간과 산정 횟수는 의학적 타당성이 부족해 청구 현황이나 중증도에 따른 단순화 방안이 필요함. 재활환자와

결핵은 위험도가 낮은 질환으로 모니터링 필요도가 비교적 낮음

- 환자 상태에 따른 구분은 체내 삽입형 의료기기 사용 환자와 그렇지 않은 경우를 고려할 수 있음. 또한 사업 목적이 셀프케어 역량 강화인 경우 서비스 제공 기간을 제한해야 하며, 상태 악화를 막기 위한 모니터링인 경우 완치까지 제공해야 함

"재택의료는 병원 못 가는 사람한테 의사나 간호사가 집으로 가는 거예요. …지금은 너무 복잡하니까 일본처럼 기본 틀에 조건별 가산 붙이는 게 낫죠." (학계2)

"지금 사업들이 따로따로 놀고 있어서 정리할 필요가 있어요. 그냥 하나로 묶고 명확히 구분해서 관리하면 돼요." (정책2)

"서비스를 제공하는 의료기관의 의사 수, 팀 구성이나 응급 콜 가능 여부와 같은 역량에 따라 더 보상해야 해요. 저희는 인공호흡기 사용 루게릭 환자 같은 중증도 보거든요. 이런 분들은 해드려야 할 것들이 더 많은데 일반적인 만성질환자들과 같은 비용을 받고 있어요." (의료1)

"방문진료는 건강보험에서 필요하면 누구나 할 수 있도록 기본수가를 정하고 정책 목적에 맞는 가산이 붙는 구조가 맞아요. 중증소아나 치매 환자처럼 우선순위가 있는 대상과 기관별 자격에 따라 수가를 더 보상하는 방식이죠. 수가는 단계별로 1단계, 2단계, 3단계로 설계되면 좋아요. 다만 기본 수가는 너무 높게 잡으면 안 되고…" (의료2)

"수가는 한번 올려주면 내려갈 수는 없기 때문에 일회성 수가를 올리기보다 전체 큰 틀에 대한 고려를 해야 해요." (학계1)

"방문만 생각하면 우리나라가 적지는 않아요. 그렇지만 일본은 가산이 많기 때문에…"(의료1)

"임종기 수가를 더 주는 게 필요하지만 예측이 어려워 재택 현장에선 적용이 쉽지 않아요. 비 암성 질환은 평생에 한 번 같은 기준을 고민할 수 있을 것 같아요" (의료3)

"보통 방문진료로 할 수 있는 게 제한적이라 검사가 필요하면 결국 외래로 올 수밖에 없어요." (정책1)

"병원이나 종합병원은 본인 수익과 직결되지 않아서 가산 기준이 생겨도 막 늘거나 하지 않아요.…일부 우수사례가 있지만 이런 상황에 대한 반영은 일반화가 된 이후에 하는 게 맞다고 생각해요." (정책2)

"집중 서비스가 필요한 시점 기준으로 수가를 나누는 것도 고려할 수 있어요" (정책3)

"간호사, 사회복지사, 작업치료사 수가는 의사 수가에 묶지 말고 따로 만들어야 해요. 간호 수가가 있어야 간호사를 채용하고, 사회복지사 수가도 최소한 있어야 고용이 가능해요" (의료2)

"24시간 대기 수가가 필요해요. 간호사들이 경력이 있어도 24시간 전화 받는 걸 부담스러워해요. (의료3)"

"교통비가 포함돼 있지만, 멀리까지 가는 걸 보장할 수준은 아니에요. 너무 먼 곳은 지속적인 관리가 어려워 바람직하지 않아요. 동일 건물이나 동일 세대에 대한 감산 기준은 장애인에게도 적용하는 방향으로 제도 정비가 필요해요" (정책4)

"1차 의료 방문진료 수가 시범사업은 100건 제한이 있어서, 최대 120건 정도밖에 못 해요. 이건 풀타임 인력을 쓰지 말라는 뜻이에요 방문 횟수를 하루 8~10건 정도로 해서, 한 의사당 월 160건 정도는 가능하게 해야 해요" (의료2)

"장애인 주치의 같이 등록 환자 수가 정해져 있으면 의사당 방문 횟수 제한이 필요 없어요. 일차의료 방문진료는 등록해서 인원 제한을 하지 않기 때문에 의사 횟수 제한을 하는 거죠" (정책4)

"지금처럼의 다 구분한 행위별 수가보다는 기본 행위를 묶음으로 하는 게 장기적인 관점에서는 나쁘지 않다고는 생각해요. 다만 과보상에 대한 이슈를 어떻게 해소할 수 있을지는 잘 모르겠어요."(정책4)

"환자가 입원이나 외래가 필요해서 찾아오는데 특별한 이유 없이 못 가게 차단하지는 않잖아요. 어차피 의사를 봐야 할 환자가 재택의료를 못하게 되면 힘들게 외래나 입원으로 가기 때문에 적극적으로 제한하는 건 어려울 수 있어요. 방문진료 간격을 횟수로 조정할 수는 있을 것 같아요. 질환별 재택의료는 환자 난이도가 높아서 의원급보다는 병원급이 하는 게 맞아요. 복막투석 재택의료가 처음으로 시작했는데, 질환이 계속 늘어나 통합이 필요하다는 이야기가 계속 있었어요. 운영 시간이나 횟수는 질환별로 학회랑 논의해서 정한 거라 일부 통합할 수 있는 부분은 묶어야 해요." (정책2)

"재활이나 결핵은 다른 질환군별 재택의료와는 결이 달라요…거동이 가능해도 심장질환같이 급성 모니터링이 필요한 중증 환자는 대상이 될 수 있어요. 1형 당뇨는 상태가 양호해 보여도 갑작스러운 악화가 있을 수 있어 실시간 모니터링이 중요해요" (학계3)

3) 재택의료 대상자 및 서비스 제공자 자격

○ (거동불편환자 대상) 방문의료는 자발적으로 의료기관 방문이 불가능한 사람으로 제한해야 함. 단기적으로 장기요양 1, 2등급자, 인공호흡기 또는 산소치료 요양비 대상자 등을 고려했으며 향후 별도의 선별기준과 등록 체계가 필요함

- 장애인은 취약계층으로 일정 수준의 인센티브를 부여하는 것에 동의하나 그 차이가 너무 커질 경우 서비스 제공자가 환자를 선택할 우려가 있음. 수가에 따라 대상자 선정에 왜곡이 발생하지 않도록 의학적 필요도에 따른 대상자 선정 체계 마련이 필요함. 거동불편 판정을 위한 도구는 ADL 등을 기반으로 개발·적용이 가능함

○ (현 재택의료 대상자 공백) 장기요양 재택의료 시범사업 대상이 아닌 환자는 재택의료 사각지대임. 호스피스 진입 전 말기 환자, 퇴원 후 관리 필요환자 등에게 재택의료를 제공해야 함

"거동불편자 개념을 명확하게 하는 게 제일 중요해요. 장애인은 범위가 넓어 조심스러운데, 정신질환처럼 보호자가 병원에 데리고 가기 힘든 경우도 대상자가 될 수 있죠. 물리적으로 이동이 어려운 사람이 대상인데… 당장 활용이 가능한 장기요양 1·2등급, 인공호흡기나 산소치료 요양비 대상자가 정해진

거예요.…결국 장기적으로 별도의 등록체계를 갖춰야 해요. 기존 도구를 얼마나 간편하고 명확하게 쓸지에 대한 합의가 필요해요.” (정책3)

“ADL로 요양병원 입원 중증도를 구분한 것처럼 재택의료 대상이 되는 거동불편도 유사한 방식으로 만드는 게 가능할 거예요.” (정책2)

“거동불편 환자 중증도를 기준으로 1군, 2군, 3군으로 나누는 구조가 필요해요.” (학계3)

“중증장애인은 수가가 높아서 건강 문제보다 다른 목적으로 발굴될 수 있어요… 암 진단을 받았지만 장기요양 대상이 아닌 고령자도 많고, 말기 환자이지만 호스피스로 가기엔 애매한 사람들도 재택의료가 필요해요. 비암성 말기환자도 재택으로 커버해야 해요.” (의료2)

○ (서비스 제공자 자격) 서비스 제공자의 전문성은 재택의료 질 관리를 위해 필수적임. 전문성은 자격만을 의미하는 것이 아니며, 체계화된 교육 프로그램 이수와 2~3년의 임상경력 등이 적합함

“일반 간호사도 교육만 잘 받으면 충분히 가능해요. …장애인도, 노인성 질환자도 아닌데 거동이 안되는 사람은 의사방문만으로는 한계가 있어요.” (의료1)

“현장에서는 자격보다 실무 경험 많은 간호사를 더 선호해요. 방문 간호사는 병원 내에서도 제일 실력 있는 분들이에요.” (의료3)

“의사와 간호사 모두 재택의료에 대한 기술과 역량을 학습하고 훈련해야 해요. 그런 교육을 학회나 제도적으로 보장해 줘야 해요‥수술 후 단기적으로 도움이 필요한 젊은 환자도 재택의료가 필요해요.” (학계2)

“재택의료팀 교육이 필요해요. 2시간 비대면 교육으로 끝나는 건 안 되고, 학회 차원에서 자율 규제와 질 관리를 해야 해요.” (정책1)

“가정으로 나가는 사람은 전문성이 중요해요. 가정전문간호사나 관련 경력 2~3년 이상 같은 기준을 갖춰야 해요.” (정책4)

4) 적정 본인부담률

○ 일차의료 방문진료는 본인부담률이 높아(30%) 의료적 필요가 적거나 서비스 만족도가 낮은 환자는 이용을 중단하게 하는 역할을 함. 이에 지속 이용이 필요한 환자군을 선별하고 본인부담률을 적정수준으로 조정하는 방안이 필요함

- 일부 본인부담금이 없는 환자관리료는 기준에 따른 본인부담률을 적용하는 것이 타당함. 재택의료 활성화를 위해 본인부담률을 낮추면 서비스 가치를 인식하지 못하는 부작용이 발생될 수 있음. 또한 장기요양이나 지자체 예산으로 제공되는 사업은 별도로

운영되어 통합 기준에 대한 고려가 필요함

"재택의료가 꼭 필요한 지속이용 환자 본인부담이 높은 건 문제가 돼요. 일차의료 방문진료 15% 기준은 실제 거동불편자만 선별하겠다는 목적이 컸어요." (정책3)

"장기요양 재택의료센터 이용자 30% 정도는 초기에 본인부담 때문에 이탈해요. 이런 분들은 외래보다 재택이 경제적이나 여러 가지 측면에서 더 유리하기 때문인 것 같아요…본인부담이 서비스 지속 여부에 영향을 미쳐요." (정책1)

"시범사업이라도 실제 건강보험에서 적용될 본인부담 수준을 기준으로 설정해야 해요" (학계3)

"본인 부담을 확 낮추면 가족들이 경제적인 부담이 줄어들어서 많이 이용은 할 텐데 서비스의 가치를 잘 모르게 돼요." (학계2)

라. 기타 의견

○ (재택의료 대상자 선정 주체) 대상자 선정 주체는 건강보험과 장기요양 모두 이해관계 개입 우려 등으로 제3의 기관(지자체, 별도의 외부기관 등)이 하는 것이 타당함

- 건보공단에서 주도하는 의료-요양-돌봄 통합판정 시범사업은 대상자 스크리닝 목적이 크며, 평가항목 등에 대한 사항은 여전히 논의 중임

○ (재택의료 역할) 일차의료 기반 방문의료는 이용 환자의 중증도와 의료기관의 역량에 따른 서비스 범위가 넓어 임종관리가 포함된 호스피스부터 입원, 단순 외래까지 대체 가능함

○ (지불제도의 다양화) 지속적 통합관리는 환자 상태(중증도)별 제공 서비스(방문, 교육·상담, 비대면 관리 등) 구성과 평균 비용을 고려한 인두제나 미국의 ACO 사례를 참고할 수 있음

"저는 판정하는 곳이 돈 주는 곳과 달라야 된다고 생각해요. 지자체나 공신력 있는 기관이 판정을 하고…장기요양 재택의료 센터는 인두제랑 행위별 수가가 합쳐진 거잖아요. 재택관리료가 인두제 형식이니깐 좀 포괄성을 가지는 방식을 이미 하고 있기 때문에…"(의료1)

"하나의 단일화된 도구로 평가해서 요양병원이나 시설을 갈지, 이런 것 들을 결정해야한다는… 사실은 중증도 보다는 스크리닝의 개념이에요.…재택의료를 받는 환자가 요양병원 입원 환자부터 외래를 다니는 만성질환자까지 천차만별이어서 딱 구분해서 입원 대체냐 외래 대체냐 말하기가 어려워요." (정책1)

"미국 ACO 같이 성과에 따라 보상해주는 것이 결국 미래 방향 같아요." (정책3)

3. 소결

○ 인터뷰 결과 확인된 참여자 그룹별 건강보험 재택의료에 대해 가지고 있는 주요 의견과 인식의 차이를 아래 표와 같이 구분함

- 모든 그룹에서 재택의료의 긍정적인 효과(환자 만족도, 의료비 절감)에 대한 인식이 높음. 또한, 현재 시범사업의 파편화와 용어 혼재 문제에 대한 공감대가 형성되어 있으며, 통합 및 개선의 필요성을 강조함

〈표 73〉 심층 면접 참여자 유형별 주요 의견 차이

주제		의료	학계	정책	환자
재택의료 경험	참여 동기	방문진료 관심, 지인 추천, 코로나19로 인한 수요 증가	-	-	지역 신문 기사, 구청 문의 등 비공식 경로
	팀 구성	다학제 팀 필수, 사회복지사와 물리·작업치료사 필요	다학제 팀 바람직, 간호사 역할 중요	-	-
	서비스 효과	환자와 보호자 만족도 높음, 입원과 응급실 이용 감소, 의료비 절감 효과	환자와 보호자 만족도 높음, 의료비 절감, 입원 감소 효과	중증환자의 비용 대비 효과가 큼, 입원 감소 효과	매우 높은 만족도, 안정감, 비용 부담 없음
재택의료 개념	재택의료	방문 필수, 왕진, 방문진료, 재택의료로 구분	방문 필수, 원격 모니터링과 구분	방문 필수, 비정기적 방문은 재택의료로 보기 어려움	병원에 가지 못 하는 환자에게 의료진이 찾아가는 것
	질환군별 재택의료	방문 없는 모니터링은 재택의료 아님	비대면 모니터링으로 명칭 변경 필요	비대면 관리 등으로 사업명 변경 필요	-
개선 및 포괄 모형 개발 의견	수가	재택 관리비 인상 필요	기본수가에 조건에 따른 추가 수가 필요	-	본인부담금 부담스럽지 않음
	산정 기준	중증도 별 가산, 방문횟수 제한 완화 필요	환자 중증도, 기관 역량, 성과 기반 가산 방안 필요	묶음수가 적용 가능, 질관리 방안 마련	-
	인력 자격	전문 간호사 부족으로 자격 완화 필요	역량 향상을 위한 교육체계 필요	의료질 관리를 위한 진입장벽 목적의 참여 기준 마련 필요	-
	정책 방향	시범사업 통합, 기능별 구분, 잘하는 기관 지원	포괄 모형, 일본 사례 참고, 정부의 큰 그림 부재 지적	시범사업 간 정합성, 점진적 통합 필요	제도 확대, 홍보 필요
주요 애로사항		행정 복잡성, 인건비 부담, 치료재료 수가 미흡, 횟수 제한	다학제 협업 어려움, 제도적 허들이 많음, 수가 부재	재택의료 기관이 난립 할 수 있어 관리 필요	정보 부족, 물리치료 등 비정기적 서비스 비효율적

○ 이해관계자별 재택의료를 바라보는 관점과 우선순위에 차이가 있음. 의료계는 서비스 제공의 현실적 제약과 보상 문제를, 학계는 정합성과 장기적 비전을, 정책 담당자는 정책 집행의 효율성과 재정적 지속 가능성을, 그리고 환자는 서비스의 실질적 편익과 접근성을 강조함

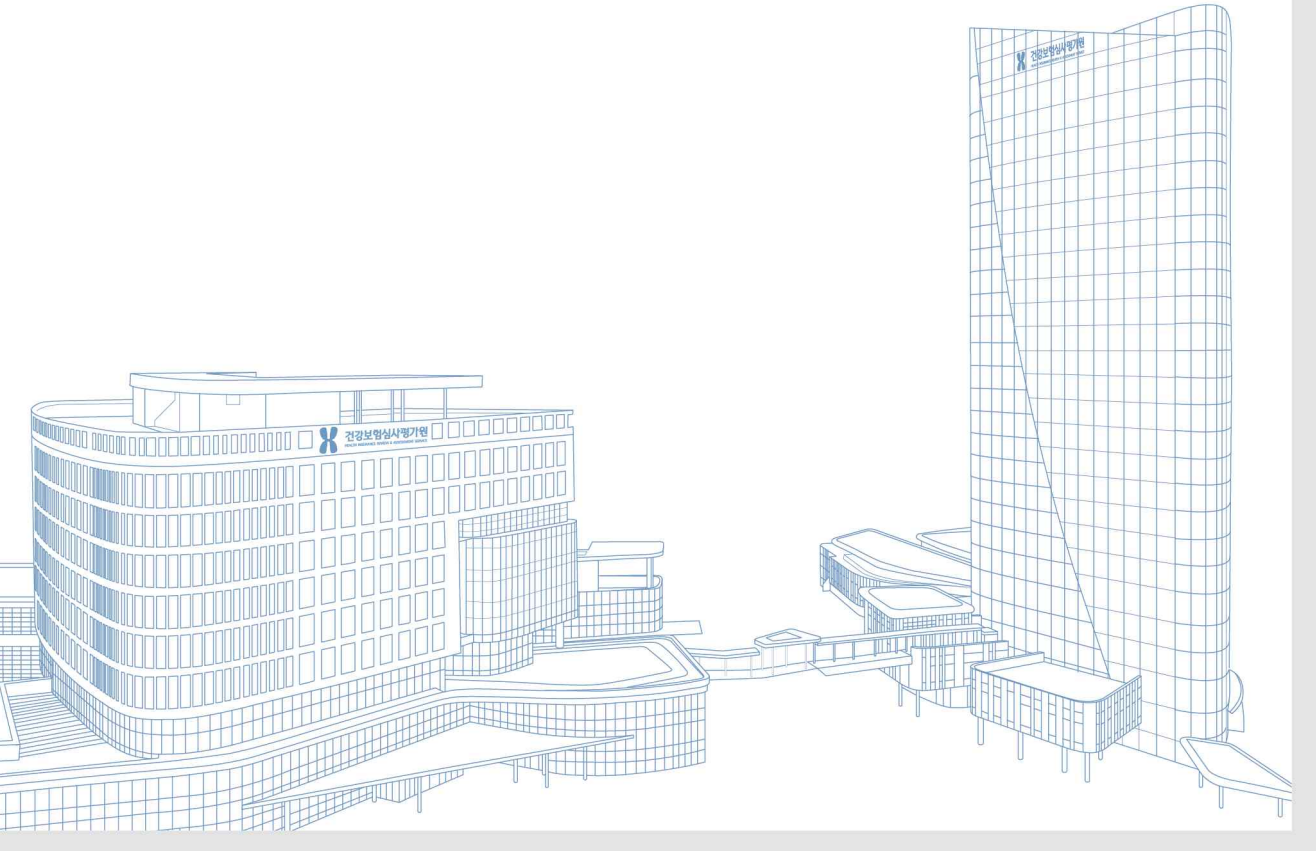
- (의료계) 다학제 팀의 필요성을 절감하면서도, 간호사, 사회복지사, 작업치료사 등에 대한 수가 미흡과 행정적 복잡성, 횟수 제한 등 현실적인 운영 애로 사항을 제기함. 중증도에 따른 수가 차등화와 환자관리에 대한 보상수준을 높여 서비스 질과 지속 가능성 확보가 필요함을 주장함. 가정전문 간호사 부족 문제로 일반 간호사의 자격 완화 의견도 포함됨
- (학계) 재택의료의 개념을 명확히 하고, 방문의료가 없는 비대면 모니터링은 재택의료에 포함하지 않는다고 강조함. 일본 사례를 참고한 포괄수가 모형과 단계별 가산 체계 도입, 장기적 정책비전 제시의 필요성을 지적함. 다학제 팀의 중요성을 인정하면서도, 실제 협업의 어려움과 제도적 장벽이 있음을 언급함
- (정책) 시범사업의 통합 필요성이 있으나 수가체계 개편 시 과보상 방지와 질 관리 방안 마련이 필요함을 강조함. 재택의료의 질을 담보하기 위한 자격 기준과 “비대면 환자 관리”와 같은 명확한 용어 사용의 필요성을 제안함
- (환자) 재택의료에 높은 만족도를 나타냄. 외래이용의 어려움과 사설 응급차 비용 등을 고려할 때 본인부담 수준이 부담스럽지 않다고 응답하며, 재택의료가 더 많은 사람에게 알려지고 확대되기를 바람

○ (질적연구의 한계) 본 연구는 참여자 일부 집단의 표본 수가 적고, 집단 간 구성 비율이 불균형하여 특정 집단의 의견이 과대 또는 과소 반영되었을 가능성이 있음. 또한 건강보험 재택의료 모든 영역의 이해관계자가 포함되지 않아 사업별 특수성이 충분히 반영되지 않았을 수 있음. 마지막으로 제3의 면담자가 아닌 연구책임자가 직접 진행하여, 참여자가 응답을 조정했을 가능성과 연구자의 사전 지식·경험이 질문 및 해석 과정에 영향을 미쳤을 가능성이 있음

HIRA
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

제6장

건강보험 재택의료 포괄모형



제6장 건강보험 재택의료 포괄모형

1. 건강보험 재택의료 개념(안)

○ 건강보험에서 '재택의료'를 처음 사용한 사례는 중증소아 재택의료 시범사업임. 중증소아 재택의료 이전에는 가정형 호스피스를 통한 포괄적 의료서비스와 가정전문간호사의 가정간호가 재가 환자에게 제공됨. 이 서비스의 '가정'은 환자가 집에 있다는 사실만을 강조한 것으로, 실제 제공되는 서비스의 내용이나 범위는 반영되지 않았다는 한계가 있음

- 장애인 건강주치의와 치매관리주치의는 건강취약계층의 지속적·포괄적 건강관리를 위한 주치의 사업으로 사업 대상자 중 일부 거동불편자에게만 방문진료를 제공함
- 정신질환자 지속치료지원사업은 급성기 입원치료에서 퇴원 후 사례관리와 낮병동 치료까지 연계하여 지속적인 의료서비스를 제공함. 이 과정에서 사례관리 일환으로 방문의료가 단기 제공되며, 이는 단순히 거동불편자의 의료서비스 제공보다 환자의 주거환경을 직접 파악함으로써 치료 순응도, 재발위험 요인, 생활 속 건강위해 요소 등을 종합적으로 평가하고, 필요한 지원과 서비스를 연계하는 데 주된 목적이 있음 (Giardino & De Jesus, 2023)
- 재활의료기관 수가 시범사업은 중추신경계나 근골격계 질환자의 급성기 치료 이후 회복기 환자의 집중치료를 위해 제한된 기간(90일, 추가 30일 연장 가능)동안 방문재활치료를 제공함
- 질환군별 재택의료는 교육·상담과 비대면 생체정보 수집, 위험 감지, 일상생활 관리 등의 내용을 포함하는 환자관리 서비스로 구분되며 방문서비스는 포함하지 않음. 복막투석 환자 대상 사업만 재택관리이며 나머지 7개 시범사업은 재택의료로 동일한 서비스이지만 사업명이 다름
- 일차의료 (한의)방문진료는 동반인력의 가산이 일부 허용되나 의사 단독방문 중심 사업으로 전문간호사 방문인 가정간호 기본방문과 형태는 유사하지만 사용하는 용어가 다름

○ 우리나라 법률에서 재택의료가 명시된 사례는 없으며 방문과 가정 등의 용어를 다음과 같이 규정함

- (방문요양급여) 가입자 또는 피부양자가 질병이나 부상으로 거동이 불편한 경우 등 보건복지부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 가입자 또는 피부양자를 직접 **방문**하여 제41조에 따른 요양급여를 실시할 수 있다(국민건강보험법 제44조).
- (가정간호) 법 제22조제1항제4호에 따라 의료기관이 실시하는 가정간호의 범위는 다음 각호와 같다(의료법 시행규칙 제24조).
- (가정형 호스피스) 보건복지부장관은 호스피스대상환자를 대상으로 호스피스전문기관을 설치·운영하려는 의료기관 중 보건복지부령으로 정하는 시설·인력·장비 등의 기준을 충족하는 의료기관을 입원형, 자문형, 가정형으로 구분하여 호스피스전문기관으로 지정할 수 있다(호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 제25조1항)
- (방문진료) 국가와 지방자치단체는 의료기관등을 직접 이용하기 어려운 장애인을 위하여 장애인의 거주지를 방문하여 진료 등을 행하는 방문진료 사업을 수행할 수 있다(장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 제9조2항)
- 참고로, 2026년 3월 시행 예정인 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」에서는 의료지원 외에 재택, 방문 등의 용어를 사용하지 않음

○ 일본과 미국 재택의료는 거동불편자를 대상으로 함을 분명히 함. 일본 재택의료는 의사, 간호사 등의 의료전문가 방문의료와 통합관리로 함. 의사 방문을 방문진료와 왕진으로 구분하는데 이는 각각 계획에 따른 정기적 방문과 비계획적·비정기적 방문을 의미함. 미국 메디케어는 방문의료가 포함된 통합적 관리를 재택의료로, 의사 방문을 재택방문으로 하며 방문의 계획적·정기적 수행 여부에 따른 용어 구분은 없음

- 일본과 미국 모두 비대면 모니터링 서비스는 포괄적 서비스를 제공하는 재택의료에 포함되기도 하고 재택의료와 무관하게 단독 사업으로 수행되기도 함. 단독 사업인 경우 원격 생체정보 모니터링(RPM: Remote Physiological Monitoring)과와 원격치료모니터링(RTM: Remote Therapeutic Monitoring)이 구분됨

○ 심층 면접 결과 대부분 재택의료는 환자중심 용어로 환자가 집에서 받는 모든 의료서비스를 의미하며 방문의료를 필수적으로 포함해야 한다고 응답함. 의사 방문은

일본 사례에 따라 방문진료와 왕진을 구분해야 한다는 의견도 확인함

○ 재택의료 개념에 대한 선행 연구는 가정(거주지), 포괄적 의료서비스, 통원 곤란자, 다학제 관리가 주요 키워드로 확인됨. 방문의료는 재택의료의 하위 개념으로 의료진이 환자의 집을 직접 방문하여 포괄적 의료서비스를 제공하는 것이며, 방문진료는 이 중 의사가 수행하는 방문의료를 지칭함

- 미국 AHRQ(Agency for Healthcare Research and Quality)는 재택기반 일차의료(Home Based Primary Care)를 ①일차의료 기관의 의료서비스 제공자의 방문(전화상담 혹은 간호사 단독 방문 제외), ②환자 가정에서 제공(기관 거주자 제외), ③장기적·지속적 치료(단기 급성기 치료나 일회성 방문 제외), ④포괄적 일차의료 서비스(단일질환 관리 제외)로 구분함(Totten AM et al, 2016)

〈표 74〉 재택의료 개념에 관한 선행 연구

구분	세부 내용
재택의료	• 가정에서 제공되는 포괄적인 의료서비스로 방문의료, 방문진료, 왕진을 모두 포함하는 개념(송경신 외, 2024) • 의료를 받는 사람의 거주지 등에서 제공되는 보건의료서비스(김희년 외, 2024) • 지역에서 거주하는 통원곤란자의 가정을 의료·간호·복지 등의 전문직이 방문하여 환자와 가족의 의사를 반영하여 제공하는 포괄적이고 전인적인 의료(Yoshimura R, 2023) • (Home Healh care) 숙련된 의료인이 의사의 지시에 따라 환자의 집에서 제공하는 의료·재활·복지 서비스 체계(Ellenbecker, 2008)
방문의료	• 의사 이외의 보건의료 인력이 환자 가정에서 수행하는 보건의료 활동으로 방문간호, 재활, 복약지도, 건강관리, 돌봄 및 복지서비스를 제공(이건세, 2019) • (Home Visits) 의사, 간호사 등 의료전문가가 환자의 집을 방문해서 진료·상담·평가하는 의료행위(Theile et al. 2011)
방문진료	• 의사가 직접 환자의 가정을 방문하여 수행하는 진료활동으로, 진료, 처치, 처방, 상담 등의 의료적 서비스를 제공하는 것. 왕진은 의료기관 방문이 불가능한 환자의 요청에 따라 환자의 가정을 비연속적으로 방문하여 제공되는 진료(오영인 외, 2019) • 의사가 환자의 가정을 방문하여 진료를 행하는 것(이건세, 2019) • 의사가 환자를 방문하여 진료서비스를 제공하는 것(김희년 외, 2024)

○ 일차의료 방문진료 수가 시범사업은 계획적, 정기적 수행 여부에 따른 용어를 구분하지 않으며, 일본 외의 구분 사례를 확인하지 못함에 따라 방문진료와 왕진을 별도로 구분하지 않음. 환자평가, 계획수립, 교육·상담, 비대면 관리 등은 외래 중심 주치의 사업에서도 제공 가능하나, 방문의료는 재택의료에서 주로 이루어지기 때문에 재택의료의 하위 개념이자 필수 요소임

○ 국내외 현황, 심층 면접 및 선행 연구에 따라 건강보험 재택의료, 방문의료 등의 개념을 대상자와 서비스 내용을 모두 고려하여 다음과 같이 제시함

- (재택의료) 의료적 필요가 있는 거동불편 재가환자에게 다학제 의료진이 제공하는 계획적·정기적·포괄적 의료서비스
- (방문의료) 재택의료의 하위개념으로 의료진이 환자의 가정에 방문하여 제공하는 의료서비스
- (방문진료) 의사의 권한인 진료를 수행하기 위한 방문의료의 하위 개념으로 서비스 제공 주체를 의사로 한정함

2. 건강보험 재택의료 포괄모형(안)

가. 건강보험 재택의료 중증도 구분

○ 본 연구에서 검토한 15개 시범사업은 사업목적과 개요에 따라 통합관리를 위한 재택의료, 방문진료, 비대면 모니터링으로 구분됨. 대상 환자 특성과 주로 청구하는 의료기관의 종별 구분, 선행 연구 결과에 따라 시범사업별 중증도 차이를 확인함

- 대면서비스인 재택의료와 방문진료는 하나의 그룹으로 중증도를 구분함
  - 가정용 인공호흡기, 가정산소요법 등 사용 중증소아에게 상급종합병원이 재택의료를 제공하는 중증소아 재택의료 시범사업은 중증환자군 대상 사업임
  - 병원과 종합병원이 급성기 퇴원 이후의 환자에게 방문재활 등을 제공하는 정신질환자 지속치료 지원 시범사업과 재활의료기관 수가 시범사업은 중등증 환자군 대상임
  - 의원의 의사가 방문진료를 하거나 다학제 그룹이 포괄적 의료서비스를 제공하는 사업은 경증 환자를 주 대상으로 함. 다만, 일차의료 방문진료 수가 시범사업 대상자 중 장기요양 1,2등급 와상환자와 산소치료, 인공호흡기 요양비 대상자의 본인부담률을 15%로 하는 현황을 고려하면 일부 중증환자가 포함되기도 함. 또한 장애인 건강주치의는 사업모형이 다양해 상급종합병원에서 중증장애인을 관리할 수 있으나, 실제 청구는 대부분 의원급에서 이루어지는 점을 고려하여 경증 재택의료로 분류함

- 비대면 모니터링은 선행 연구에서 제안한 중증도 구분을 적용했으며(장석용 외, 2024), 별도로 언급하지 않은 재활환자와 결핵환자는 병원(50.8%)과 종합병원(66.7%) 이용 비율이 크며, 집중관리가 필요한 회복기 환자를 대상으로 하는 사업의 특성을 고려하여 중등증에 포함함

〈표 75〉 건강보험 재택의료 시범사업 별 대상자와 제공기관 특성에 따른 중증도 구분

구분	중증도	건강보험 재택의료	대상 환자	주 제공 기관
재택의료, 방문의료	중증	중증소아 재택의료 시범사업	만 18세 이하 재택의료가 필요한 의료적 요구가 있는 중증소아	상급종합병원
	중등증	정신질환자 지속치료 지원 시범사업: 병원기반 사례관리	정신건강의학과 퇴원예정환자	병원, 종합병원
		재활의료기관 수가 시범사업: 방문재활	중추신경계, 근골격계 등으로 집중재활 치료 후 퇴원 환자	재활의료기관 지정 병원
	경증	일차의료 방문진료 수가 시범사업	거동불편자	의원
		일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업		
		장애인 건강주치의 시범사업	경증·중증 장애인	
		치매관리 주치의 시범사업	치매 환자 (입원환자 제외)	
비대면 모니터링	중증	가정용 인공호흡기 환자 재택의료 시범사업	가정용 인공호흡기 처방 요양비 급여 대상자	상급종합병원
		심장질환자 재택의료 시범사업	ICD, CRT, 심박기 삽입 심장질환자	상급종합병원
	중등증	복막투석환자 재택관리 시범사업	만성신장병 5기 환자	병원, 상급종합병원
		1형당뇨병 재택의료 시범사업	인슐린 투여가 반드시 필요한 제1형 당뇨병 환자	종합병원, 상급종합병원
		암환자 재택의료 시범사업	장루조성술을 받은 암환자	상급종합병원
		암환자(요루) 재택의료 시범사업	요루조성술을 받은 암환자	상급종합병원
		재활환자 재택의료 시범사업	근골격계 수술환자 또는 중추신경계 질환자	병원
		결핵환자 재택의료 시범사업	결핵 및 다제내성 결핵 환자	종합병원

○ 중증도 구분 결과 방문진료와 재택의료는 대상 환자의 특성과 서비스의 종류에 따라 의원부터 상급종합병원까지 다양한 의료기관에서 제공되며, 비대면 모니터링은 주로 병원급 이상 의료기관에서 중등증 환자를 대상으로 시행함을 확인함

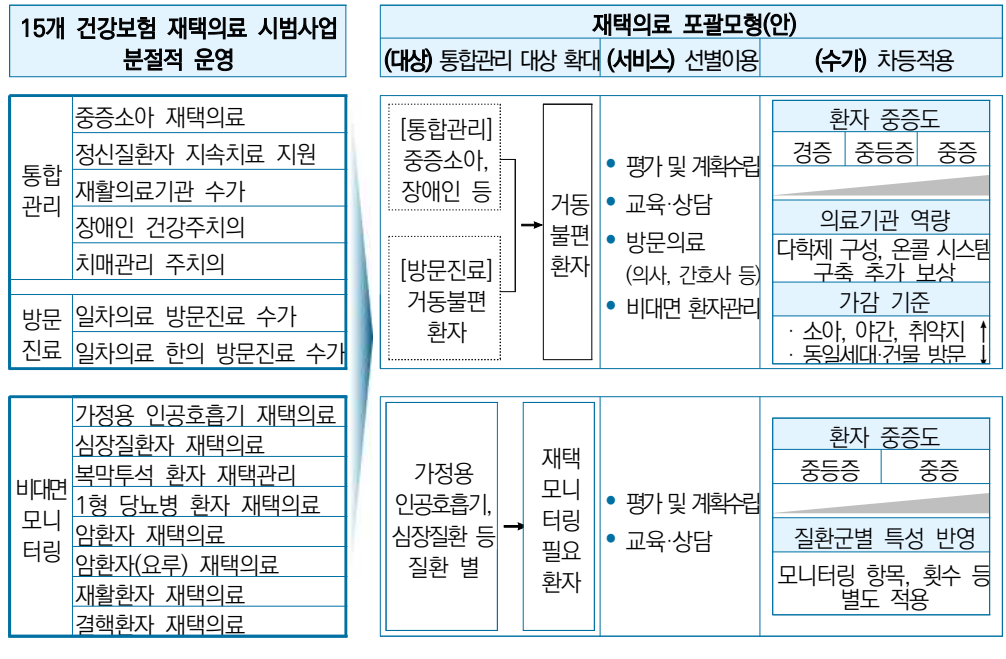
- 다학제팀 구성이 필수 요건이 아닌 방문진료와 주치의 사업은 의원 중심이며, 정신질환자나 재활이 필요한 환자 등 특정 질환자를 대상으로 한 서비스는 병원급 이상이 담당함. 중증의 소아·청소년 환자와 같이 고위험 전문관리 환자의 입원 대체 목적 재택의료는 상급종합병원 중심으로 이루어짐

- 비대면 모니터링은 환자의 상태를 지속적으로 관찰하고 이를 진료·치료 과정과 연계하는 경우가 많음. 이에 전문 인력과 장비, 데이터 관리 체계를 갖춘 병원급 이상에서 수행하는 것이 적합해 경증 구분을 하지 않음

○ 가정간호 기본방문과 가정형호스피스는 의원부터 상급종합병원까지 모든 의료기관이 제공 할 수 있음. 가정간호 기본방문은 상급종합병원이 전체 제공 기관의 8.9%이지만 이용 환자의 41.1%를 담당하며, 임종기 중증 환자를 대상으로 하는 가정형 호스피스 의원 비율이 17.8%인 현황을 고려하여 시범사업별 중증도 구분은 제한적으로 해석해야 함

나. 건강보험 재택의료 포괄모형(안)

○ 앞서 검토한 내용을 바탕으로 재택의료 시범사업 유형구분에 따른 포괄모형을 다음과 같이 제안함. 방문진료는 재택의료 하위개념으로 포괄모형은 재택의료와 비대면 모니터링 두 범주로 구분함



[그림 15] 건강보험 재택의료 포괄모형(안)

1) 재택의료

○ (대상 환자) 현재 통합관리를 위한 재택의료 대상자는 회복기 재활환자, 정신질환자, 장애인, 중증소아, 치매환자로 제한됨. 재택의료 대상자는 상병이나 자격으로 제한하지 않고 의학적 상태에 따라 구분하여 거동이 불편한 환자 전체로 확대함. 거동불편 환자의 의학적 필요에 따라 의사, 간호사 등 다학제팀의 방문의료와 비대면 관리, 교육·상담 등의 서비스를 받을 수 있도록 해야함

- 거동불편자 대상인 일차의료 (한의)방문진료에는 통합관리를 위한 평가 및 계획수립, 교육·상담, 비대면 관리, 다학제 방문 등이 서비스 내용에 포함되지 않음. 건강보험 재택의료를 2개 이상 이용한 환자의 약 70%가 가정간호 기본방문과 방문진료 등을 상호보완적 조합으로 이용하고 있어. 통합관리의 필요이 확인됨
  - 미국, 일본 모두 의료적 필요가 있는 거동불편 환자에게 재택의료를 제공함
  - 재택의료 사업별 주상병 확인 결과 거동불편에 영향이 있을 것으로 예상되는 근골격계질환(등통증, 관절장애 등), 뇌경색증, 척추질환 등과 고혈압, 당뇨병 등 만성질환이 다수로 대상자를 상병으로 특정할 수 없음을 확인함
- (중복) 일차의료 방문진료와 장애인 건강주치의 등 중복이용 사례를 확인했으나, 단일기관 제공 사례가 95%이며 해당 의료기관 수가 상대적으로 적어 환자의 중증도 등 상태와 횟수 기준에 따른 이용 현황 파악이 불가해 현 상황에서 남용이라 판단하기 어려움

○ (제공 기관) 재택의료 제공 의료기관의 자격과 역할을 관리 환자 중증도, 온콜 시스템 구축, 다학제 팀 구성 등 기관 역량에 따라 구분하는 방안을 고려함. 현재 재택의료는 주로 의료기관 종별구분에 따라 의원은 경증, 상급종합병원은 중증을 담당하고 있으나, 현행 종별 구분에 의료기관 역량에 따라 환자 중증도와 제공 서비스의 차이를 추가로 구분하고, 보상 수준을 차등화하는 체계로 전환해야 함

- 방문의료 제공을 위해서는 물리적 이동 거리가 중요해 지역사회 일차의료 중심의 제공체계를 기본으로 하되, 만성질환 관리에서 중증질환·임종 관리까지 아우르는 폭넓은 서비스 스펙트럼을 감안할 때 병원급 이상 전문기관의 역할도 필요함. 일반의원이 수행하기 어려운 고난이도 치료, 방문재활과 같은 전문 인력 필요 특수분야, 고위험 환자의 입원 대체 재택의료 등에서 병원급 이상의 전문기관 역할이 요구됨

- 현황 분석 결과 참여 기관의 78%가 의원급이며, 일본과 미국은 환자의 임상적 특성과 의료적 필요성을 고려해 의료기관 역량에 따른 제공 범위와 자격을 제한하는 사례를 함께 고려함

○ (제공 서비스) 재택의료 개념을 다학제 의료진이 제공하는 계획적·정기적·포괄적 의료서비스로 함에 따라 치료 및 관리 계획에 따른 평가 및 계획수립, 교육·상담, 비대면 관리, 의사, 간호사, 물리·작업치료사 등의 방문의료를 제공함

- 일차의료 방문진료 수가 시범사업 이용환자의 63.5%가 1회만 이용하며, 시범사업 신청 의료기관 중 의사 단독개원이 89.3%인 현황(홍미영 외, 2022)과 일본이 왕진을 별도의 수가로 구분하는 사례를 고려할 때, 단기 방문진료 단독 이용도 가능하도록 해야 함

- 지속적인 재택 통합관리필요 환자는 방문의료 이외의 서비스인 평가 및 계획수립, 교육·상담, 비대면 관리를 가정형 호스피스 통합환자 관리료와 장기요양 재택의료센터 재택의료기본료와 같은 통합관리 묶음수가(가칭: 재택종합 관리료)로 적용할 수 있음. 다만 묶음수가는 환자 중증도 반영과 의료질 관리가 어렵다는 심층 면접과 전문가 자문 결과에 따라 관리방안에 대한 검토가 선행되어야 함

- 대부분의 비대면 서비스가 환자관리 수가로 구분되어 수가 구분이 명확하지 않음. 전화 등을 이용한 의료진의 환자 상태 확인, 환자가 필요 시 의료진에게 연락할 수 있도록 하는 온콜 시스템, 다학제 팀 회의 등 제공 서비스에 따른 수가 구분을 명확해야 함

  • 일본과 미국은 모니터링과 상태 확인, 팀 회의를 다른 의료행위로 구분함. 환자 상태 확인과 온콜시스템은 의료진과 환자 사이 핫라인 구축(전화번호 공개)의 개념으로 통합할 수 있으나 행위분류를 명확히 하기 위해 팀 회의는 별도의 수가로 분류하는 것이 바람직함

○ (가산기준) 환자의 중증도와 서비스 제공 기관의 역량, 소아, 의료접근성 취약지, 공휴일 및 야간 방문 여부에 따라 가산 기준을 적용할 수 있음. 다만, 중증도 구분과 기관 자격 기준에 대한 추가 논의가 필요함

- (중증도) 중증도(중증소아, 임종기, 장기요양 1,2등급, 인공호흡기 사용 등), 사회적 요구도(장애인, 정신질환자 등)가 높은 환자군에게 재택의료 및 비대면 모니터링

제공 시 보상 수준과 횟수 기준을 상향하여 인정함

- 미국 CMS의 OASIS는 재택의료 환자를 위한 표준화된 임상평가 도구임. 일차의료 만성질환관리 시범사업의 환자관리료의 환자 위험도 등급분류와 요양병원 입원환자 평가표 등의 사례도 참고할 수 있음. 향후 건강보험 재택의료 환자 중증도 판정도구를 개발하여 대상자 판정과 중증도 가산 기준을 마련해야 함

- (본인부담률 조정) 일차의료 방문진료는 장기요양 1, 2등급 와상환자와 산소치료, 인공호흡기 요양비 대상자의 본인부담률을 일반 환자의 50%수준으로 하여 수가 수준이 아닌 진입 문턱을 낮추는 방식으로 인센티브를 부여함. 이에 중증도 등으로 재택의료 필요가 상대적으로 큰 환자군은 본인부담률 인하 대상으로 고려해야 함

○ (감산 기준) 방문의료의 경우 동일 세대·동일 건물 방문 시나 같은 날 다른 의료기관의 방문 등에 대한 감산 기준을 동일하게 적용해야 함

○ (산정 기준) 평가 및 계획수립 1회/연, 교육·상담 및 비대면 관리 1회/월, 방문의료는 초기 계획수립에 따라 제공함. 재택의료 환자를 기준으로 서비스 제공자(다학제팀, 의사) 단위 방문 혹은 등록 환자 수 제한 기준과 환자 단위 횟수 기준 모두 적용함

- 서비스 제공자 단위 기준은 방문의료 질관리 목적에 해당하는 것이 대부분으로 일차의료 방문진료(60회/월, 재택의료 센터 100회/월)와 가정간호 기본방문(7회/일)가 있으며, 장애인 건강주치의 주치의 당 등록 환자 수 200명, 일차의료 만성질환 관리의원 당 500명 제한 기준을 운영 중임. 건강보험의 비용·효과성을 고려한 환자 단위 횟수 기준은 일반적으로 평가 및 계획수립 연 1회, 재수립 1회 추가 인정, 일차의료 방문진료 주 3회 이내, 중증소아 재택의료 물리·작업치료사 방문료 연 18회 이내, 질환군별 재택의료 환자관리료 월 1회 등의 기준이 있음

- 환자 상태에 따라 필요한 서비스 제공 횟수가 다를 수 있으나 장기요양 재택의료 센터의 의사 월 1회, 간호사 월 2회 이상, 연 1회 포괄평가 및 계획수립, 월 2회 사례회의 등의 기준을 참고할 수 있음

- 참고로, 일본은 지속 관리 환자 수가 많을수록 전문기관으로 인식하여 추가 수가를 인정하며, 동일 환자에게 같은 날 두 번 이상 방문하거나, 2개 이상의 의료기관이 방문하면 수가 감산의 사유가 됨

○ (서비스 제공 기간) 회복기 재활환자와 사례관리가 필요한 정신질환자, 일회성 일차

의료 방문진료 이용 환자 등 단기이용 환자를 제외한 지속적·포괄적 재택의료 환자의 서비스 제공 기간을 특정하기는 어려우나 치료계획 수정과 대상자 지속 여부 확인을 위한 정기적 재평가를 실시해야 함

- 미국 메디케어는 재택의료 이용 환자를 6개월 주기로 평가하고 세부 내용을 기록으로 남기도록 하며, 장애인 건강주치의와 장기요양 재택의료 센터는 연 1회 환자 상태를 재평가함
- 다만, 심층 면접 결과 거동불편의 의료적 필요가 있는 환자에게 서비스 제공 기간을 한정하는 것은 의료이용 제한으로 바람직하지 않으며, 기간이 아닌 환자 대상 제공 횟수 기준으로 이용 수준을 조절해야 한다는 의견을 고려해야 함. 또한 현황 분석 결과, 고령의 만성중증질환자의 비중이 크게 나타나 재평가를 통한 서비스 제공 기간 조절 기능이 얼마나 효과적으로 작동할지는 불확실함

2) 비대면 모니터링

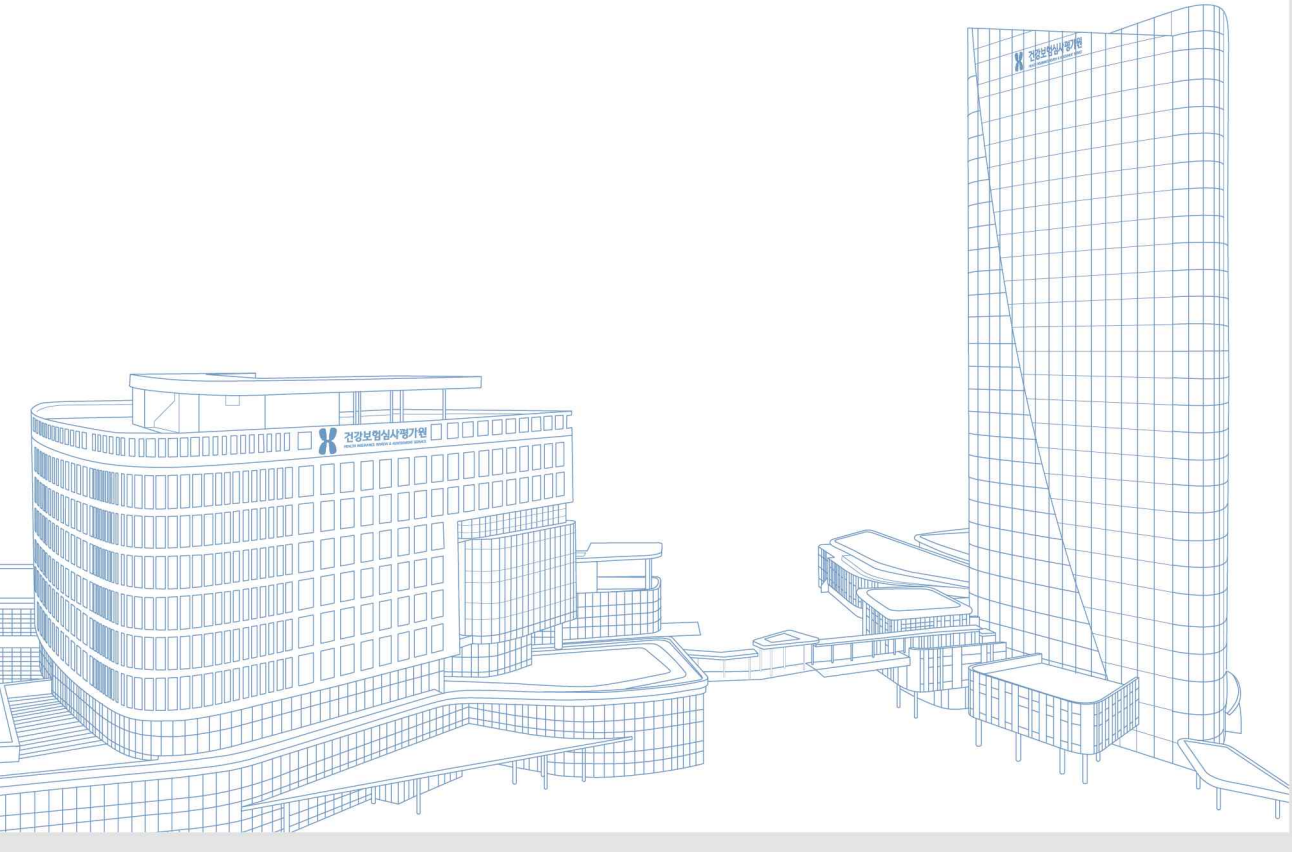
○ 질환군별로 구분된 사업을 하나로 통합하고 중증도에 따른 차등 수가를 적용하며 사업명은 서비스 특성을 반영하여 재택의료가 아닌 재택관리로 함. 질환별 모니터링 지표와 서비스 제공 시간 등은 세부 사항으로 정함

- 교육·상담과 비대면 관리만 제공하는 사업이 재택의료를 대변하지 않아 질환군별 재택의료 시범사업의 명칭 변경이 필요함. 건강보험 재택의료의 비대면 서비스는 대부분 환자관리로 구분되며, 복막투석환자 대상 사업도 재택관리 시범사업으로 운영되고 있는 점을 고려하여 이들을 재택관리리 시범사업으로 통합할 것을 제안함
- 선행 연구에서는 가정용 인공호흡기와 심장질환자를 중증군으로 복막투석, 암환자(장루·요루), 1형 당뇨병은 중등증군으로 구분함. 또한 방문의료 등과의 연계가 필요함을 제안함(장석용 외, 2024). 심층 면접의 질환군별로 상이한 서비스 제공 시간과 산정 횟수는 의학적 타당성이 부족해 청구 현황이나 중증도에 따른 단순화 방안이 필요하며, 재활환자와 결핵은 위험도가 낮은 질환으로 모니터링 필요도가 비교적 낮다는 결과를 반영함
- 일차의료 만성질환 통합관리와의 경계 설정을 위하여 병원 이상 의료기관의 관리가 필요한 환자군을 대상으로 하며, 가정용 인공호흡기 환자 등 방문의료 필요가 있는 경우 재택의료 제공 및 연계 체계를 갖추어야 함

HIRA
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

제7장

결론 및 제언



제7장 결론 및 제언

○ 방문의료가 있거나, 사업명에 재택을 포함되는 15개 건강보험 시범사업은 통합·포괄적 의료서비스, 비대면 관리, 방문의료로 구분하며, 일부 차이가 있으나 의료접근성 향상, 지속적·통합적 의료서비스 제공, 불필요한 입원 및 의료비 감소 등을 목적으로 특정 환자에게 분절적으로 운영 중임

○ 이 연구는 건강보험 재택의료의 효율성과 일관성을 확보하고 실효성 있는 운영을 위한 포괄모형 개발을 목적으로 함. 이를 위해 국내·외 유사 사례를 파악하고 청구 현황 분석과 이해관계자 심층 면접 등을 수행함

○ 우리나라 건강보험 재택의료는 주치의, 재택의료, 사례관리, 방문, 가정 등의 용어 사용이 혼재됨. 예를 들어, 중증소아 재택의료와 가정용 인공호흡기 환자 재택의료는 명칭이 유사하지만 서비스 내용이 다르며, 비대면 관리 사업인 질환군별 재택의료는 재택관리라는 용어를 사용하기도 함. 이러한 용어의 불일치는 사업의 목적과 내용에 대한 명확한 이해를 방해함

- 제공 기관은 의료기관 종별로 구분되며, 전문진료센터·전문병원 등 지정 여부나 상근 의료인력 수준에 따라 차등화되기도 함. 의사나 간호사가 단독으로 방문하는 사업을 제외하고 대부분 팀 단위 서비스를 제공한다는 특징이 있음
- 통합관리를 목적으로 하는 재택의료는 평가 및 계획수립, 교육·상담, 방문의료, 비대면 모니터링 등의 서비스를 모두 제공하며, 비대면 모니터링은 교육·상담과 모니터링만 포함함
- 시범사업 수가 수준과 가산 및 감산, 산정 기준 등도 대부분 상이함

○ 일본과 미국은 모두 건강보험 재택의료 대상자를 자력 이동이 곤란한 자와 같이 상병이 아닌 상태로 명시함. 미국은 칩거상태의 환자가 전문간호 등의 필요가 있음을 문서로 인증함. 다직종 서비스 제공을 보장한다는 공통점도 확인됨. 일본은 의사, 간호사, 약사, 영양사, 재활전문가 등이 미국은 간호, 물리·작업·언어 치료뿐만 아니라 요양보호, 사회서비스 등이 포함되는 포괄적 서비스를 인정함

○ 15개 건강보험 재택의료와 방문의료가 포함된 가정간호 기본방문, 가정형 호스피스의 청구 현황을 함께 분석한 결과 2024년 기준, 1개 재택의료만 이용한 환자가 전체의 94.7%로 가장 많음. 2개의 재택의료 이용은 4.3% 수준임을 확인함. 2024년 2개 사업 이용 환자 5,034명이 가장 많이 참여한 사업조합은 가정간호 기본방문과 일차의료 방문진료 수가 시범사업으로 이용 환자의 57.6%를 하나의 의료기관에서 제공함. 해당 기관 수는 25개소임

○ 일대일 심층 면접 결과 모든 그룹에서 재택의료의 긍정적 효과에 대한 인식이 높음을 확인함. 시범사업별 분절적 운영과 용어 혼재를 문제로 지적해 통합 및 개선의 필요성을 강조함. 재택의료는 의료적 필요가 있는 거동불편 환자에게 다학제 의료진이 제공하는 계획적·정기적·포괄적 의료서비스로, 비대면 모니터링과는 구분되어야 함

○ 연구 내용을 종합하여 건강보험 재택의료 시범사업을 통합관리하기 위해 재택의료, 방문진료, 비대면 모니터링으로 유형화하고, 거동불편자 대상 재택의료와 비대면 모니터링 단독 제공의 두 범주로 재정리함. 기존 방문진료는 재택의료 하위개념으로 서비스 제공 범위와 대상을 확대하는 방향으로 제안함

○ 본 연구는 개별적·분절적으로 추진되고 있는 건강보험 재택의료 시범사업의 운영 현황을 통합적으로 분석하였고, 개별 심층 면접, 전문가 자문을 통하여 비교·검토하고 향후 추진 방향을 제안했다는 점에서 의의가 있음

○ 이용자를 중심으로 한 건강보험 재택의료 포괄모형 제공을 위해서는 장·단기 추진 계획을 마련해야 함

- (단기) 사업별 산정 횟수와 간격, 가산 및 감산 기준, 환자와 서비스 제공자 횟수, 본인부담률 등 세부 기준을 일관성 있게 정비해 동일 환자가 유사한 서비스를 받아도 일관된 수준에서 적용받도록 해야 하며, 환자의 재택의료에 대한 요구도와 지불의사 등에 관한 조사가 필요함. 또한 비대면 모니터링 관련 사업을 통합하고, 본 연구에서 제시한 재택의료 개념 체계에 따라 사업명을 조정할 필요가 있음

- (중기) 거동불편 환자 선정 기준과 중증도 판정 도구를 개발하여 환자의 의료적 필요에 따른 건강보험 재택의료 제공을 정교화 해야 함. 또한 환자단위 관리 시스템을 구축하여 진입·이용 현황과 자료 제출을 통합적으로 관리할 수 있도록 해야 함. 마지막으로

서비스 제공자 질관리를 위해 전문영역별 재택의료 교육 프로그램 마련이 요구됨

- (장기) 특성과 서비스 조합에 따른 차등 지불모형을 적용하여 재택의료의 특수성을 보다 잘 고려한 합리적인 지불체계를 마련해야 하며, 재택의료 질에 대한 검토가 필요함

○ 건강보험 재택의료 포괄모형의 실제 적용에는 여러 법적·제도적 한계가 존재함. 비대면 모니터링이나 방문재활 등은 아직 명확한 법적 근거가 마련되어 있지 않음. 또한 장애인 건강주치의, 가정간호 기본방문, 가정형 호스피스 등이 각 근거법령에 따라 독립적으로 추진되고 있어, 재택의료의 개념과 구체적 운영 기준을 일관되게 정립하기 어려움. 따라서 건강보험 재택의료를 안정적으로 정착시키기 위해서는 재택의료 관련 법의 정비가 선행되어야 함

○ 재택의료는 의료기관 밖에서 이어지는 특성으로 건강보험의 가정간호 기본방문과 장기요양의 방문간호, 장기요양 재택의료 센터 등 재원 사용의 우선순위가 모호할 수 있어 건강보험과 장기요양의 역할 구분이 필요함. 질병치료와 증상악화 방지를 목적으로 하는 경우 건강보험 적용을 우선하고, 이에 대한 의학적 근거를 체계적으로 관리·검증할 수 있는 시스템을 고려할 수 있음

- 일본은 동일·유사 서비스의 경우 장기요양 우선 적용을 원칙으로 하되, 중증·희귀질환, 급성악화 등은 건강보험을 우선 적용함. 본 연구의 심층 면접에서도 이와 유사한 의견이 제시됨

○ 건강보험에서 재택환자를 대상으로 하는 사업은 본 연구에서 검토한 15개 시범사업 외에도 요양병원, 급성기병원, 재활병원 퇴원환자 대상 지역사회 연계와 비대면 진료 등이 포함되므로 향후 관련 서비스 전반에 대한 포괄적 검토가 필요함. 또한 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」이 2026년 시행 예정임에 따라 건강보험 재택의료뿐만 아니라 보건, 복지, 돌봄 등 관련 정책이 체계적으로 연계될 수 있도록 환자중심 지원체계를 마련해야 함

○ 이 연구는 다음과 같은 제한점이 있음

- 첫째, 시범사업 별 제공 기간과 목적 등에 따라 산정 기준이 상이하여 환자를 중심으로 유사·동일한 서비스가 누구에게 얼마나 제공되었는지 파악하지 못함. 또한 환자별 시범사업 진입 시점이 다르지만 환자 단위의 관리체계가 없어 최초진입 시점을 고려하지 못함

- 둘째, 일대일 심층 면접은 일부 집단의 참여자 수가 적고 집단 간 비율의 불균형으로 특정 집단의 의견이 과대 또는 과소하게 반영되었을 가능성이 있음. 다만, 환자군 대상자 수는 적지만 이론적 포화에 도달하여 방법론적 적절성이 확보되었음을 질적 연구 전문가 자문을 통하여 확인함. 아울러 건강보험 재택의료와 관련된 모든 이해관계자가 참여하지 못해 사업별 특수성이 충분히 반영되지 않았을 수 있음. 마지막으로 면담 과정을 연구책임자가 직접 진행해 참여자의 응답조정과 연구자의 사전지식과 경험이 질문 및 해석 과정에 영향을 미쳤을 가능성이 있음

참고문헌

■ 보고서 및 학술지(단행본) 등

- American Medical Association. CPT® evaluation and management (E/M) descriptors and guidelines 2023. Chicago (IL): American Medical Association; 2023.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Calendar year (CY) 2025 home health prospective payment system final rule fact sheet (CMS-1803-F). Baltimore (MD): CMS; 2024.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. CY 2024 per-visit payment amounts for home health agencies (HHAs). In: MLN Matters: MM13411. Baltimore (MD): CMS; 2025.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. CY 2026 HH PPS proposed rule. Fed Regist. 2025;90:29108 (FR 2025-12347).
- Centers for Medicare & Medicaid Services. CY2023–2026 HH PPS proposed rules. Fed Regist. 2022;87:37600 (2022-13376); 2023;88:43654 (2023-14044); 2024;89:55312 (2024-14254); 2025;90:29108 (2025-12347).
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Definition and Uses of Health Insurance Prospective Payment System (HIPPS) Codes. Version 10. CMS. 2022.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Expanded home health value-based purchasing (HHVBP) model resource index. Baltimore (MD): CMS; 2024.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Home health PPS case-mix weights. Baltimore (MD): CMS; 2025.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Home health prospective payment system (HHPPS). Baltimore (MD): CMS; 2024.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare and Medicaid programs; calendar year (CY) 2026 home health prospective payment system (HH PPS) rate update. U.S. Department of Health and Human Services; 2025.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare physician fee schedule final rule summary: Calendar year 2023. Baltimore (MD): CMS; 2022.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare program; calendar year (CY) 2023

home health prospective payment system rate update. Baltimore (MD): CMS; 2022 Nov.

- Centers for Medicare & Medicaid Services. Outcome and Assessment Information Set OASIS-E manual. Baltimore (MD): CMS; 2024 Jan.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Overview of the patient-driven groupings model (2018). Fed Regist. 2019;84:60490.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Physician fee schedule search results: CPT codes 99341–99350. Baltimore (MD): CMS; 2024.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Remote patient monitoring. Medicare telehealth. U.S. Department of Health & Human Services; 2025.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. Telehealth & remote patient monitoring (MLN Booklet No. MLN901705). U.S. Department of Health and Human Services; 2025.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. The Medicare claims processing manual (Pub. 100-04). Baltimore (MD): CMS; chapter 10.
- CGS Administrators, LLC. Home health billing codes. Nashville (TN): CGS Medicare; 2025. Available from: https://cgsmedicare.com/hhh/claims/hh_billing_codes.html
- Ellenbecker CH. Home health care. In: Harris JE, editor. Public health nursing. 8th ed. St. Louis (MO): Mosby; 2008. p. 623-34.
- Giardino AP, De Jesus O. Case management. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.
- Giusti R, Ravoni G, Porzio G. The clock is ticking: can palliative care survive the dual crises of time and workforce shortages? BMJ Support Palliat Care. 2025;15(2).
- Hood C, Sikka N, Manaoat Van C, Mossburg SE. Remote patient monitoring. AHRQ PSNet. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality; 2023 Mar 15.
- Hughes SL, Weaver FM, Giobbie-Hurder A, Manheim L, Henderson W, Kubal JD, Ulasevich A, et al. Effectiveness of team-managed home-based primary care: A randomized multicenter trial. JAMA. 2000;284(22):2877-85.
- Jane Ritchie, Jane Lewis, Carol McNaughton Nicholls, Rachel Ormston. Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students&Researchers. National Centre for Social Research. 2013.

- MBuntin MB, Hoadley J, Stevenson DG, et al. Medicare Payment Advisory Commission. Chapter 8: Home health care services. In: Report to the Congress: Medicare Payment Policy. Washington, DC: MedPAC; March 2023.
- Medicare Payment Advisory Commission. Home health care services payment system. Washington (DC): MedPAC; 2024..
- Medicare Rights Center. Home health basics. Medicare Interactive. 2025.
- Mun H, Cho K, Lee S, Choi Y, Oh SJ, Kim YS, et al. Patient-centered integrated model of home health care services in South Korea (PICS-K). Int J Integr Care. 2023;23(2):6.
- Patton MQ. Qualitative research & evaluation methods. 4th ed. Thousand Oaks (CA): Sage Publications; 2015.
- R. Giusti, G. Ravoni, G. Porzio(2025), The clock is ticking: can palliative care survive the dual crises of time and workforce shortages?, BMJ Supportive & Palliative Care, 2025.2.
- Ritchie J, Lewis J, McNaughton Nicholls C, Ormston R. Qualitative research practice: A guide for social science students & researchers. London: National Centre for Social Research; 2013.
- Sun Y, Iwagami M, Komiyama J, Sugiyama T, Inokuchi R, Sakata N, et al. Association between types of home healthcare and emergency house calls, hospitalization, and end-of-life care in Japan. J Am Geriatr Soc. 2023;71(6):1795-805.
- Theile G, Kruschinski C, Buck M, Hummers-Pradier E. Home visits—central to primary care, tradition or an obligation? A qualitative study. BMC Fam Pract. 2011;12:24.
- Totten AM, White-Chu EF, Wasson N, Morgan E, Kansagara D, Davis O'Reilly C, et al. Home-based primary care interventions: comparative effectiveness reviews, No. 164. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016.
- Valluru G, Yudin J, Patterson CL, Werner RM. Integrated home- and community-based services improve community survival among Independence at Home Medicare beneficiaries without increasing Medicaid costs. J Am Geriatr Soc. 2019;67(7):1495-501.
- Wajnberg A, Wang KH, Aniff M, Kunins HV. Hospitalizations and skilled nursing facility admissions before and after the implementation of a home-based primary care program. J Am Geriatr Soc. 2010;58(6):1144-7.

- Yoshimura R. Home medical care in Japan: Requirements for its patient-centered operation. Kyoto: Graduate School of Kyoto Women's University; 2023.
- 강은나, 김혜수, 정찬우, 김세진, 이선희, 주보혜, 황남희, 김경래, 이혜정, 최경덕. 2023년도 노인실태조사. 보건복지부, 한국보건사회연구원; 2023.
- 건강보험심사평가원. 만성질환 통합관리 수가 안내. 건강보험심사평가원; 2024.
- 김창오, 장숙랑, 서동민, 이혜진, 홍종원, 이태훈, 이자경, 최은희. 지역사회 거주지원을 위한 의료·요양서비스 연계강화 방안-재택 의료 활성화 방안 중심. 보건복지부, 성공회대학교; 2021.
- 김창오, 홍종원, 조미희, 최은희, 장숙랑. 거동불편 대상자를 위한 방문진료의원 모형: 1년 6개월간의 운영사례 보고. 한국노년학. 2020;40(60):1403-28.
- 김희년, 문석준, 고든솔, 유원섭, 정형선. 인구 고령화에 따른 방문진료 및 재택의료 제도화 방향. 한국보건사회연구원; 2024 8.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 1형 당뇨병 환자 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2024.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 가정용 인공호흡기 환자 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2023.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 결핵환자 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2025.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 급성기 환자 퇴원지원 및 지역사회 연계활동 제2단계 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2025.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 복막투석 환자 재택관리 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2023.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 심장질환자 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2023.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 암환자 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2025.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 암환자(요루) 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2025.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 일차의료 방문진료 수가 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2024.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 일차의료 한의 방문진료 수가 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2025.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 장애인 건강주치의 4단계 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2024.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 재활의료기관 수가 4단계 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2024.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 재활환자 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2024.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 정신질환자 지속치료 지원 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2025.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 중증소아 재택의료 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2025.
- 보건복지부, 건강보험심사평가원. 치매관리주치의 시범사업 지침. 건강보험심사평가원; 2024.
- 보건복지부, 국민건강보험. 장기요양 재택의료센터 시범사업 지침. 보건복지부; 2024.

- 보건복지부, 질병관리본부, 한국건강증진개발원, 국민건강보험, 건강보험심사평가원. 일차의료 만성질환관리 시범사업 지침. 보건복지부; 2024.
- 송경신, 심유빈, 이준협. 한국 재택의료와 방문진료 모델 설계: 미국 Medicare에서의 전략. 보건행정학회지. 2024;34(4):350-60.
- 오영인, 임지연, 강태경. 일본의 재택의료 현황과 시사점. 의료정책연구소; 2019.
- 윤종률, 노용균, 김창오, 김홍수, 여요환, 최아름. 지역사회 거동불편 노인의 적절한 의료·요양 연계를 위한 재택의료센터 가이드라인 개발 연구. 보건복지부, 한림대학교 산학협력단; 2022.
- 이건세, 이정화. 방문진료 및 재택의료체계와 공공보건의료부분의 역할. 대한공공의학회지. 2023;13(1):93-112.
- 이건세. 커뮤니티케어·재택의료 추진 전략. HIRA 정책동향. 2019;13(3).
- 이정석, 권진희, 선정연, 김정희, 정애리. 장기요양 재택의료센터 시범사업 평가연구. 국민건강보험 건강보험연구원; 2023..
- 이정석, 권진희, 이희승, 김정희, 김현기, 송희연. 장기요양 재택의료센터 시범사업 효과분석: 의료이용과 시설 입소예방. 국민건강보험 건강보험연구원; 2024.
- 이태훈, 이자경, 장숙랑, 이혜진, 서동민, 홍종원, 김창오. 미국의 거동불편 칩거노인을 위한 재택의료 서비스. 대한가정의학회지. 2022;12(3):129-36.
- 임선미, 이정찬, 문성제, 박정훈. 일차의료 중심 지역 의료돌봄체계 구축을 위한 실행방안 연구. 의료정책연구원; 2024.
- 장석용, 이상규, 김범석, 강은석, 이승환, 서정환, 김경이, 최은정, 김지은, 홍민지, 최서영, 박유신, 박준영, 최은영. 질환군별 재택의료 시범사업 효과분석 연구. 건강보험심사평가원, 연세대학교 의과대학; 2024.
- 최경환. 일본 농촌지역의 재택의료 실태와 시사점. 한국농촌경제연구원; 2022.
- 행정안전부 보도자료. 65세 이상 인구 비중 20% 기록. 2024.12.24.
- 홍미영, 김경창, 한주희, 안효정. 중증소아 재택의료 시범사업 2차 효과평가 및 개선방안. 건강보험심사평가원; 2024.
- 홍미영, 김진휘, 성미진, 오주연, 조민호. 일차의료 방문진료 수가 시범사업 효과평가 및 개선방안. 건강보험심사평가원; 2022.
- 홍미영, 박미숙, 김아름, 김선미, 윤주영, 황모세, 윤정원. 재택의료 활성화 방안. 건강보험심사평가원; 2020.
- 후생노동성. 2014년도 재택의료에 관한 조사연구 보고서. 후생노동성; 2015.
- 후생노동성. 2024년도 진료보수 개정 개요. 후생노동성; 2024.

- 후생노동성. 2024년도 진료수가 개정 결과 검증에 관한 특별조사 - 재택의료, 재택치과의료, 재택방문약제관리 및 방문간호의 실시 상황 조사. 후생노동성; 2025.
- 후생노동성. 국민건강보험제도의 개요. 후생노동성; 2021.
- 후생노동성. 사회의료진료행위별 통계. 후생노동성; 2025.
- 후생노동성. 의료시설조사. 후생노동성; 2011, 2014, 2017, 2020, 2023.
- 후생노동성. 진료보수 산정방법 일부 개정: 별표 제1 의과 진료보수 점수표 (후생노동성 고시 제57호). 후생노동성; 2024.
- 후생노동성. 정보통신기기를 이용한 진료의 경과. 후생노동성; 2018.
- 후생노동성. 환자조사. 후생노동성; 2011, 2014, 2017, 2020, 2023.

■ 웹사이트

- Agency for Healthcare Research and Quality [Internet]. Agency for Healthcare Research and Quality; c2025. Available from: https://www.ahrq.gov
- AHRQ PSNet [Internet]. Agency for Healthcare Research and Quality; c2025. Available from: https://psnet.ahrq.gov
- American Medical Association [Internet]. American Medical Association; c2025. Available from: https://www.ama-assn.org
- BioMed Central [Internet]. BioMed Central; c2025. Available from: https://www.biomedcentral.com
- BMJ [Internet]. BMJ Publishing Group; c2025. Available from: https://www.bmj.com
- Centers for Medicare & Medicaid Services [Internet]. Centers for Medicare & Medicaid Services; c2025. Available from: https://www.cms.gov
- International Journal of Integrated Care [Internet]. Ubiquity Press; c2025. Available from: https://www.ijic.org
- JAMA Network [Internet]. American Medical Association; c2025. Available from: https://jamanetwork.com
- Medicare Payment Advisory Commission [Internet]. Medicare Payment Advisory Commission; c2025. Available from: https://www.medpac.gov
- Medicare.gov [Internet]. U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services; c2025. Availa

ble from: https://www.medicare.gov

- StatPearls Publishing [Internet]. StatPearls Publishing; c2025. Available from: https://www.statpearls.com
- 건강보험심사평가원 [Internet]. 건강보험심사평가원; c2025. Available from: https://www.hira.or.kr
- 국민건강보험공단 [Internet]. 국민건강보험공단; c2025. Available from: https://www.nhis.or.kr
- 대한가정의학회 [Internet]. 대한가정의학회; c2025. Available from: https://www.kafm.or.kr
- 대한공공의학회 [Internet]. 대한공공의학회; c2025. Available from: https://www.ksphm.or.kr
- 보건복지부 [Internet]. 보건복지부; c2025. Available from: https://www.mohw.go.kr
- 의료정책연구소 [Internet]. 의료정책연구소; c2025. Available from: https://rihp.or.kr
- 한국농촌경제연구원 [Internet]. 한국농촌경제연구원; c2025. Available from: https://www.krei.re.kr
- 한국보건사회연구원 [Internet]. 한국보건사회연구원; c2025. Available from: https://www.kihasa.re.kr
- 후생노동성[Internet]. 후생노동성; c2025. Available from:https://www.mhlw.go.jp
- 행정안전부 [Internet]. 행정안전부; c2025. Available from: https://www.mois.go.kr

■ 법령

- 「국민건강보험법」(법률 제20505호, 2024.10.22. 일부개정) 제44조
- 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」(법률 제20415호, 2024.3.26. 제정, 2026.3.27. 시행)
- 「의료법 시행규칙」(보건복지부령 제1116호, 2025.6.20. 일부개정) 제24조
- 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」(법률 제20509호, 2024.10.22. 일부개정) 제9조 제2항
- 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료 결정에 관한 법률」(법률 제19466호, 2023.6.13. 일부개정) 제25조 제1항

ABSTRACT

The Development of a Comprehensive, Patient-Centered Health Insurance Model for Home-Based Healthcare

Since 2018, fifteen pilot projects for home-based healthcare have been implemented under Korean National Health Insurance. Launched at different times and targeting various populations, these projects have resulted in a fragmented design and potential service gaps. Even when similar services are provided to the same patients, inconsistencies in payment levels, reimbursement criteria, and cost-sharing rates have been observed. Furthermore, the "Home-Based Healthcare for Peritoneal Dialysis Patients" remote monitoring pilot uses similar terminology to the "Pediatric Home-Based Healthcare" program that offers comprehensive management, creating confusion among both patients and providers.

This study aims to develop a comprehensive, patient-centered model for home-based healthcare under the national insurance system that enhances efficiency and consistency while preventing service gaps and overlaps. To achieve this goal, the study reviewed Korea's current home-based healthcare policies and outcomes, compared definitions and operational structures with those in Japan and the United States, analyzed health insurance claims data for the 15 pilot projects as well as home nursing and home hospice services, and conducted in-depth interviews with key stakeholders to identify challenges and directions for reform.

The findings indicate that Korea's home-based healthcare is currently divided into three categories—comprehensive management, home visits, and remote monitoring—but lacks consistency in reimbursement and eligibility criteria. The

system tends to focus on specific patient groups, leaving gaps for homebound patients who need integrated care. In contrast, Japan provides segmented fee-for-service items that can be flexibly combined according to patient needs, while U.S. Medicare uses the OASIS tool to assess patient conditions and applies bundled monthly payments for patients requiring continuous care.

Based on these findings, this study proposes integrating comprehensive management and home visits into a single category while maintaining remote monitoring as a separate domain, thereby simplifying the current three-category structure into two. It also recommends consolidating disease-specific remote monitoring pilots, shifting eligibility criteria from a diagnosis-based to a condition-based approach, and building delivery systems tailored to the medical needs of homebound patients. The proposed comprehensive, patient-centered model is expected to reduce service gaps, standardize reimbursement, alleviate administrative burdens, and ultimately improve both the efficiency and sustainability of home-based healthcare under the Korean national insurance system.

Keywords: Home-Based Healthcare, Home Visits, Remote Patient Monitoring, Pilot Program on National Health Insurance

이 보고서의 내용은 연구진의 의견이며, 건강보험심사평가원의 공식적인 견해와는 다를 수 있습니다.

환자중심의 건강보험 재택의료 포괄모형 개발

발 행 일 : 2025년 12월
발 행 인 : 강 중 구
편 집 인 : 김 유 석
발 행 처 : 건강보험심사평가원 심사평가정책연구소
강원도 원주시 혁신로 60(반곡동)
대표전화 : 1644-2000
홈페이지 : www.hira.or.kr

※ 이 보고서는 무단으로 복제나 인용을 할 수 없습니다.
(저작권법 제136조 등 관련법 적용)